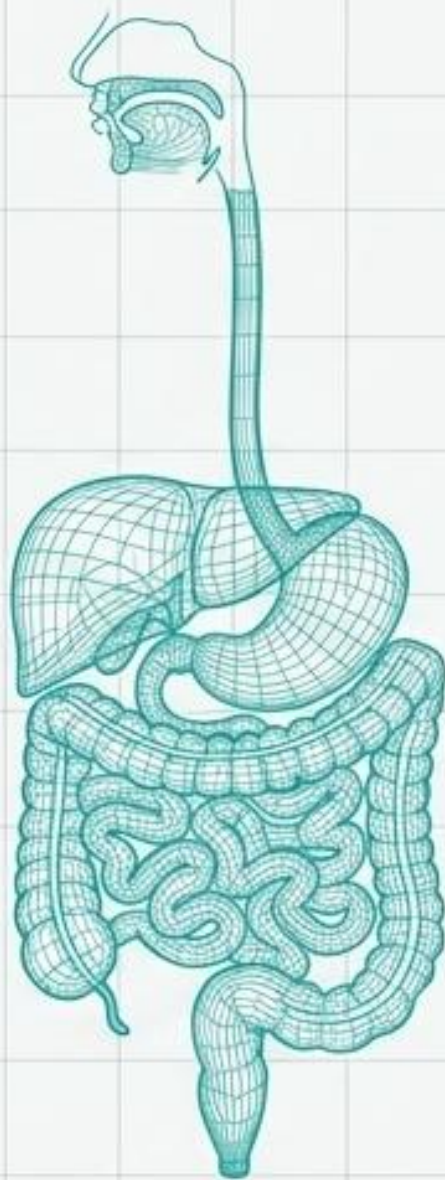
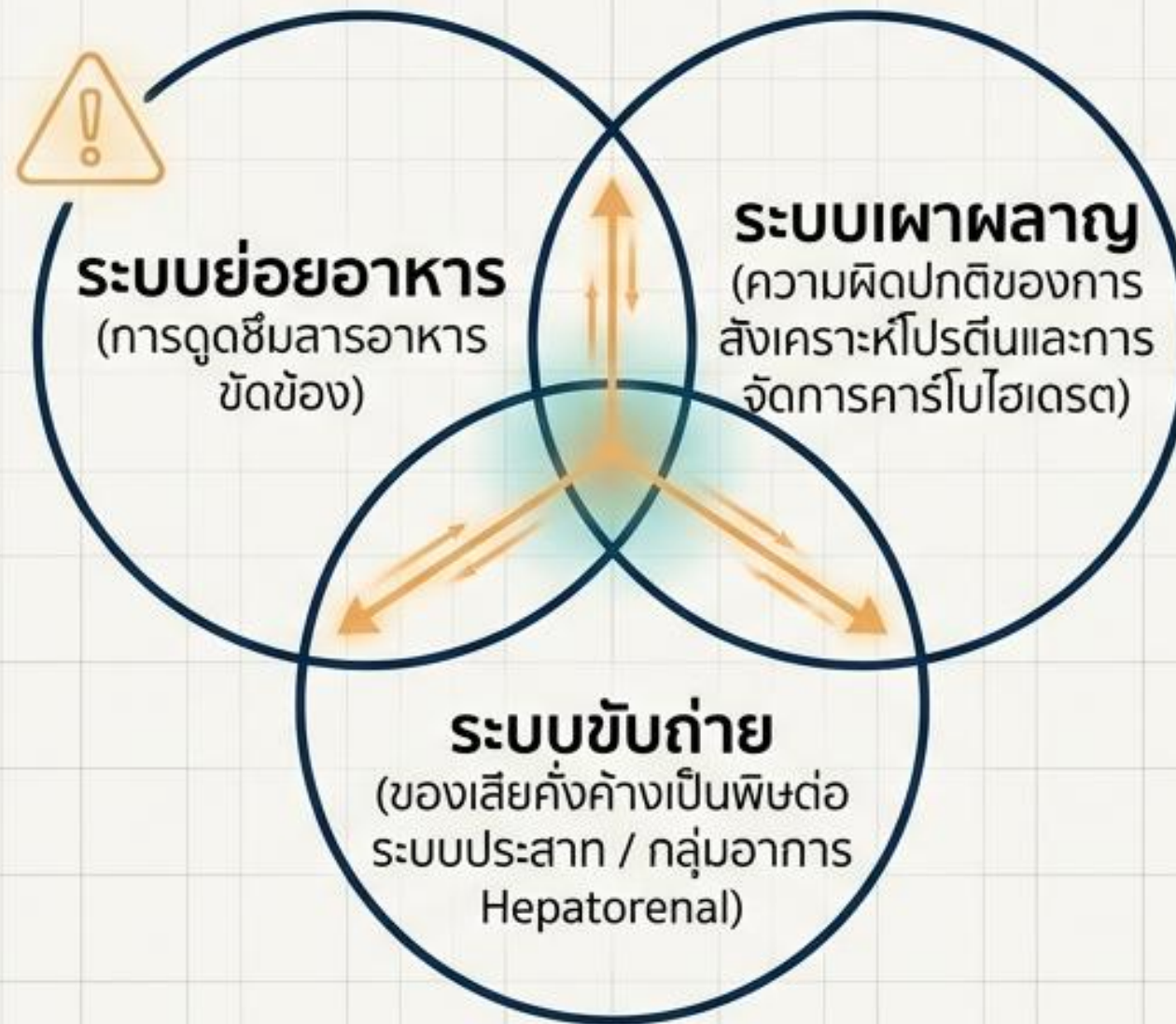




การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ:
ความผิดปกติระบบย่อยอาหาร การเผาผลาญ และขับถ่าย
พยาธิสรีรภาพ การประเมินทางคลินิก และการจัดการทางการพยาบาลแบบองค์รวม

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาริยมาส

รากฐานการดูแลแบบองค์รวม (The Holistic Triad)



กระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Critical Thinking) เป็นสิ่งจำเป็น
พยาบาลต้องมองข้ามการรักษาแบบแยกส่วนอวัยวะ เพื่อรับมือกับภาวะแทรกซ้อนข้ามระบบในผู้ป่วยวิกฤตและผู้สูงอายุ

โรคกรดไหลย้อน (GERD): เมื่อหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างสูญเสียการควบคุม



พยาธิสภาพ: หูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง (LES) บกพร่อง



อาการเตือน: แสบร้อนกลางอก (Heartburn)
รุนแรงเมื่อนอนราบ, ขย้อนน้ำเปรี้ยว,
ไอเรื้อรัง/เสียงแหบตอนเช้า

1



หนุนหัวเตียงสูง 6-8 นิ้ว
(รองขาเตียง ห้ามหนุน
หมอนหลายใบ)

2



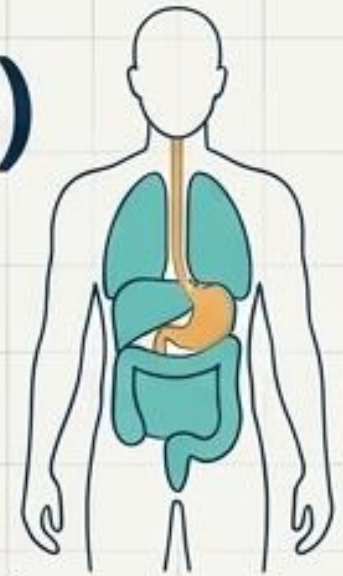
กินมื้อเล็กแต่บ่อยครั้ง
และห้ามนอนราบภายใน
3-4 ชั่วโมงหลังอาหาร

3



ทานยาลดกรด PPIs
(เช่น Omeprazole)
ก่อนอาหารมื้อแรก 30-
60 นาทีอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะเสียสมดุลกรด (GERD & Peptic Ulcer Disease)



ปัจจัยทำลาย
(กรด HCl, เอนไซม์เปปซิน, เชื้อ H. pylori, ยา NSAIDs)



ปัจจัยปกป้อง
(เมือก, ไบคาร์บอเนต, ระบบ ไทลเวียนเลือดหล่อเลี้ยงเยื่อบุผิว)

หูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง (LES) บกพร่อง
เสี่ยงต่อภาวะ Barrett's esophagus และมะเร็ง

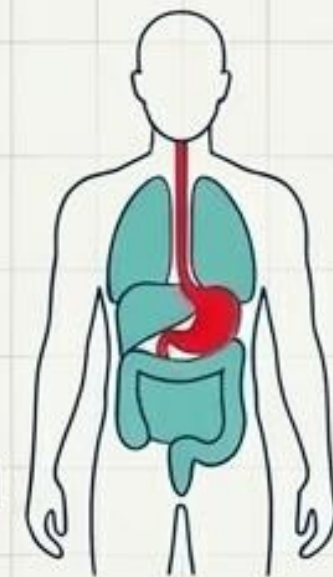
หนุนหัวเตียงสูง 6-8 นิ้ว (ห้ามหนุนหมอนทับกัน)
และห้ามนอนราบ 3-4 ชั่วโมงหลังอาหาร



แผลลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ (Muscularis mucosae)
สัมพันธ์กับมื้ออาหาร (Gastric ปวดหลังกิน 1-2 ชม. / Duodenal ปวดตอนท้องว่าง)

บริหารยาลดกรด PPIs ก่อนอาหารมื้อแรก 30-60 นาทีอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะวิกฤต: เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (UGIB)



Alert Dashboard

เสียเลือด < 15% (< 750 mL) | สัญญาณชีพปกติ ร่างกายชดเชยได้

เสียเลือด 15-30% | ชีพจร > 100 ครั้ง/นาที, Orthostatic hypotension, ปัสสาวะเริ่มลดลง

เสียเลือด 30-40% | SBP < 90 mmHg, ชีพจร > 120 ครั้ง/นาที, หายใจเร็ว, ตัวเย็นเหงื่อออกไหล

เสียเลือด > 40% (> 2,000 mL) | หหมดสติ, ชีพจร > 140 ครั้ง/นาที, ปัสสาวะไม่ออก (Anuria)

Blood Volume



Emergency Resuscitation



เปิดเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ (18-20G) 2 เส้น เพื่อให้สารน้ำ Isotonic crystalloid / เติร์ยมจกเลือด (PRBC)



NPO จดน้ำและอาหาร เพื่อเตรียมส่องกล้อง EGD จุกเงินภายใน 24 ชม.



เฝ้าระวัง: หากปัสสาวะ < 0.5 mL/kg/hr รายงานแพทย์ทันที (Hypovolemic shock รุนแรง)

รอยโรคแผลในกระเพาะอาหาร (PUD): Gastric vs. Duodenal Ulcer



	Gastric Ulcer (แผลในกระเพาะ)	Duodenal Ulcer (แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น)
เวลาที่เกิดอาการปวด	1-2 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร	2-5 ชั่วโมง หลังอาหาร หรือ ปวดตอนท้องว่าง/กลางคืน
ความสัมพันธ์กับอาหาร	ทานอาหารแล้วยังปวดมากขึ้น	อาการปวดดีขึ้นหลังทานอาหารหรือยาลดกรด
พยาธิสภาพหลัก	ปัจจัยปกป้องเยื่อบุผิว (เมือก) ถูกทำลาย	การหลั่งกรดมากเกินไปร่วมกับเชื้อ H. pylori

การประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (UGIB)

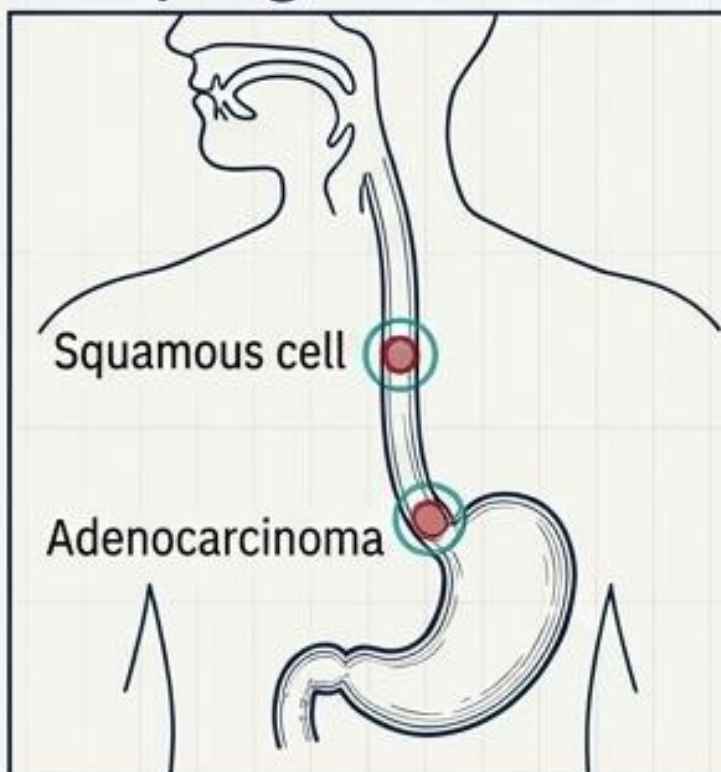


Emergency Fix: เปิดเส้นเลือดขนาดใหญ่ (เบอร์ 18/20) 2 เส้นทันที, NPO, ใส่สาย NG Tube เพื่อประเมินเลือด, เตรียมพร้อมส่องกล้อง (EGD) ภายใน 24 ชม.

มะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน (Esophageal & Gastric Cancer)



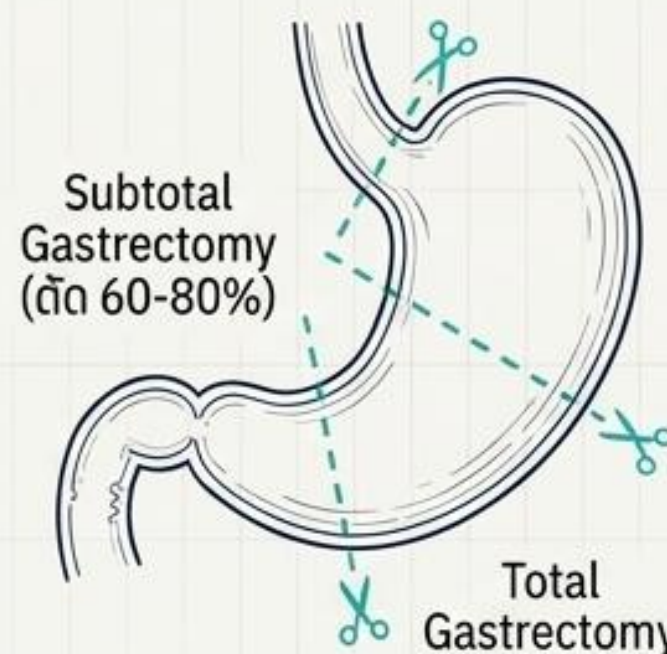
Esophageal Cancer



Squamous cell (ส่วนบน/กลาง - สัมพันธ์กับบุหรี่/สุรา) vs **Adenocarcinoma** (ส่วนปลาย - เกิดจาก GERD เรื้อรัง)

อาการ: กลืนอาหารแข็งลำบาก จนถึงกลืนน้ำไม่ได้, น้ำหนักลด รุนแรง, เสียหาย

Gastric Cancer



เกิดจากการอักเสบเรื้อรัง และเชื้อ *H. pylori* (ชอบเกิด บริเวณ Antrum/Pylorus และ Cardia)

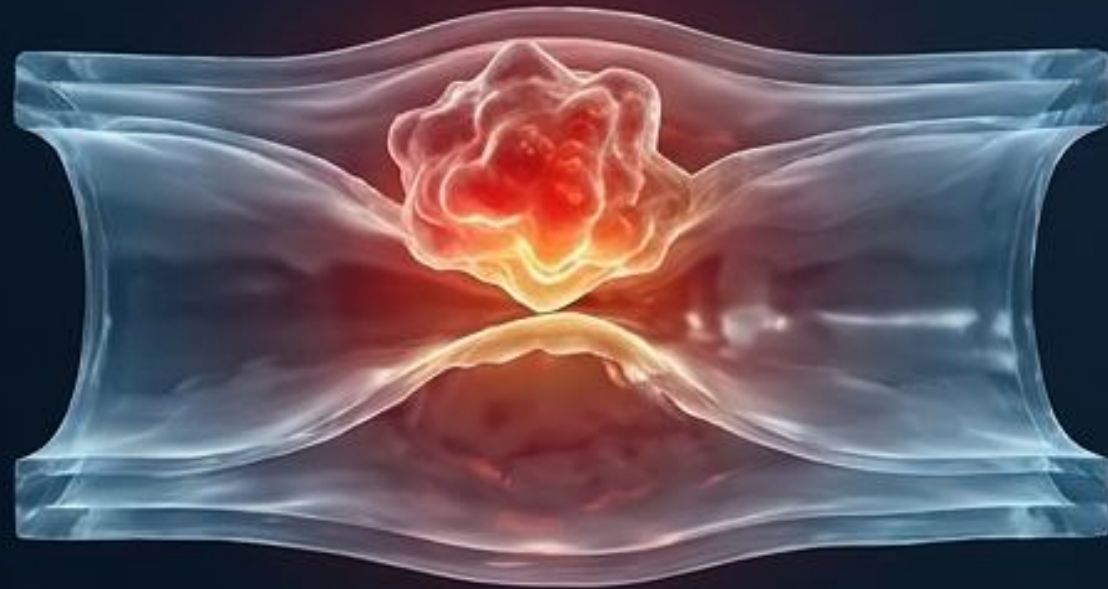
การรักษา: Subtotal Gastrectomy (ตัด 60-80%) หรือ Total Gastrectomy

Post-Op Self-Management

-  • **Dumping Syndrome:** แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก 6 มื้อ/วัน, เลี่ยงแป้ง/น้ำตาลสูง, งดดื่มน้ำพร้อมมื้ออาหาร, นอนราบ 20-30 นาทีหลังทานอาหาร
-  • **Pernicious Anemia:** ผู้ป่วย Total Gastrectomy ต้องฉีดวิตามิน B12 เข้ากล้ามเนื้อตลอดชีวิต

มะเร็งหลอดอาหาร (CA Esophagus): การอุดตันและอันตรายจากการสำลัก

ก้อนมะเร็งอุดตันช่องหลอดอาหาร (Lumen obstruction),
อาการกลืนลำบากที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ (Progressive dysphagia)
เริ่มจากอาหารแข็งสู่ของเหลว, น้ำหนักลดฮวบ,
เสี่ยงต่อรอยทะลุเข้าหลอดลม



The Fix (Aspiration Prevention)

- จัดท่าศีรษะสูง (High-Fowler's position) ขณะทานอาหารและคงท่าเดิมไว้อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
- ให้สารอาหารลักษณะเนื้อละเอียด ช้นหนืดเล็กน้อย (ลดความเสี่ยงสำลักได้ดีกว่าน้ำใส)
- ฝึกไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective coughing) ป้องกันปอดแฟบหลังผ่าตัด

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (CA Stomach)

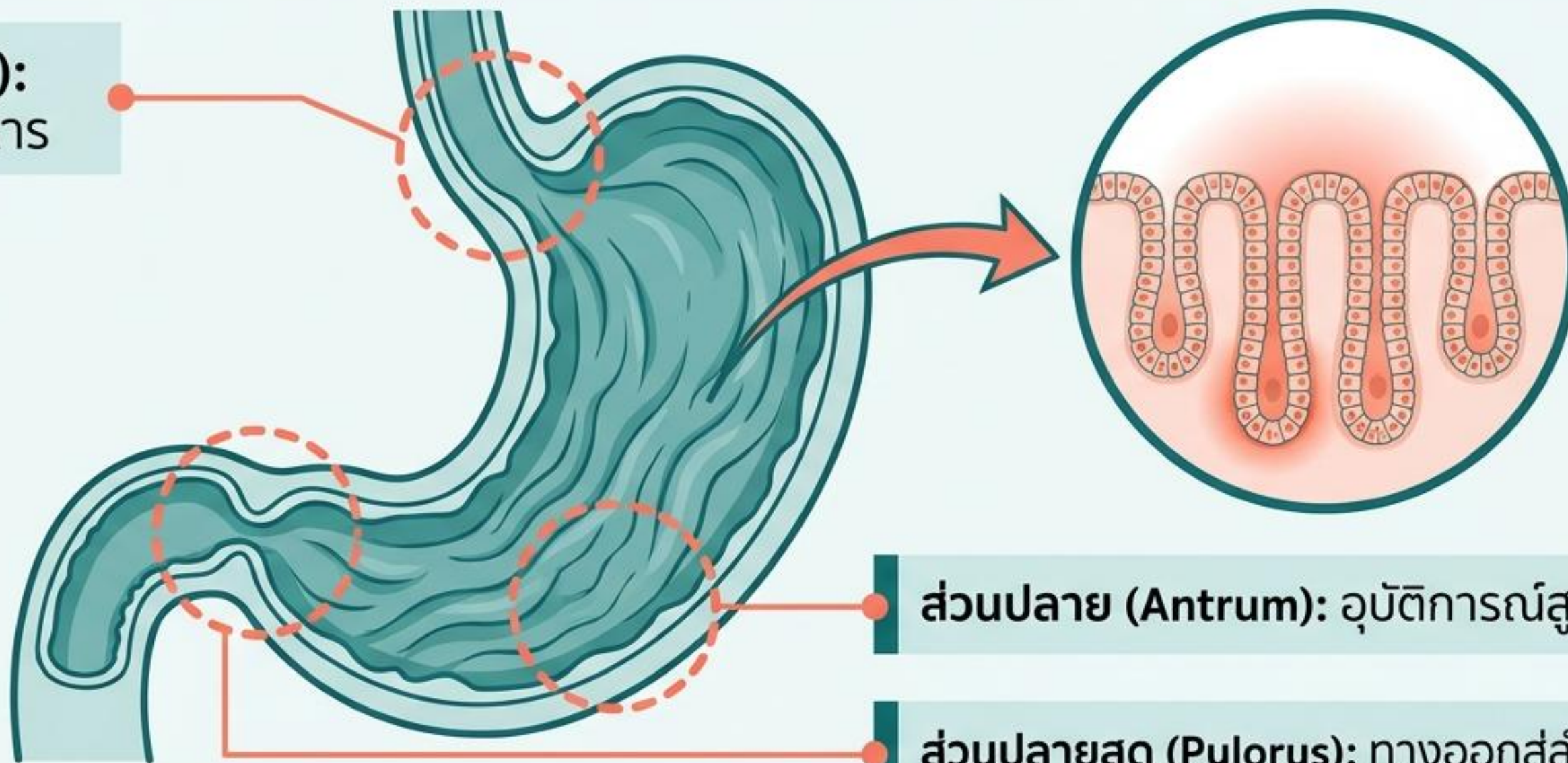
พยาธิสภาพ การวินิจฉัย
และการจัดการทางการพยาบาลขั้นสูง



จุดกำเนิดมะเร็ง: Adenocarcinoma

มากกว่าร้อยละ 90-95 ของมะเร็งกระเพาะอาหารคือ **อะดีโนคาร์ซิโนมา** (Adenocarcinoma) เริ่มต้นจากเซลล์ต่อม (Glandular cells) ที่หลั่งเมือกและน้ำย่อยในชั้นเยื่อบุผิว (Mucosa)

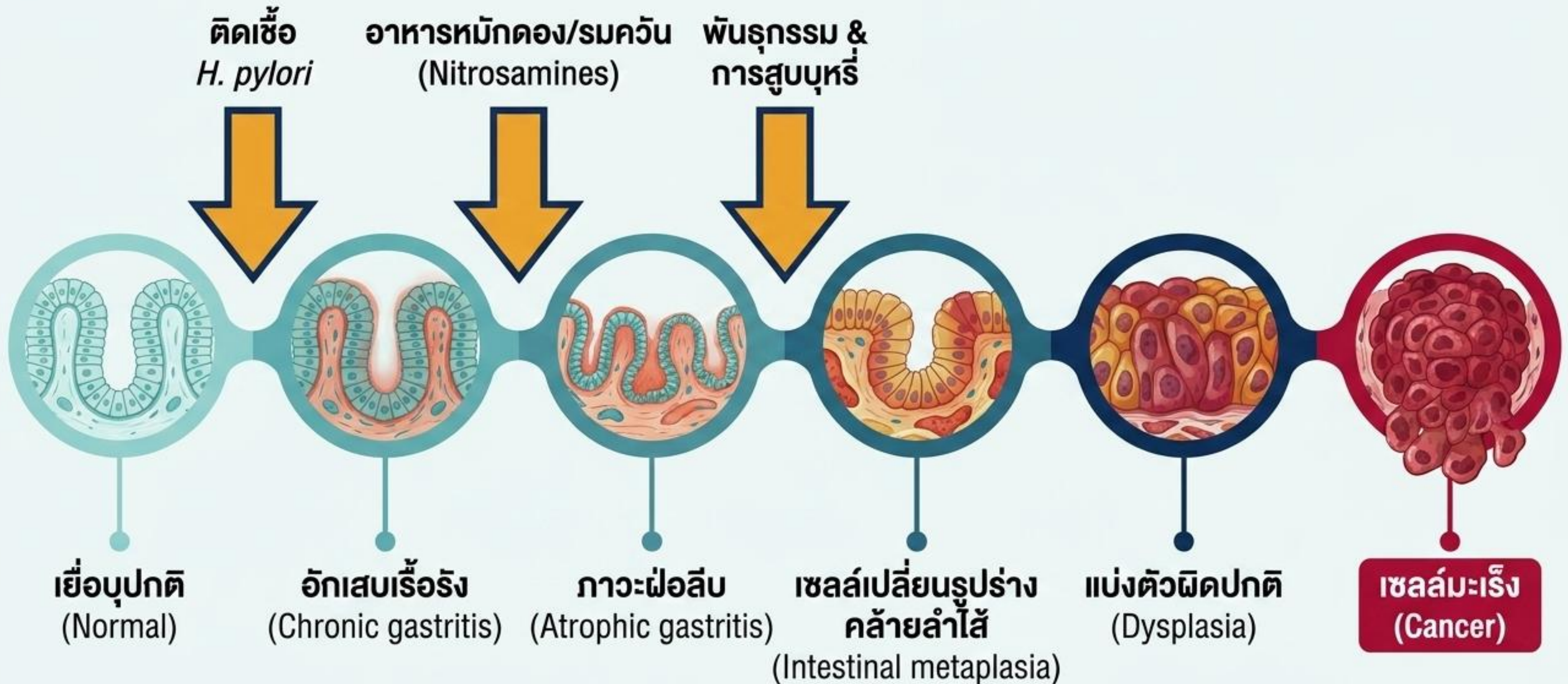
ส่วนต้น (Cardia):
รอยต่อหลอดอาหาร



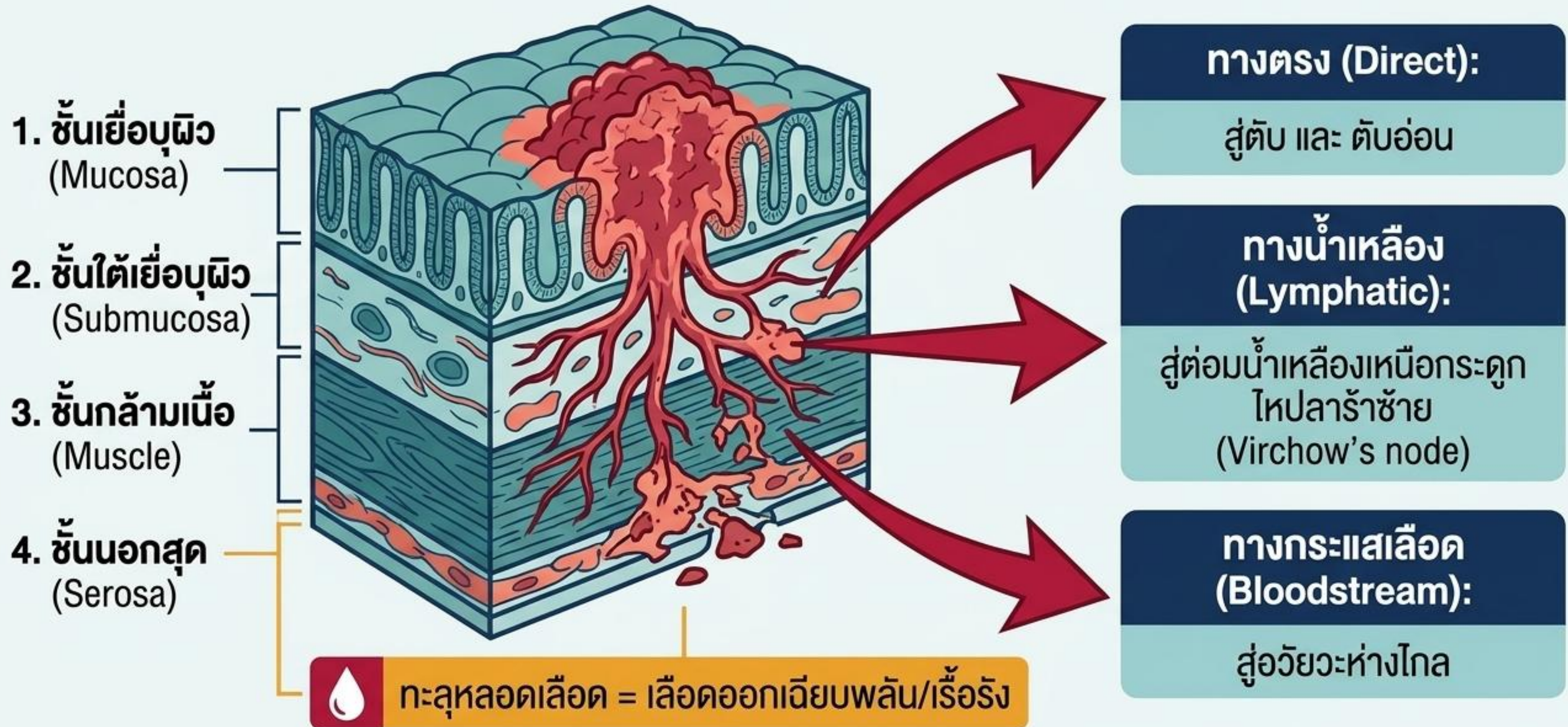
ส่วนปลาย (Antrum): อุบัติการณ์สูง

ส่วนปลายสุด (Pylorus): ทางออกสู่ลำไส้

กระบวนการเกิดโรค (The Pathogenesis Pipeline)



การลุกลามและแพร่กระจาย (Invasion & Metastasis)



อาการและอาการแสดง (Clinical Presentation)

ระยะแรก (มักถูกมองข้าม)

- อาการคล้ายโรคกระเพาะ/แผลทั่วไป
- แน่นท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
- แสบร้อนใต้ลิ้นปี่หลังอาหาร



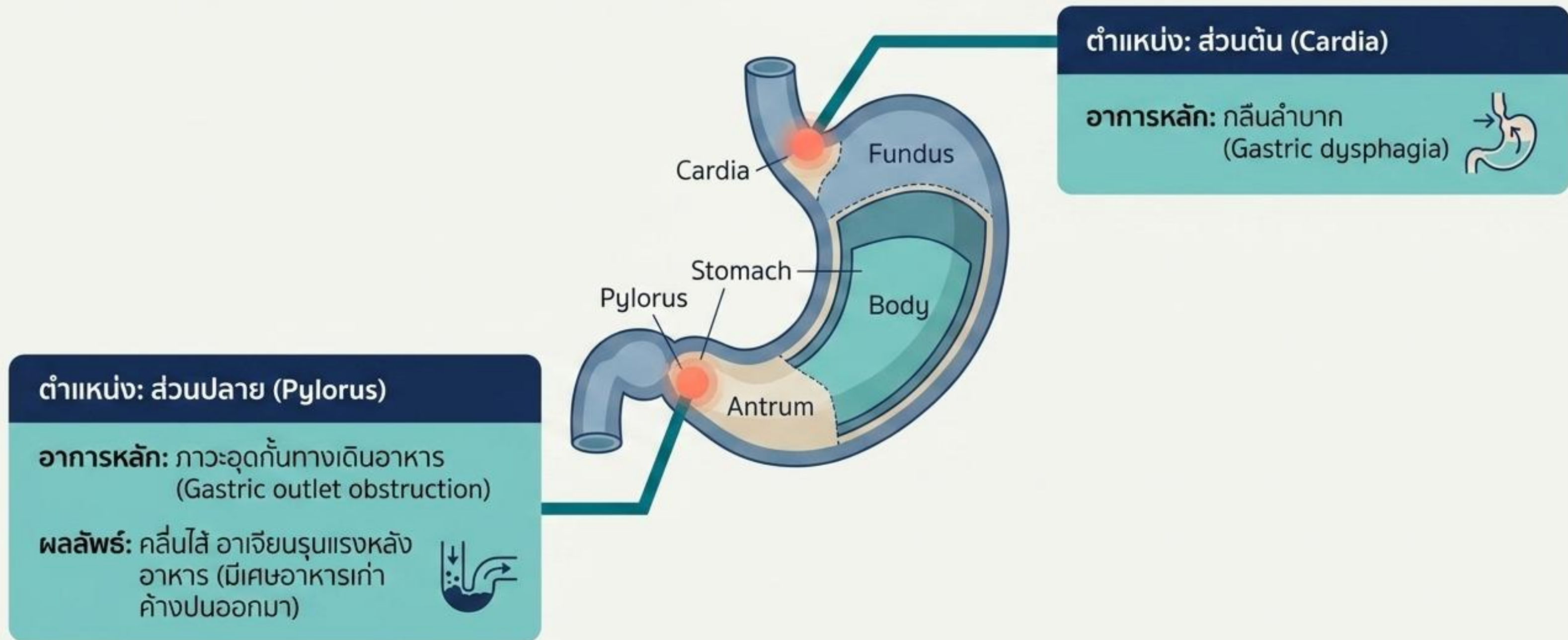
ระยะลุกลาม (รุนแรง)

- น้ำหนักลดรวดเร็ว ไม่มีสาเหตุ, เบื่ออาหาร (Anorexia), อิ่มเร็ว
- ปวดท้องรุนแรงเรื้อรัง (ไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหาร)
- อ่อนเพลีย ชีด เหนื่อยง่าย (เสียเลือดเรื้อรัง)



อาการทางคลินิก: คลำพบบก้อนแข็งรูขุมระ (Palpable mass), ถ่ายดำและคล้ายยางมะตอย (Melena)

ตำแหน่งรอยโรคและอาการเฉพาะที่ (Anatomical Symptom Mapping)



ชุดเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย (The Diagnostic Toolkit)



ส่องกล้อง (EGD) & Biopsy

- Gold Standard ดูลักษณะรอยโรค ขอบแผล และตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา



การกลืนแป้ง (Upper GI series / Barium Swallow)

- ประเมินขนาด การบีบตัว กรณีส่องกล้องไม่ได้ (พบผนังแข็งรอยตีบแคบ)



CT Scan & EUS (Endoscopic Ultrasound)

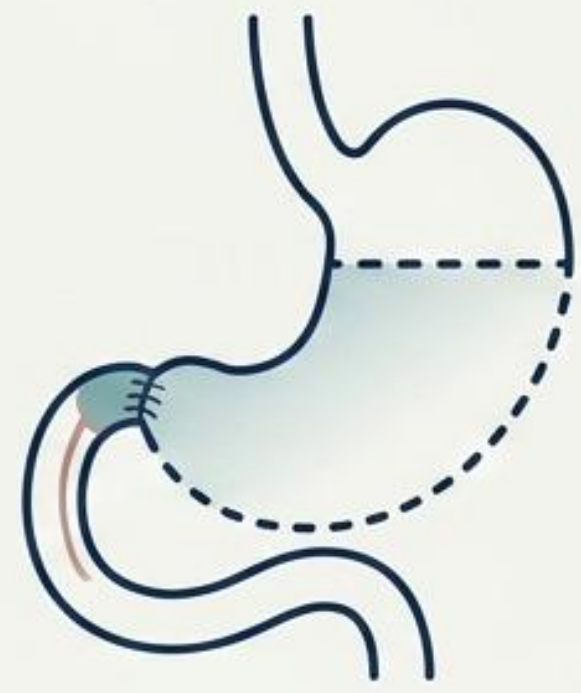
- ประเมินระยะโรค (Staging) ความลึก การลุกลามต่อมน้ำเหลืองและตับ



ทางห้องปฏิบัติการ (Labs)

- CBC (ประเมินภาวะซีดขาดธาตุเหล็ก)
- Serum albumin (ประเมินภาวะทุพโภชนาการ)
- Tumor markers: CEA, CA 19-9 (ติดตามผลและพยากรณ์โรค)

การรักษาทางศัลยกรรม (Curative Surgical Interventions)



ตัดบางส่วน (Subtotal Gastrectomy)	
ข้อบ่งชี้:	ก้อนมะเร็งส่วนปลาย
ขอบเขต:	ตัดออก 60-80%
การเย็บต่อ:	ต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้น/กลาง (Billroth I หรือ Billroth II)



ตัดทั้งหมด (Total Gastrectomy)	
ข้อบ่งชี้:	ก้อนมะเร็งส่วนต้น หรือส่วนกลาง
ขอบเขต:	ตัดออก 100% พร้อมเนื้อเยื่อข้างเคียง
การเย็บต่อ:	นำหลอดอาหารต่อกับลำไส้เล็กส่วนเจริญ (Esophagojejunostomy)

การรักษาเสริมและการประคับประคอง (Systemic & Palliative Care)



การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด (Preoperative Nursing Management)



การจัดการภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition Management)

- ประเมินน้ำหนักและระดับอัลบูมินอย่างต่อเนื่อง
- ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (TPN)
- ให้อาหารเหลวพลังงานและโปรตีนสูงตามแผนการรักษา



การบรรเทาอาการอุดตัน (Obstruction Decompression)

- ดูแลใส่สาย NG tube เพื่อระบายเศษอาหารและแก๊ส (Gastric outlet obstruction)
- ล้างกระเพาะด้วย NSS เพื่อลดอาการบวมอักเสบของผนังกระเพาะก่อนผ่าตัด

การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด: ข้อควรระวัง NG Tube (Post-Op Critical Care)



ห้ามเลื่อน ปรับตำแหน่ง หรือสวนล้างสาย NG tube เด็ดขาด!
(เสี่ยงที่มทะลุรอยเย็บต่อ - Anastomosis)

(สังเกตและบันทึกสารคัดหลั่ง)



เฝ้าระวังรอยต่อรั่ว (Anastomotic leak)



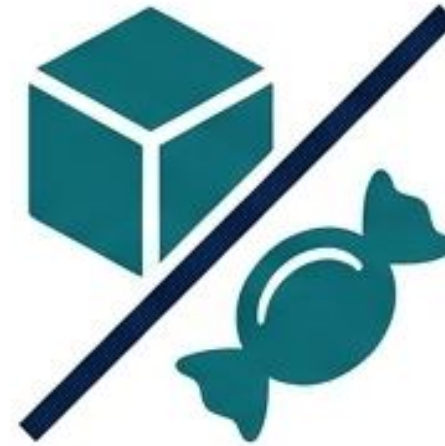
อาการ: ไข้สูง, ปวดท้องรุนแรง,
หน้าท้องแข็งเกร็ง

การจัดการ Dumping Syndrome

ภาวะแทรกซ้อนจากการที่อาหารเคลื่อนลงลำไส้เล็กเร็วเกินไป พยาบาลต้องส่งเสริมการจัดการตนเอง



1. มื้อเล็กแต่บ่อย: แบ่งรับประทานอาหารมื้อละน้อย (6 มื้อ/วัน)



2. เลี่ยงคาร์บ/น้ำตาล: หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูง



3. แยกน้ำกับอาหาร: จดดื่มน้ำพร้อมมื้ออาหาร (ให้ดื่มก่อน/หลัง 30-60 นาที)



4. นอนราบหลังกิน: นอนราบหลังรับประทานอาหารทันที 20-30 นาที (ชะลอการเคลื่อนตัวของอาหาร)

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว: ชนิดชนิด Pernicious Anemia



การให้ความรู้ (Education) - NURSING INTERVENTION

ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับวิตามินบี 12 ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
(Vitamin B12 injection) เป็นประจำตลอดชีวิต

การดูแลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ (Holistic & Spiritual Care)



จิตใจ (Psychosocial)

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกต่อแท้งจากโรคร้ายแรง



จิตวิญญาณ (Spiritual)

ประเมินความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับความหมายของชีวิต
(Spiritual distress)



ชุมชน (Community)

ประสานงานส่งต่อทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน ร่วมกับ
ครอบครัวระดับประจักษ์คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

CA Stomach Clinical Summary Dashboard

พยาธิสภาพ (Pathophysiology)	การวินิจฉัย (Diagnosis)	การรักษา (Treatment)	การพยาบาล (Nursing Care)
- Adenocarcinoma (เยื่อบุผิว) - รอยโรค: Cardia, Antrum, Pylorus - H. pylori & อาหารหมักดองเร่งการเกิดโรค	- EGD + Biopsy (ยืนยัน) - CT / EUS (ประเมินระยะ) - อาการอุดกั้น (อาเจียน) / อาการกลืนลำบาก	- ผ่าตัด: Subtotal vs Total Gastrectomy - เสริม: เคมีบำบัด / รังสี - ประคับประคอง: Bypass / ใส่สายให้อาหาร	- ก่อน: TPN, NG Tube Decompression - หลัง: ห้ามปรับลำ NG, ระวังรื้อ - Dumping Syndrome & จัด B12 ตลอดชีวิต

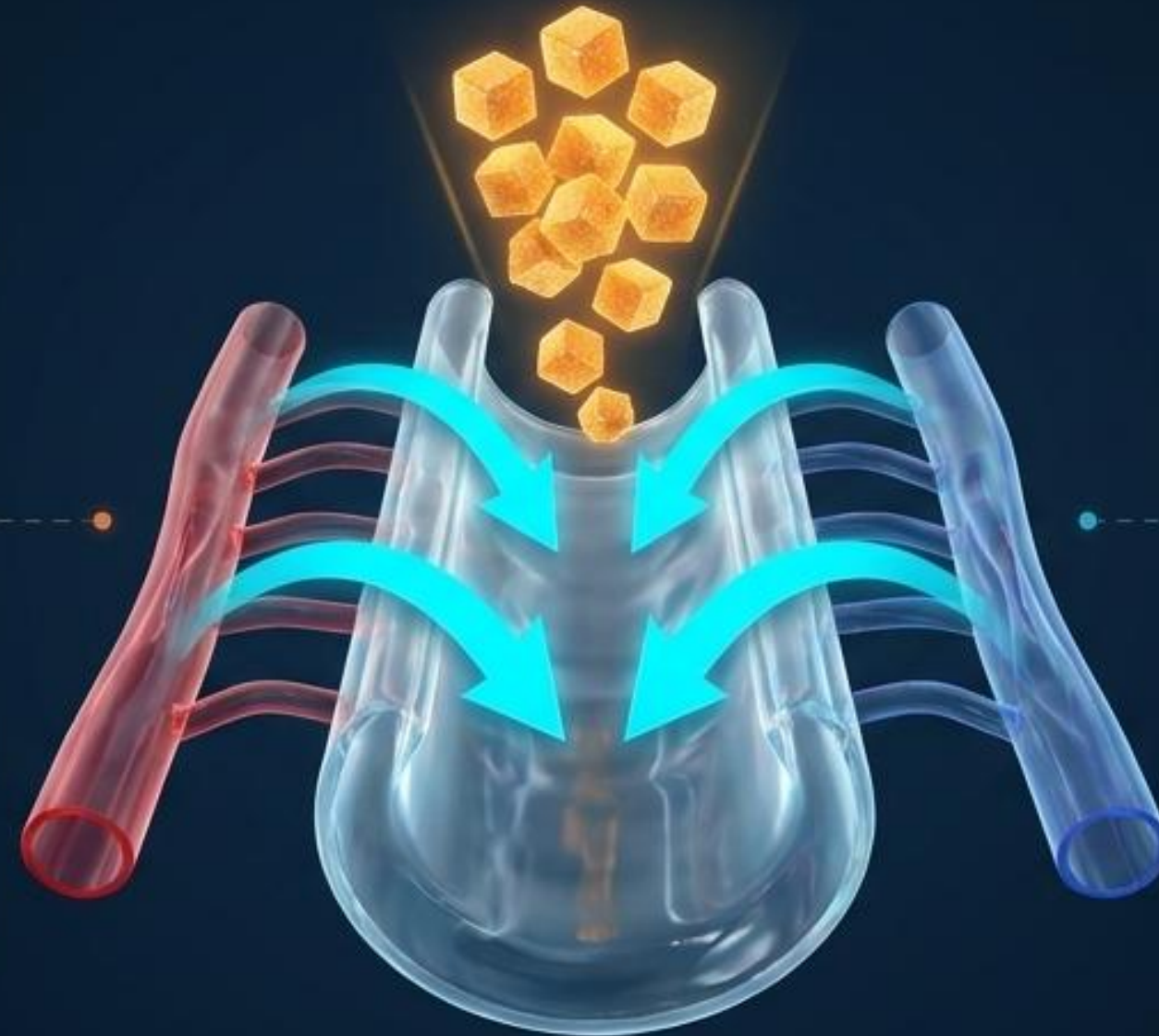
มะเร็งกระเพาะอาหารและกลไกการเกิด Dumping Syndrome หลังผ่าตัด



The Break

(Dumping Syndrome)

อาหารมีความเข้มข้นสูง
(Hyperosmolar)
ตกสู่ลำไส้เล็กอย่างรวดเร็ว
ดึงน้ำจากหลอดเลือดเข้าสู่ลำไส้
เกิดภาวะความดันโลหิตตกและ
ใจสั่นทันทีหลังทานอาหาร



The Fix

(Dumping Prevention Rules)

- แบ่งมื้ออาหารเล็กๆ 6 มื้อ/วัน
เลี่ยงคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลสูง
- ห้ามดื่มน้ำพร้อมมื้ออาหาร
(ให้ดื่มก่อน/หลัง 30-60 นาที)
- ให้นอนราบ 20-30 นาทีหลังอาหาร
เพื่อชะลอการเคลื่อนตัวของอาหาร

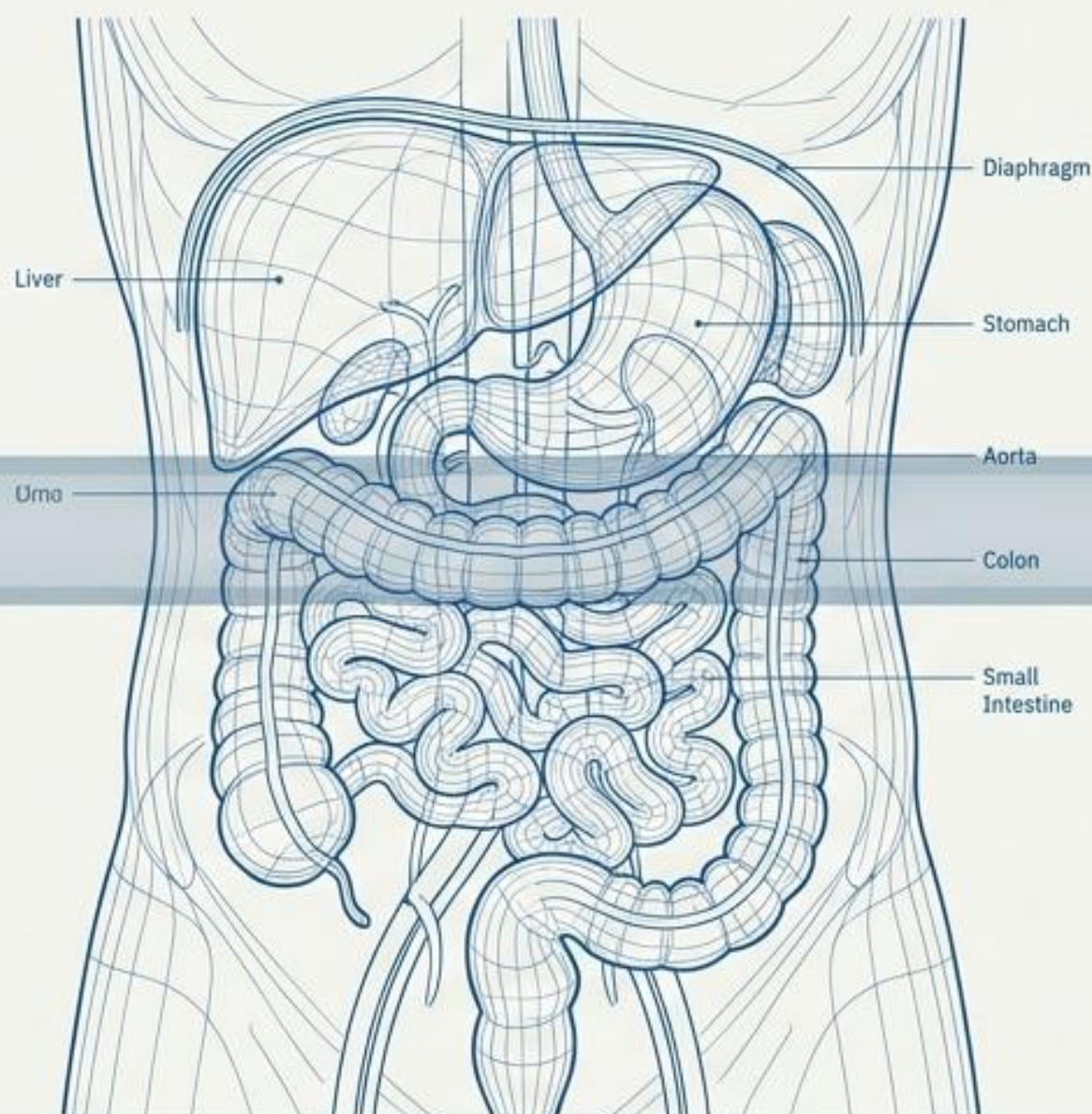


Long-term Alert: ภาวะซีดจากการขาดวิตามินบี 12 (Pernicious anemia) ต้องฉีด B12 ตลอดชีวิตเนื่องจากขาด Intrinsic factor

ภาวะวิกฤตทางศัลยศาสตร์ช่องท้อง (Acute Abdomen)

STATUS: TIME-CRITICAL

จากการอุดตันเฉพาะที่
สู่ภาวะวิกฤตทั่วระบบ
(From Localized Obstruction
to Systemic Crisis)

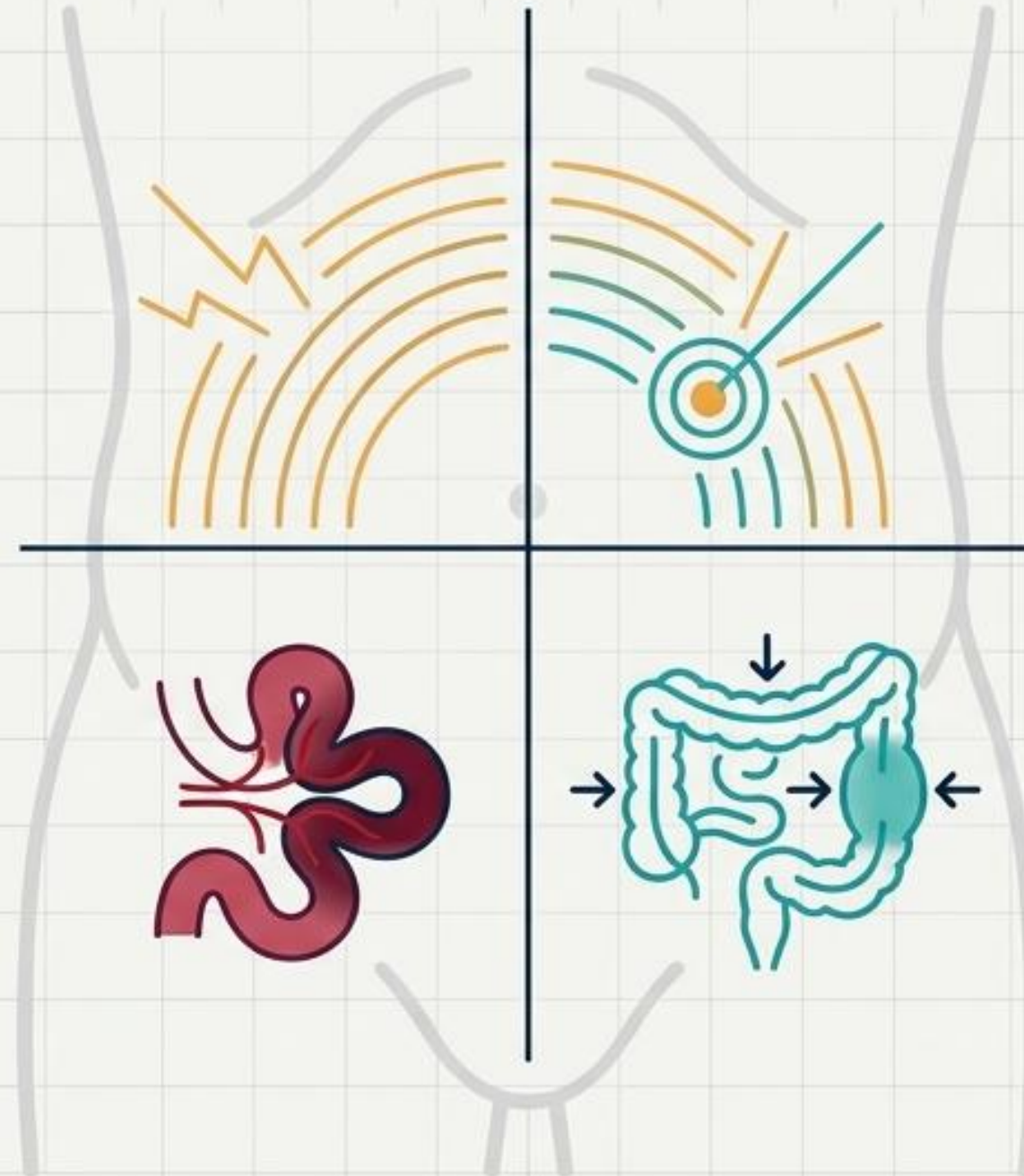


ภาวะวิกฤตทางศัลยศาสตร์ช่องท้อง (The Acute Abdomen)



Q2
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
ปวดรุนแรงทั่วท้อง
หน้าท้องแข็งเกร็งคล้ายแผ่นกระดาน
(Board-like rigidity)
ฟังเสียงลำไส้ไม่ได้

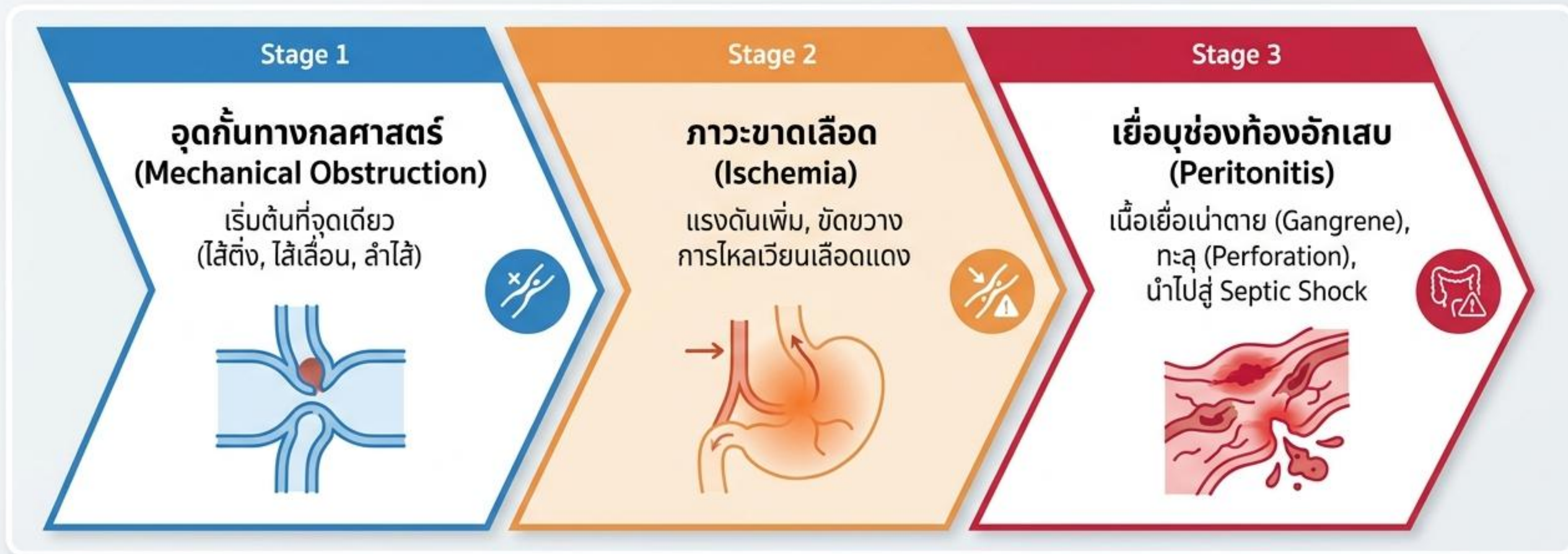
Q4
ไส้เลื่อนชนิดขาดเลือด
ก้อนไส้เลื่อนดันกลับไม่ได้
แข็งตึง กดเจ็บมาก
ผิวหนังคล้ำ/เขียวช้ำ
(ภาวะฉุกเฉินลำไส้เน่าตาย)



Q1
ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
ปวดรอบสะดือย้ายมาท้องน้อยขวา
(McBurney's point),
Rebound tenderness,
Rovsing's sign

Q3
ลำไส้อุดตัน
ปวดท้องรุนแรงเป็นพักๆ (Colicky pain),
ท้องอืดโตชัดเจน, คลื่นไส้อาเจียน
(สิ่งอาเจียนกลืนคล้ายอุจจาระ),
ไม่พายลม/ไม่ถ่าย (Obstipation)

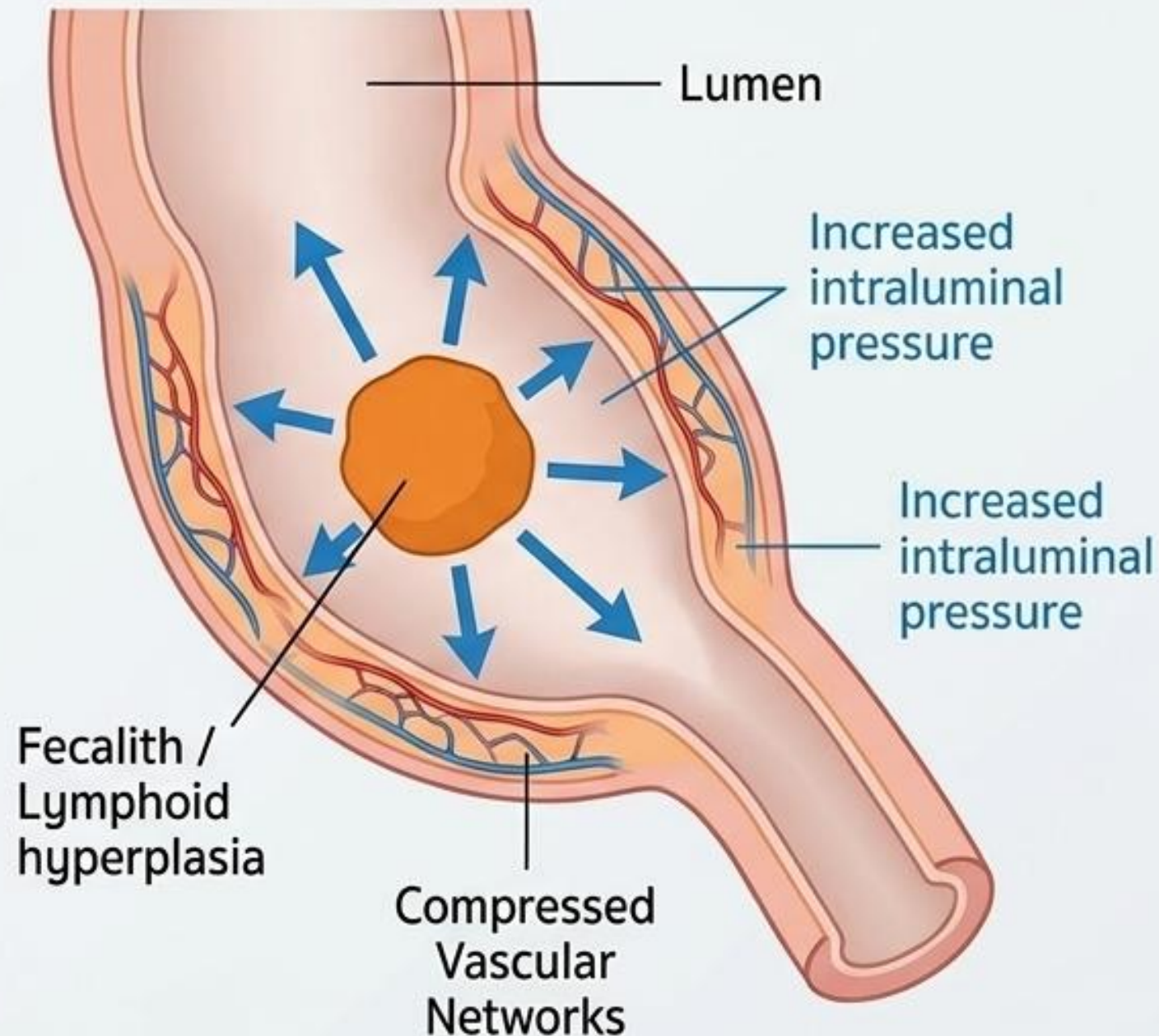
พยาธิสภาพแห่งเวลา: ปฐมบทสู่ภาวะช็อก



สาเหตุเริ่มต้นอาจต่างกัน แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา
ทุกสภาวะจะบรรจบที่จุดเดียวกันคือการแตกทะลุและติดเชื้อในกระแสเลือด

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Appendicitis): วงจรความดันสะสม

The Pressure Cooker Model



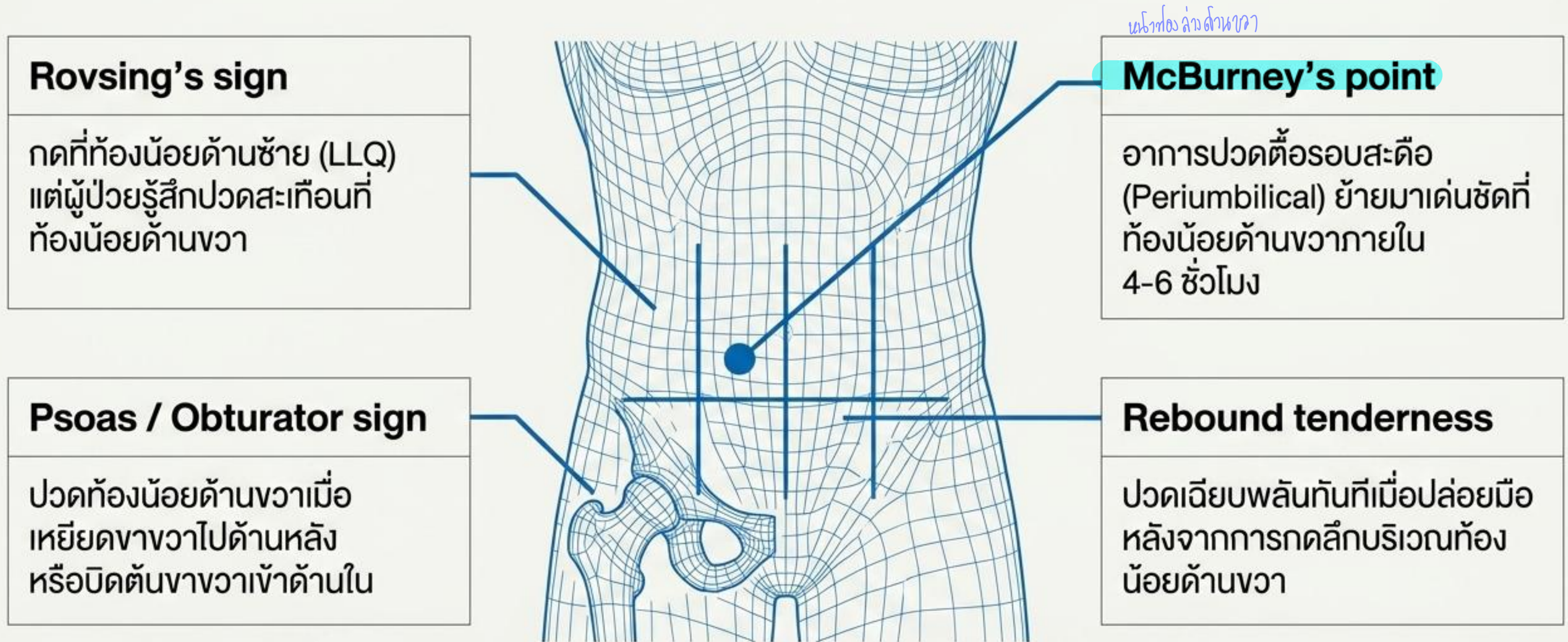
- **STEP 1:** สิ่งอุดตัน (Fecalith) ทำให้สารคัดหลั่งระบายไม่ได้
- **STEP 2:** ความดันในรูไส้ติ่งสูงขึ้น (Increased intraluminal pressure) กดทับหลอดเลือดดำและน้ำเหลือง
- **STEP 3:** เลือดแดงไหลเวียนไม่ได้ เกิดภาวะขาดเลือด (Ischemia) แบคทีเรียรุกราน



CRITICAL WINDOW:

ผนังไส้ติ่งจะเน่าตาย (Gangrenous) และทะลุ (Perforated) ภายใน 24-48 ชั่วโมง

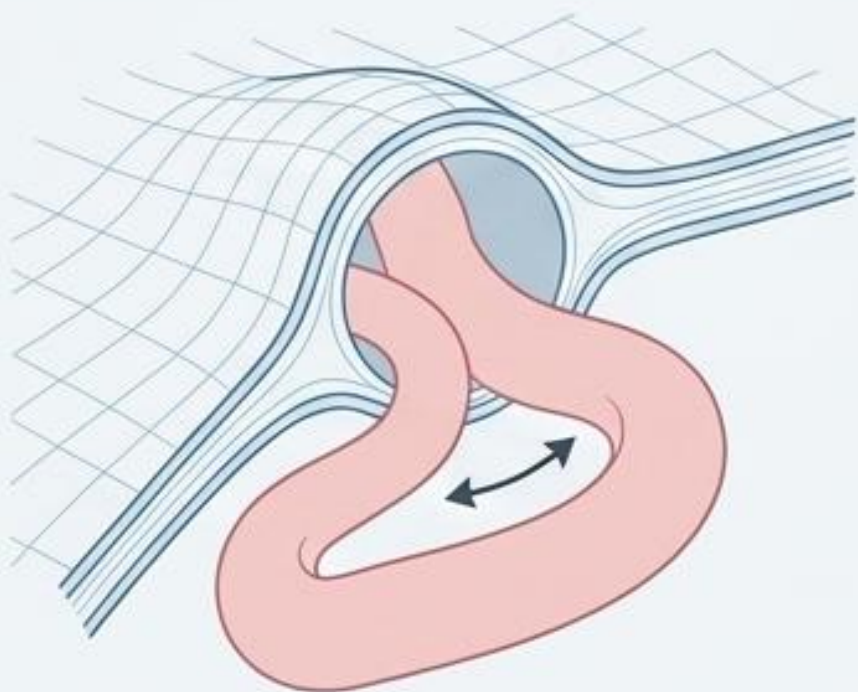
แผนที่การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical Diagnostic Mapping)



โรคไส้เลื่อน (Hernia): จากแรงดันสู่การเน่าตาย

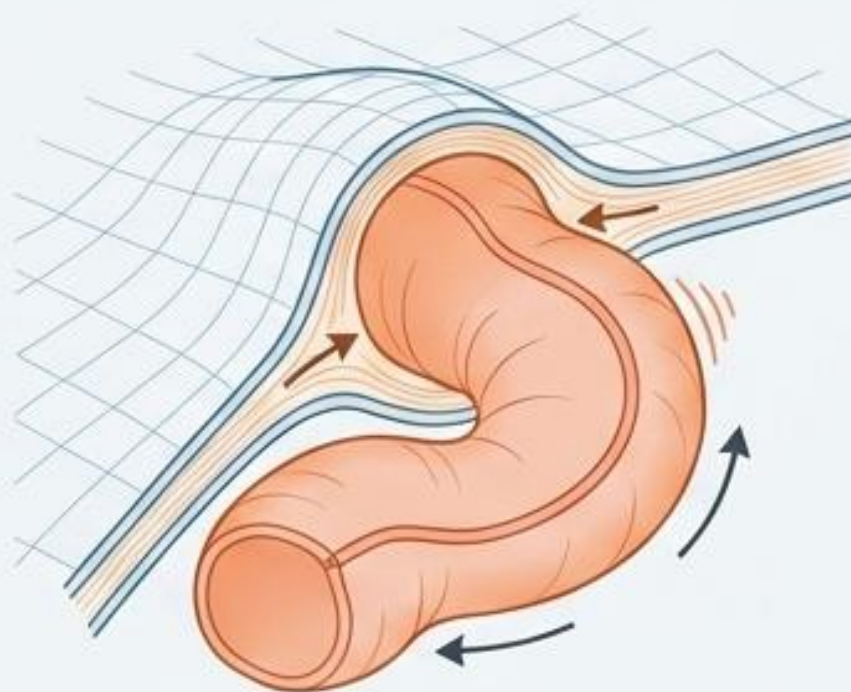
STAGE 1: Reducible

ก้อนโป่งนูนเมื่อยืน/ไอ
แต่สามารถดันกลับเข้าช่องท้องได้
(ไม่มีอันตรายเฉียบพลัน)



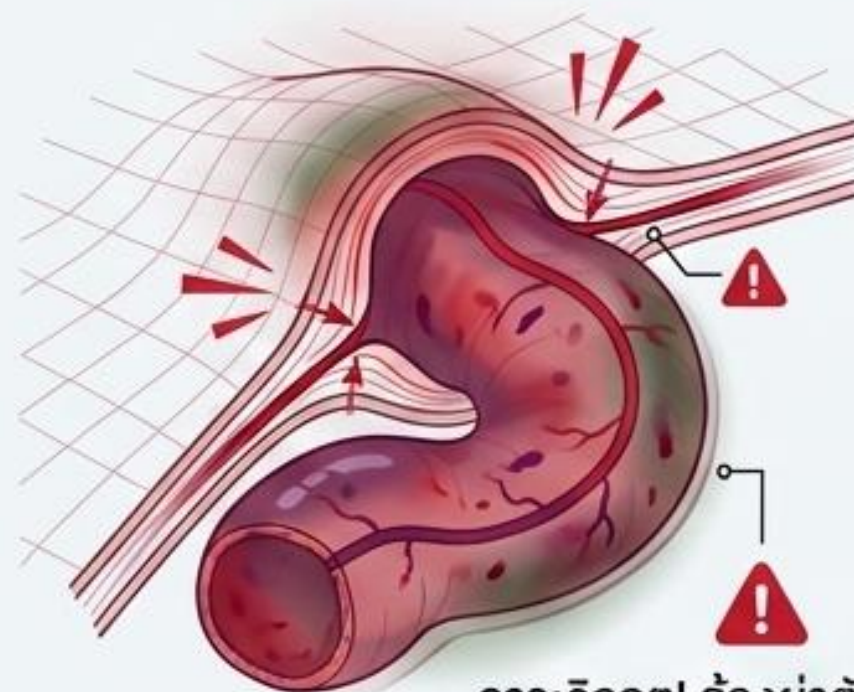
STAGE 2: Incarcerated

ลำไส้ติดค้าง ดันกลับไม่ได้
นำไปสู่ภาวะลำไส้อุดตัน



STAGE 3: Strangulated

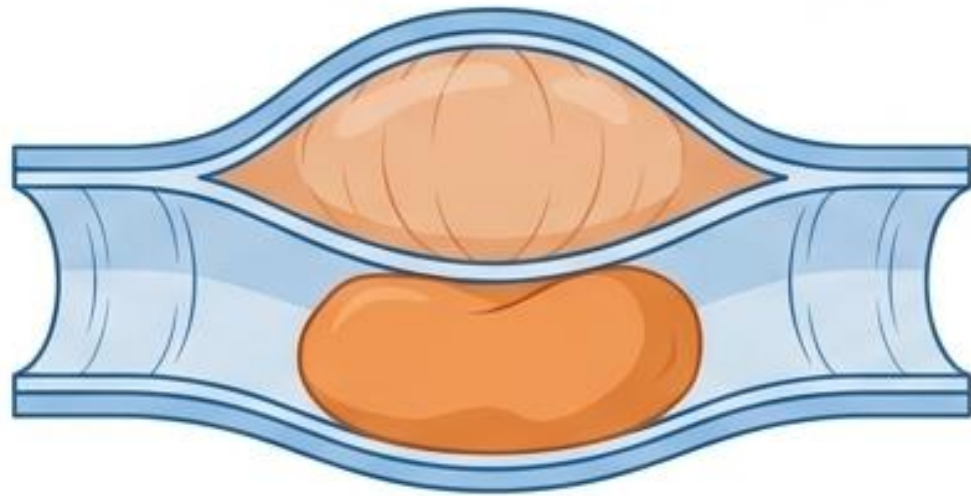
คอถุงไส้เลื่อนรัดแน่นจนเลือดไปเลี้ยงไม่ได้
ก้อนแข็งตึง กดเจ็บ ผิวหนังสีแดงคล้ำ/เขียวช้ำ
(เนื้อเยื่อเน่าตายและทะลุในไม่กี่ชั่วโมง)



ภาวะวิกฤต! ต้องผ่าตัดด่วน
(Critical! Urgent Surgery)

ภาวะลำไส้อุดตัน (GI Obstruction): กลไกขัดข้อง vs ระบบหยุดทำงาน

Mechanical Obstruction (อุดตันทางกลศาสตร์)



- กากอาหาร สารน้ำ แก๊ส เคลื่อนผ่านไม่ได้
- อาการนำ: ปวดท้องบีบๆ เป็นพักๆ (Colicky pain), ท้องอืดโต, ไม่ถ่าย/ไม่ผายลม (Obstipation)
- จุดสังเกต: อุดตันส่วนบนอาเจียนเร็ว, อุดตันส่วนล่างอาเจียนช้าและมีกลิ่นคล้ายอุจจาระ

Paralytic Ileus (ลำไส้ไม่บีบตัว)



- การอุดตันจากความบกพร่องทางสรีรวิทยา
- มักเกิดตามหลังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ (เช่น Peritonitis)

Diagnostic Matrix: การแยกแยะโรคจากอาการแสดง

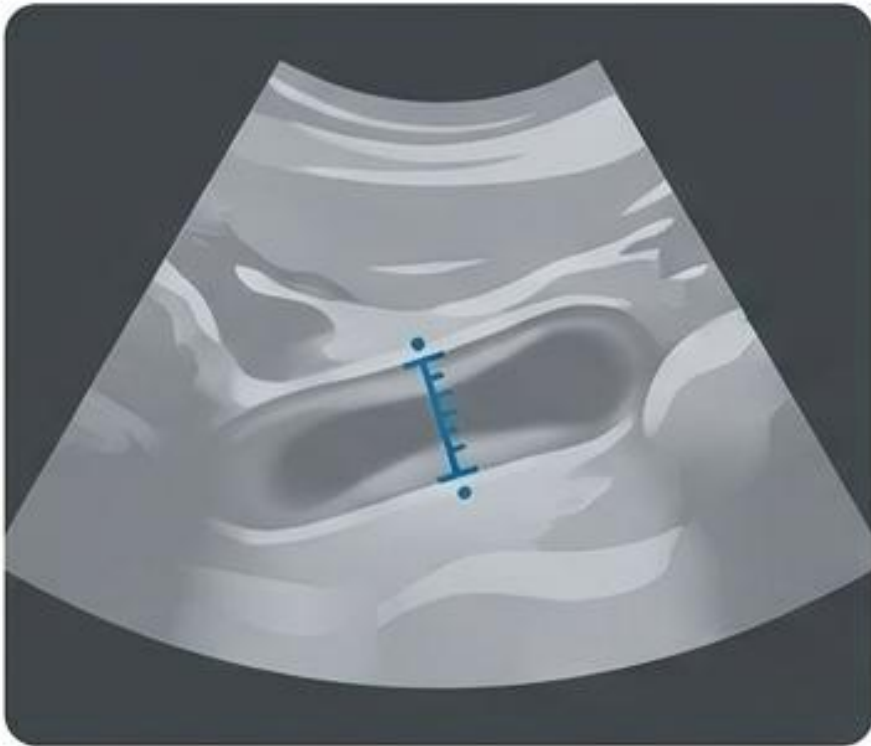
	ไส้จริงอักเสบ Appendicitis	ไส้เลื่อน Strangulated Hernia	ลำไส้อุดตัน GI Obstruction
รูปแบบการปวด (Pain)	ย้ายตำแหน่งมาขวาล่าง	ปวดรุนแรงเฉียบพลันที่ก้อน	ปวดบีบเป็นพักๆ (Colicky)
การสัมผัส (Touch)	กดเจ็บ Rebound tenderness	ก้อนแข็งตึง ผิวหนังคล้ำ	ท้องอืดโตชัดเจน
เสียงลำไส้ (Bowel Sounds)	ลดลง	แตกต่างกันตามระยะ	ระยะแรกเสียงแหลมถี่ (High-pitched/Tinkling) ระยะหลังเสียงเงียบ (Absent)

LAB ALERT:

CBC Leukocytosis > 10,000-15,000 / mm3
(Shift to the left) ป่งชี้การติดเชื้อ

ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา (Imaging Decoder Panel)

Ultrasound / CT
(Appendicitis)



ไส้ติ่งโต (Diameter > 6 mm),
ผนังหนาตัว,
หรือมีหนองรอบไส้ติ่ง

Upright X-Ray
(GI Obstruction)



ระดับน้ำสลับแก๊สลักษณะคล้ายบันได
(Air-fluid levels / Step-ladder
pattern), ลมในลำไส้ใหญ่ลดลง

Erect X-Ray
(Peritonitis / Perforation)



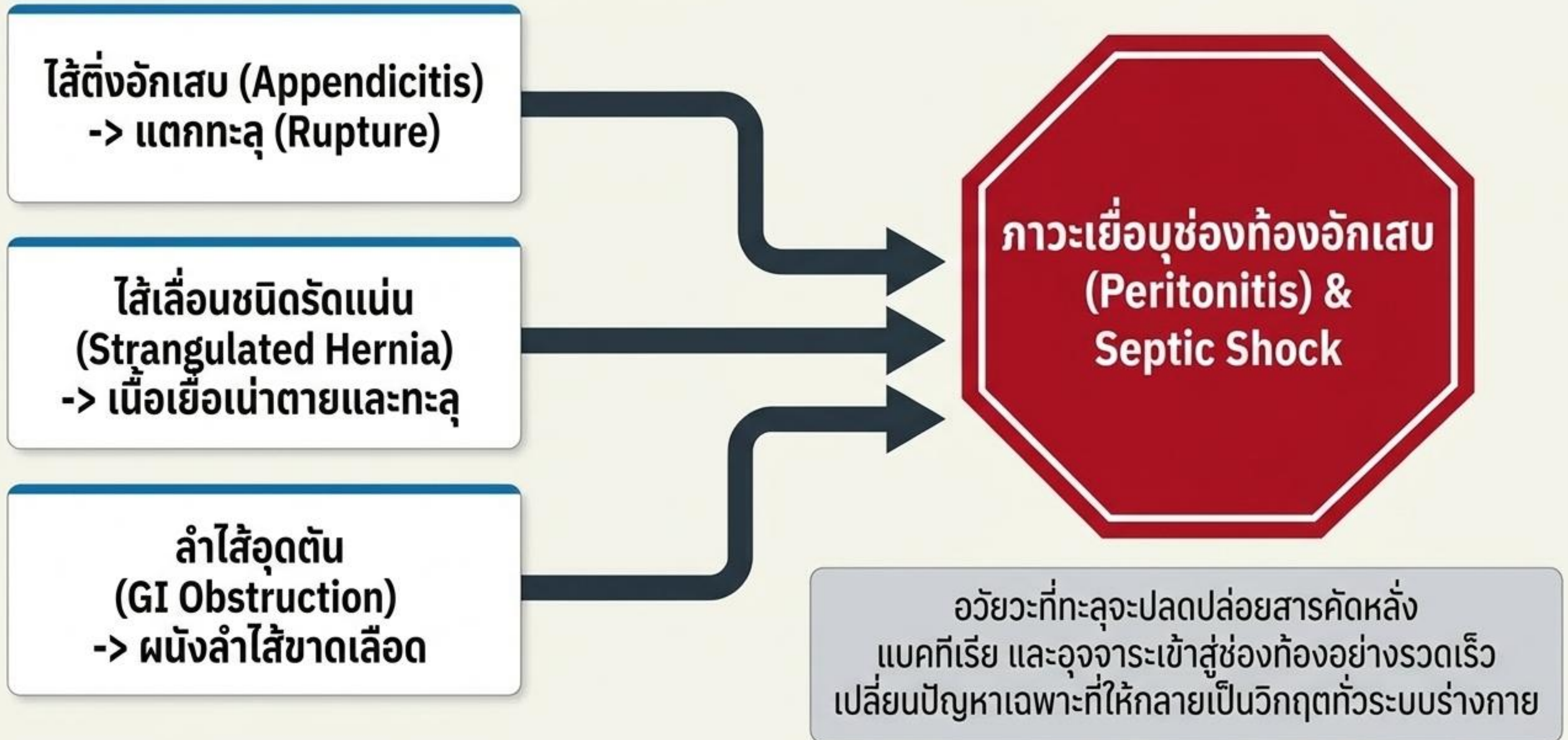
แก๊สใต้กะบังลม (Free air
under diaphragm) -
สัญญาณเตือนอวัยวะกลวงทะลุ!

การจัดการก่อนผ่าตัด (Pre-operative Nursing Protocol)

PROTOCOL APPROVED		STRICTLY PROHIBITED	
✓	งดน้ำและอาหารทางปาก (NPO) ทันที	✗	ห้ามให้ยาถ่าย / สวนอุจจาระ (No Enema)
✓	ให้สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทางหลอดเลือดดำปริมาณสูง (เพื่อพยุงความดันโลหิต)	✗	ห้ามประคบร้อนบริเวณหน้าท้อง (No Heat Pads) - ความร้อนเร่งการบีบตัว ทำให้ไส้ติ่งแตกเร็วขึ้น
✓	GI Obstruction: ใส่สาย NG tube ต่อเครื่องดูดต่ำต่อเนื่อง (Decompression) เพื่อระบายแก๊สและลดการขยายตัว		

⚠️ หากผู้ป่วย หายปวดท้องทันทีทันใด ห้ามวางใจ! นี่คือสัญญาณเตือนว่า ไส้ติ่งแตกทะลุแล้ว ต้องรายงานแพทย์ทันที

The Convergence on Sepsis: จุดบรรจบของวิกฤตหน้าท้อง



ภาวะเยื่อช่องท้องอักเสบ (Peritonitis): ปฏิกิริยาลูกโซ่สู่ความตาย

Bacterial Leak: แบคทีเรีย/สารพิษ รั่วไหลเข้าช่องท้อง (Peritoneal cavity)

Inflammatory Response: หลอดเลือดขยายตัว มีความซึมผ่านสูง
(Vasodilation & High permeability)

Massive Fluid Shift: สารน้ำและโปรตีนรั่วไหลเข้าสู่ช่องท้อง (เกิดสารน้ำคั่ง)

Systemic Crash: ภาวะขาดน้ำรุนแรง, ลำไส้หยุดทำงาน (Paralytic ileus)

End Stage: สารพิษ (Endotoxins) ซึมเข้ากระแสเลือด นำไปสู่
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Septic shock) และอวัยวะล้มเหลว

อาการแสดงวิกฤตของเยื่อช่องท้องอักเสบ (The Peritonitis Profile)



Board-like rigidity: หน้าท้องแข็งเกร็งคล้ายแผ่นกระดาน (กล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งตัวต้านความเจ็บปวด)

Generalized pain & rebound:

ปวดรุนแรงตลอดเวลาและ
เจ็บเสียวทั่วท้องเมื่อปล่อยมือ



Absent bowel sounds:

ฟังเสียงบิบบตัวของลำไส้ไม่ได้เลย
(สัญญาณของลำไส้หยุดทำงาน)

Systemic Signs:

ไข้สูง หายใจตื้นเร็ว ชีพจรเบาเร็ว
(สัญญาณชีพเข้าสู่ภาวะช็อก)



Protective Posture:

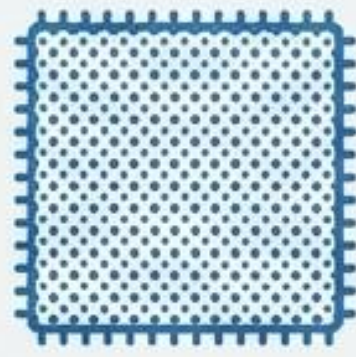
ผู้ป่วยนอนนิ่ง ชันเข่าขึ้น (Flexed knees)
เพื่อลดความตึงของผิวหน้าท้อง

การระงับเหตุทางศัลยกรรม (Definitive Surgical Interventions)



Appendectomy (การตัดไส้ติ่ง)

ทำได้ทั้งแบบเปิด (Open)
หรือส่องกล้อง (Laparoscopic)



Herniorrhaphy / Hernioplasty

ด้นลำไส้กลับและเย็บซ่อมหน้าท้อง
มักใช้แผ่นตาข่ายสังเคราะห์
(Synthetic mesh)
เพื่อลดการตึงและป้องกันการเป็นซ้ำ



Bowel Resection & Anastomosis

ตัดลำไส้ส่วนที่เน่าตายออกและ
เย็บต่อส่วนที่ดี หากมี
Strangulated hernia
หรือลำไส้อุดตันเรื้อรัง

The Critical Rescue

สำหรับ Generalized Peritonitis ต้องทำการผ่าตัดเปิดช่องท้องกว้างเพื่อล้างทำความสะอาด (Exploratory Laparotomy with Peritoneal Lavage) และใส่สายระบายคั่งไว้ พร้อมให้ยาปฏิชีวนะ (Broad-spectrum IV) ทันที

พิมพ์เขียวการพยาบาลระยะผ่าตัดเปิดช่องท้อง (Exploratory Laparotomy)



Pre-Operative



Fluid Resuscitation:
ให้ Isotonic fluid
รวดเร็ว

ประเมินดัชนีชี้วัด:
ปัสสาวะต้องออก
> 30 mL/hr



GI Decompression:
ใส่สาย NG tube
ทันทีเพื่อระบาย
แก๊สและน้ำย่อย
(Aspiration
prophylaxis)



Medication:
ให้ยาปฏิชีวนะ
ทางหลอดเลือด
ดำภายใน 60
นาทีก่อนผ่าตัด



Post-Operative



Respiratory:
จัดท่า Semi-
Fowler's
ป้องกันภาวะ
ปอดแฟบ
(Atelectasis)



Drain Assessment:
สังเกตสารคัด
หลั่ง หากออก
> 100 mL/hr
หรือเปลี่ยน
เป็นสีน้ำตาล/
อุจจาระ ต้อง
รายงานแพทย์

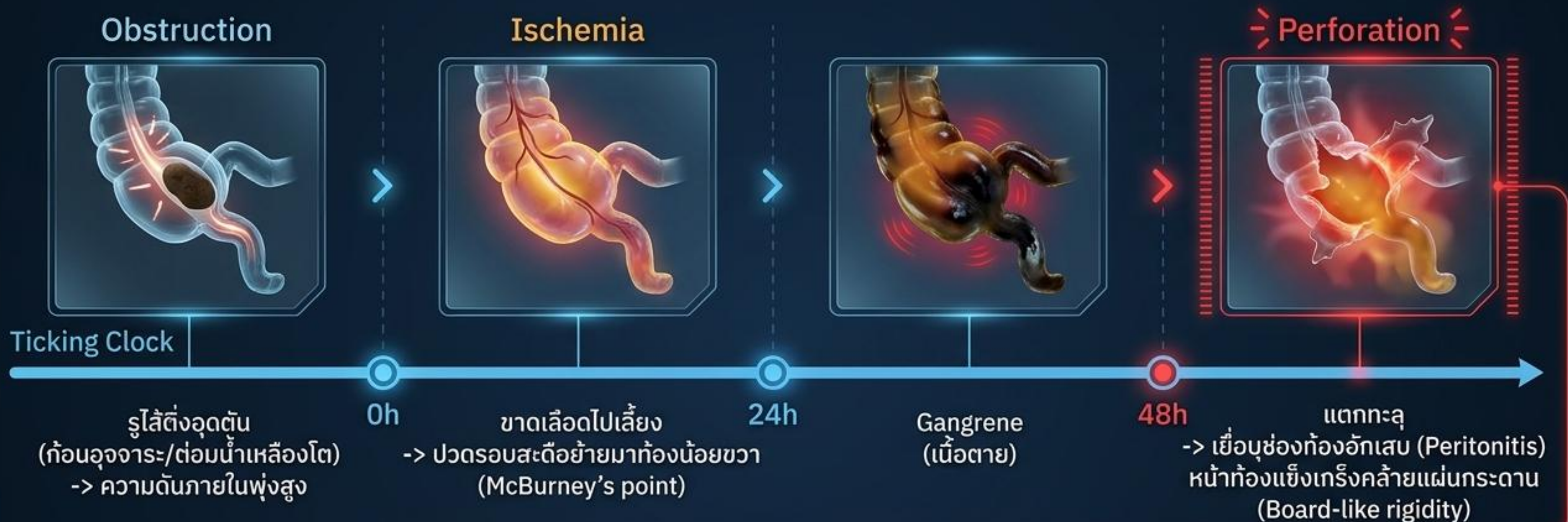


Early Ambulation:
พลิกตัวทุก 2
ชม. และกระตุ้น
ลุกเดิน เพื่อ
ป้องกันพังผืด
และฟื้นฟูการ
บีบตัวของลำไส้



Pain Management:
ประเมิน
ความปวด
และดูแล
การให้ยา
ผ่านเครื่อง
PCA

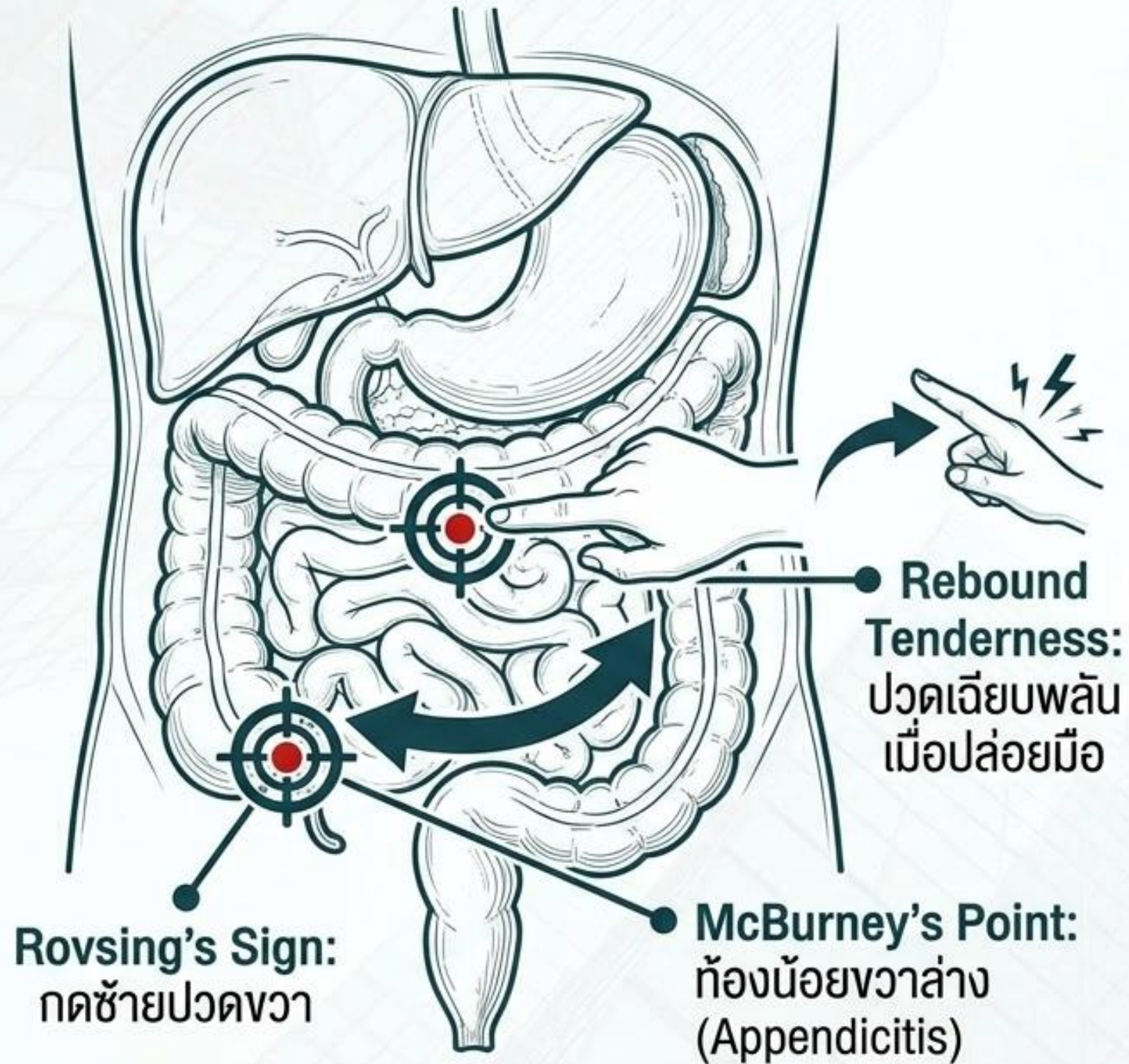
ลำดับเวลาวิกฤตของไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis Timeline)



  ห้ามประคบร้อน
ห้ามสวนอุจจาระ
(เร่งให้ไส้ติ่งแตก)

 หากผู้ป่วยบอกว่า
“อาการปวดหายไปทันที”
= ไส้ติ่งแตกทะลุแล้ว!

Acute Abdomen: Clinical Diagnostic Map



Comparison Matrix

Appendicitis (ไส้ติ่งอักเสบ)

- ปวดท้องรอบสะดือ ย้ายมาขวาล่าง
- มีไข้ต่ำ คลื่นไส้



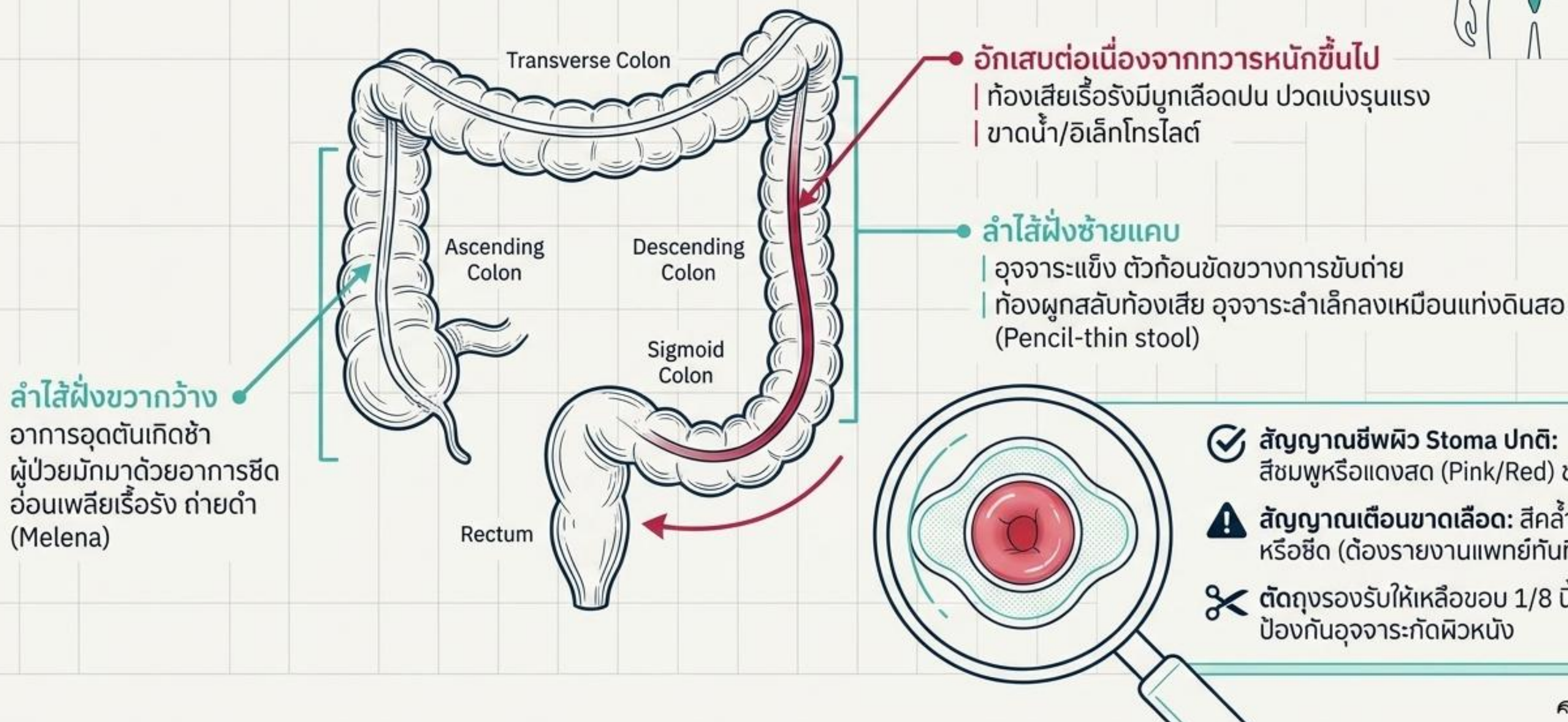
***Warning*:**

ปวดหายกะทันหัน
= **ไส้ติ่งแตก!**
ห้ามประคบร้อน/
ห้ามสวนอุจจาระ

Peritonitis (เยื่อช่องท้องอักเสบ)

- ปวดรุนแรงทั่วท้องตลอดเวลา
- ท้องแข็งเกร็งคล้ายแผ่นกระดาน (Board-like rigidity)
- Absent bowel sounds
- ไข้สูง ช็อก

โรคและการอักเสบของลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Lower Tract Disorders)



มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon): ความแตกต่างตามตำแหน่งกายวิภาค

มะเร็งฝั่งขวา (Ascending Colon)



ลำไส้ฝั่งนี้กว้าง อาการอุดตันจึงเกิดช้า.

Symptoms: ถ่ายอุจจาระปนเลือดสีดำ (Melena), ซีดอ่อนเพลียเรื้อรัง (Anemia) ไม่ทราบสาเหตุ, คลำพบบก้อน

มะเร็งฝั่งซ้าย (Descending Colon) & ทวารหนัก (Rectum)



ลำไส้ฝั่งนี้แคบ อุจจาระแข็งตัว ก้อนขัดขวางการขับถ่ายง่าย.

Symptoms: ท้องผูกสลับท้องเสีย, อุจจาระลำเล็กลงเหมือนแท่งดินสอ (Pencil-thin stool), ถ่ายเป็นเลือดสด



The Fix (Stoma Care Alert): ประเมินสีของ Stoma ใน 24-48 ชม. แรก ต้องมีสีชมพู/แดงสด (ชุ่มชื้น) หากพบสีคล้ำ ดำ หรือซีด = **ลำไส้ขาดเลือด (Ischemia)** ต้องรายงานแพทย์ทันที

ภาวะลำไส้อุดตัน (GI Obstruction) และไส้เลื่อน (Hernia)

โรคไส้เลื่อน (Hernia)



โรคไส้เลื่อน (Hernia): Reducible (ดันกลับได้) vs. Incarcerated (ติดค้าง). **Emergency:** Strangulated Hernia (คอกุ้งรัดแน่นจนลำไส้ขาดเลือดน่าตาย) ปวดเฉียบพลัน ก้อนแข็งตึง สีคล้ำ

ลำไส้อุดตัน (GI Obstruction)



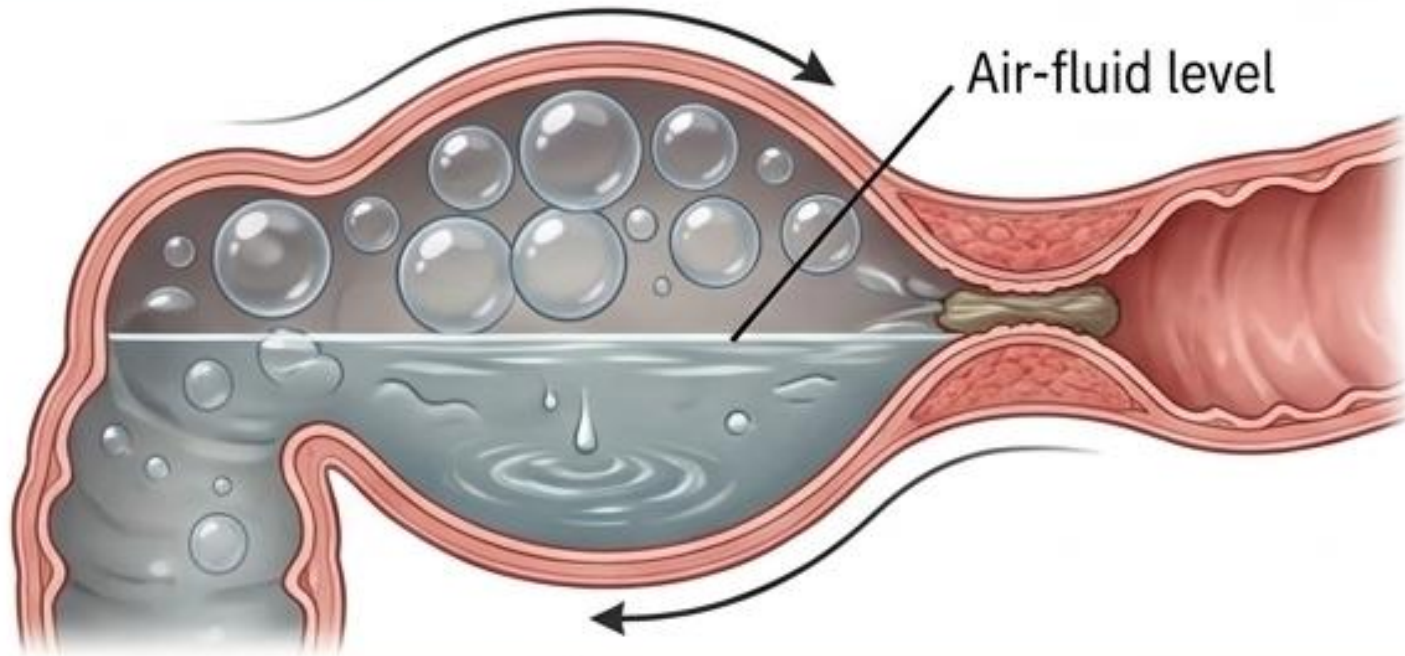
ลำไส้อุดตัน (GI Obstruction):
อาการแสดง: ปวดท้องบีบเป็นพักๆ (Colicky pain), ท้องอืดโตชัดเจน, อาเจียนมีกลิ่นอุจจาระ, ภาพถ่ายรังสีพบ Air-fluid levels (บันได)



The Fix: ใส่สาย NG tube ต่อเครื่องดูดเพื่อระบายแก๊สและสารน้ำค้าง (Decompression) กันที

GI Obstruction & Hernia Pathophysiology

Mechanical Obstruction



Strangulated Hernia



GI Obstruction Symptoms

- ปวดท้องบีบๆ (Colicky pain)
- ท้องอืดโต
- คลื่นไส้อาเจียน (อาเจียนกลิ่นอุจจาระ = อุตันส่วนล่าง)
- ไม่ถ่าย/ไม่ผายลม (Obstipation)

X-Ray Finding

ภาพระดับน้ำสลับแก๊สคล้ายบันได (Step-ladder pattern)

Hernia Progression

Reducible
(ดันกลับได้)

→ Incarcerated
(ติดค้าง/อุตัน)

→ Strangulated
(ขาดเลือด เนื้อตาย
ทะลุรวดเร็ว =
ภาวะฉุกเฉิน!)

Primary Nursing Goal: NG Tube Decompression
ต่อเครื่องดูดน้ำ ระบายแก๊สและสารน้ำค้าง

ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative Colitis)



The Break

ภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์เยื่อบุลำไส้
เกิดแผลตื้นจำนวนมากต่อเนื่อง
กัน (Continuous lesion)
เริ่มจากทวารหนักลามขึ้นบน



The Alarm

ท้องเสียเรื้อรังมีมูกเลือดปน
(Bloody Diarrhea)
วันละหลายสิบครั้ง,
ปวดเบ่งรุนแรง (Tenesmus),
ซีดและอัลบูมินต่ำ
ซีดและอัลบูมินต่ำ

Nursing Interventions



Diet: ทานอาหารโปรตีนสูง
กากใยต่ำ (Low-residue diet)
หลีกเลี่ยงนมและอาหารรสจัด



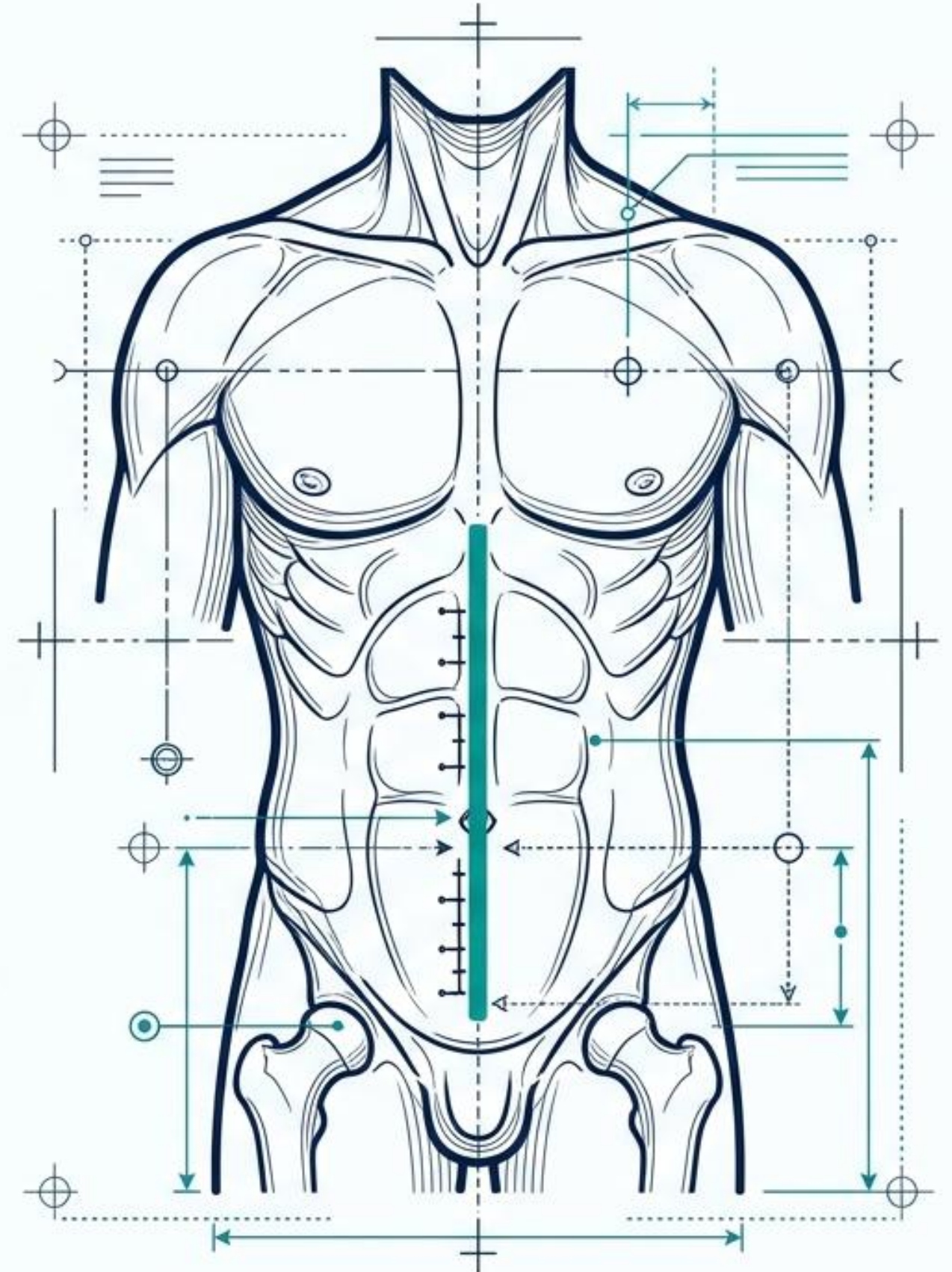
Hydration: ติดตาม I/O
และระดับโพแทสเซียมในเลือด
อย่างใกล้ชิด



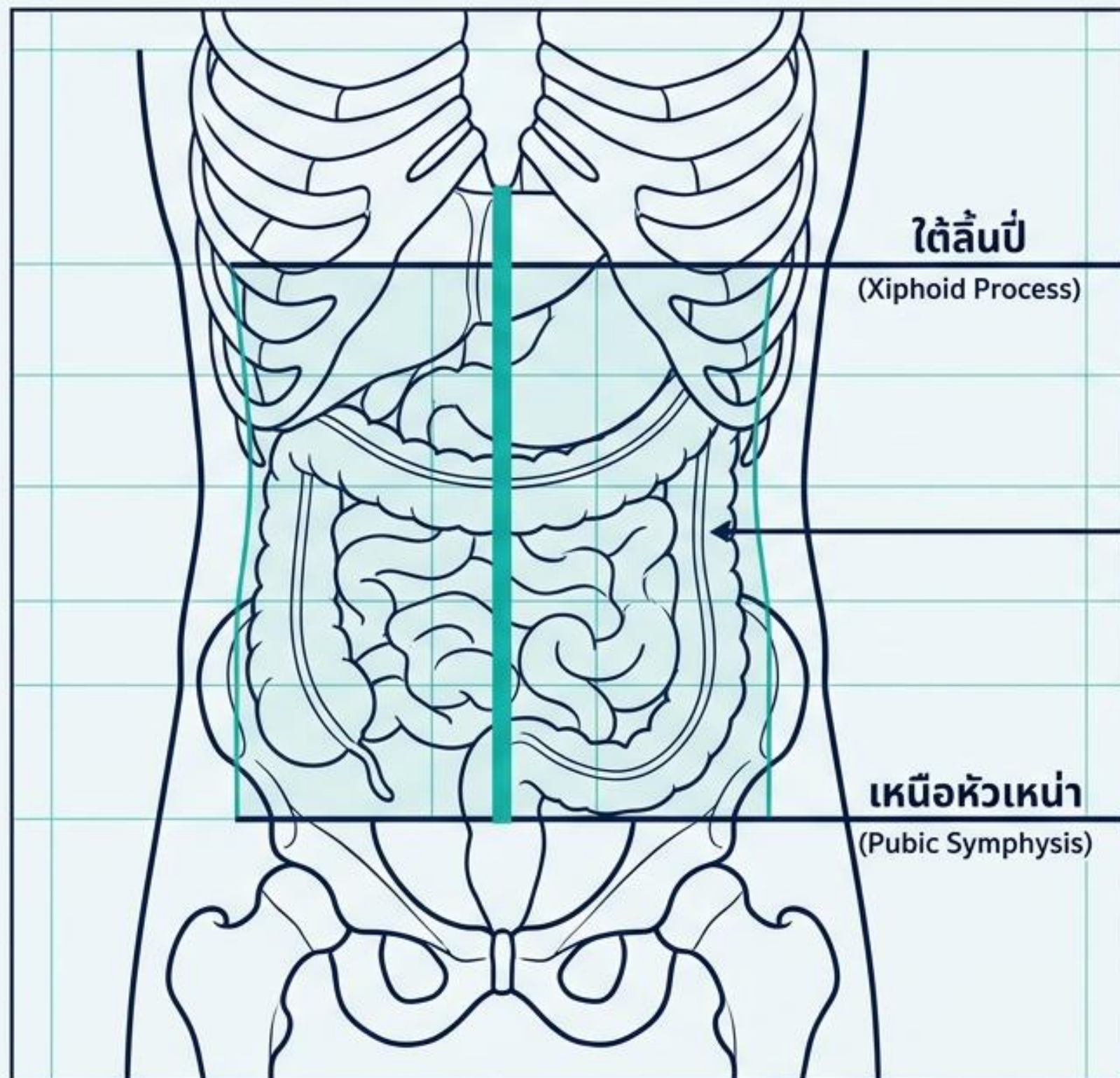
Skin Care: ทำความสะอาด
รอบทวารหนักอย่างนุ่มนวล
ทา Zinc oxide cream ป้องกัน
ผิวเปื่อยยุ่ย

CLINICAL BLUEPRINT & DASHBOARD

การพยาบาลผู้ป่วย ระยะก่อนและหลัง ผ่าตัดเปิดช่องท้อง (Perioperative Care for Exploratory Laparotomy)



ขอบเขตและวัตถุประสงค์ (Scope & Objectives)



1. สำรวจ (Explore)

วินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนด้วยการตรวจภายนอก

2. วินิจฉัย (Diagnose)

เข้าถึงช่องท้อง (Peritoneal
cavity) อย่างครอบคลุม

3. แก้ไข (Intervene)

ระงับเหตุและแก้ไขพยาธิสภาพที่
เป็นอันตรายเฉียบพลัน

4 ข้อบ่งชี้สำคัญทางศัลยกรรม (Surgical Emergencies)



ภาวะอวัยวะภายในช่องท้องทะลุ (Hollow Viscus Perforation)

กระเพาะอาหารทะลุ (PPU),
ไส้ติ่งแตก (Ruptured Appendicitis)
→ เสี่ยงเยื่อช่องท้องอักเสบ
(Generalized Peritonitis)



การตกเลือดในช่องท้องรุนแรง (Severe Hemorrhage)

อุบัติเหตุช่องท้องถูกกระแทก
(Blunt Trauma),
หลอดเลือดแดงใหญ่แตก (AAA)



ภาวะลำไส้อุดตันรุนแรง (Severe Obstruction)

ลำไส้บิดเกลียว (Volvulus),
ลำไส้กลืนกัน (Intussusception)
→ เสี่ยงลำไส้เน่าตาย (Bowel strangulation)



ฝีหรือหนองในช่องท้องขนาดใหญ่ (Large Abscess)

ฝีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเจาะ
ระบายผ่านผิวหนังได้

เป้าหมายหลักของการพยาบาล (Phase Objective Matrix)

ระยะก่อนผ่าตัด (Pre-Op)

การรักษาเสถียรภาพ
(Stabilization & Decompression)

Key Focus:

- ฟื้นฟูสารน้ำ
- ระบายสารคัดหลัง
- เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน



ระยะหลังผ่าตัด (Post-Op)

การฟื้นฟูระบบและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
(Systemic Recovery & Prevention)

Key Focus:

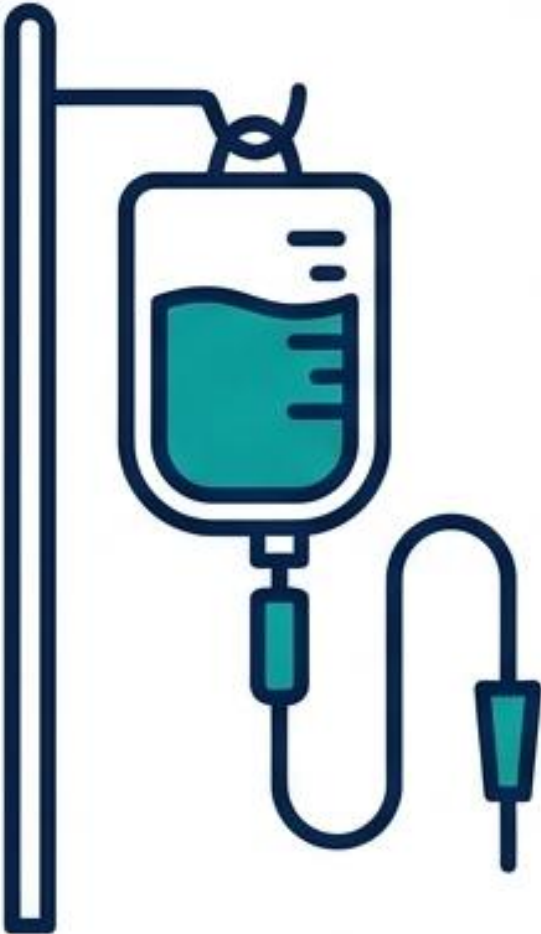
- การหายใจ
- การเคลื่อนไหวของลำไส้
- จัดการความปวด
- เฝ้าระวังแผลแยก



Pre-Op 1: การฟื้นฟูสภาพสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ (Fluid Resuscitation)

INPUT DATA

OUTPUT KPI



IV ACCESS

18–20 gauge
(1–2 เส้น)

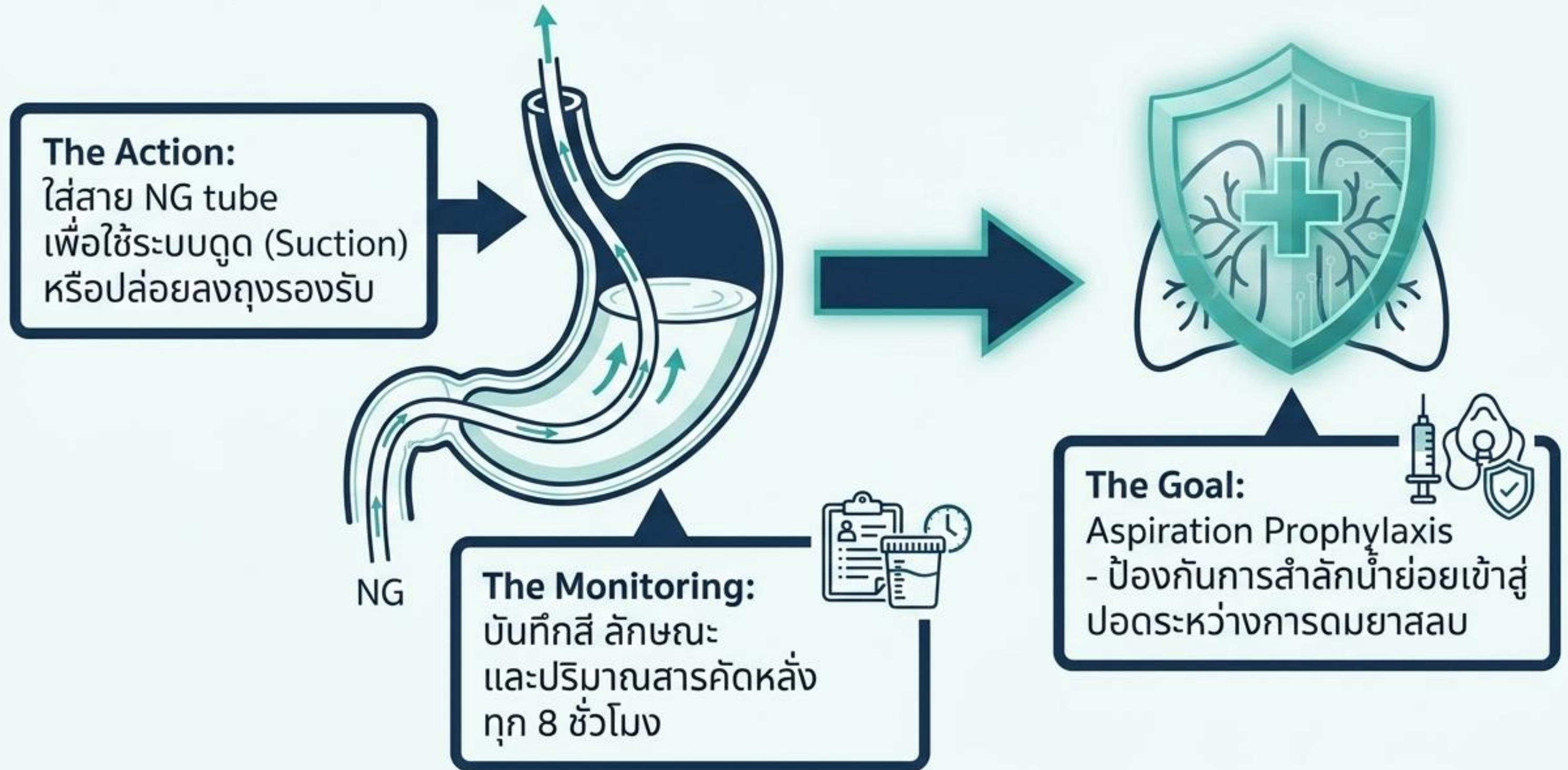
FLUID TYPE

Crystalloids
(0.9% NSS, Lactated Ringer's)
อย่างรวดเร็ว



ดัชนีชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกว่า
อวัยวะสำคัญได้รับเลือดไปเลี้ยงเพียงพอ

Pre-Op 2: การลดความดันและระบายสารคัดหลั่ง (GI Decompression)



Pre-Op 3: การจัดการทางยาและเตรียมความพร้อม (Medical & Legal Readiness)



Prophylactic Antibiotics: ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ภายใน 60 นาที ก่อนผ่าตัด (ลดการติดเชื้อ)



Informed Consent: ตรวจสอบความถูกต้องของใบยินยอมรับการผ่าตัด และดมยาสลบ



Foreign Body Removal: ถอดฟันปลอม และเครื่องประดับทั้งหมด



Skin Prep: เตรียมผิวหนังหน้าท้องตามมาตรฐานสถาบัน



5 เสาหลักการพยาบาลระยะหลังผ่าตัด (The 5 Pillars of Recovery)



Post-Op 1: ระบบทางเดินหายใจและสัญญาณชีพ (Respiratory Management)



The Position



จัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา
(Semi-Fowler's position)

The Biomechanics



ช่วยให้กะบังลมหย่อนตัวลง (Diaphragm drops) → ปอดขยายตัวได้เต็มที่

The Goal



ส่งเสริมการไอขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ
และป้องกันภาวะปอดแฟบ (Atelectasis)

Note: เฝ้าระวังทางเดินหายใจอุดตันหลังถอดท่อช่วยหายใจ

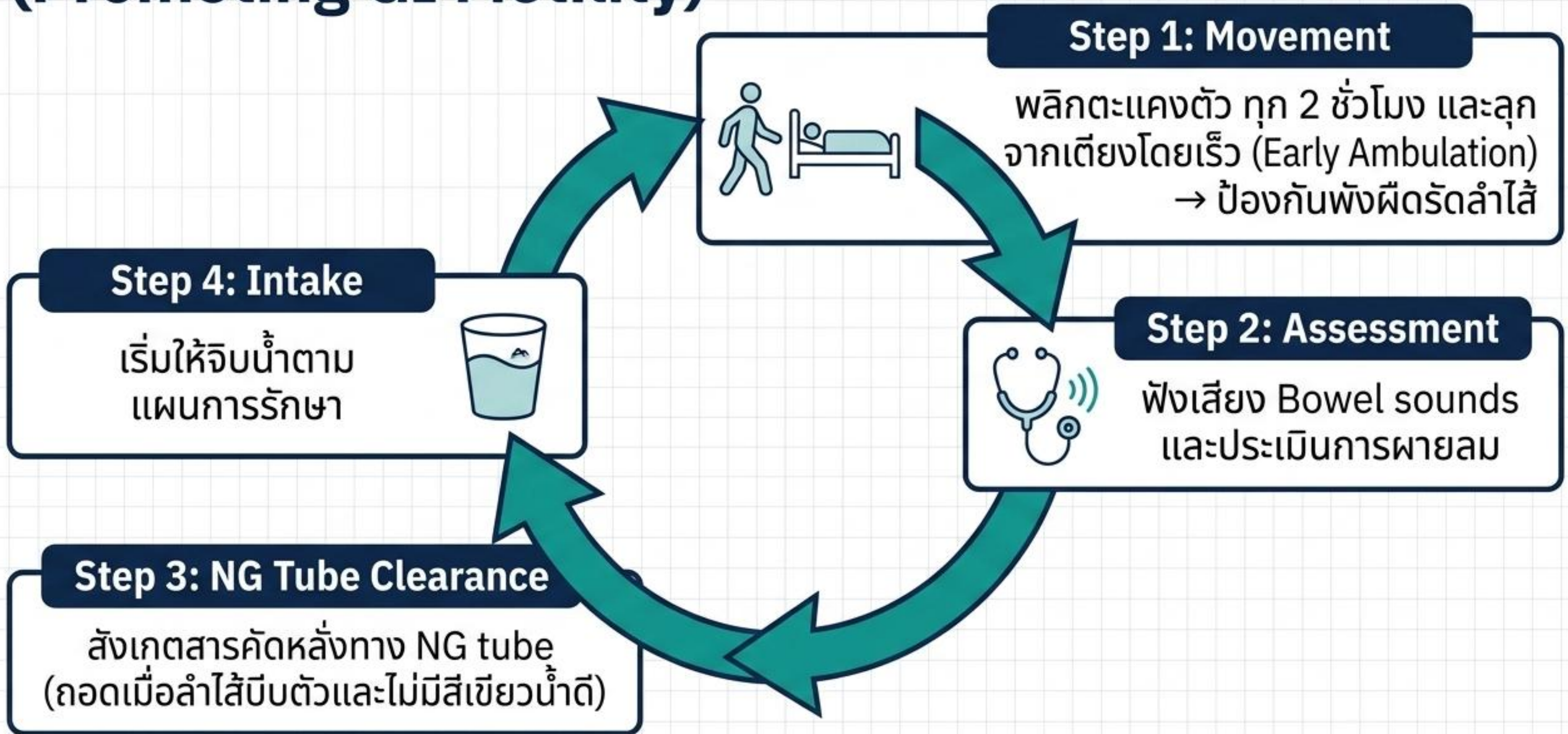
Post-Op 2: การประเมินแผลและสายระบาย (Wound & Drain Assessment)

ภาวะปกติ (Normal/Expected)		สัญญาณเตือน (Red Flags!) ต้องรายงานแพทย์ทันที
[STATUS]: สภาพเป็นสุญญากาศ (Maintains vacuum)		[ALERT 1]: ปริมาณมากผิดปกติ > 100 mL/ชั่วโมง
[FLUID]: สีเซรุ่ม/เลือดจางๆ ปริมาณลดลงตามลำดับ		[ALERT 2]: สารคัดหลั่งเปลี่ยนเป็นสีคล้าย อุจจาระ หรือ น้ำดี

Note: ตรวจสอบผ้าก๊อชปิดแผลบ่อยๆ สังเกตการมีเลือดซึม

Post-Op 3: การกระตุ้นลำไส้และป้องกันพังพืด

(Promoting GI Motility)

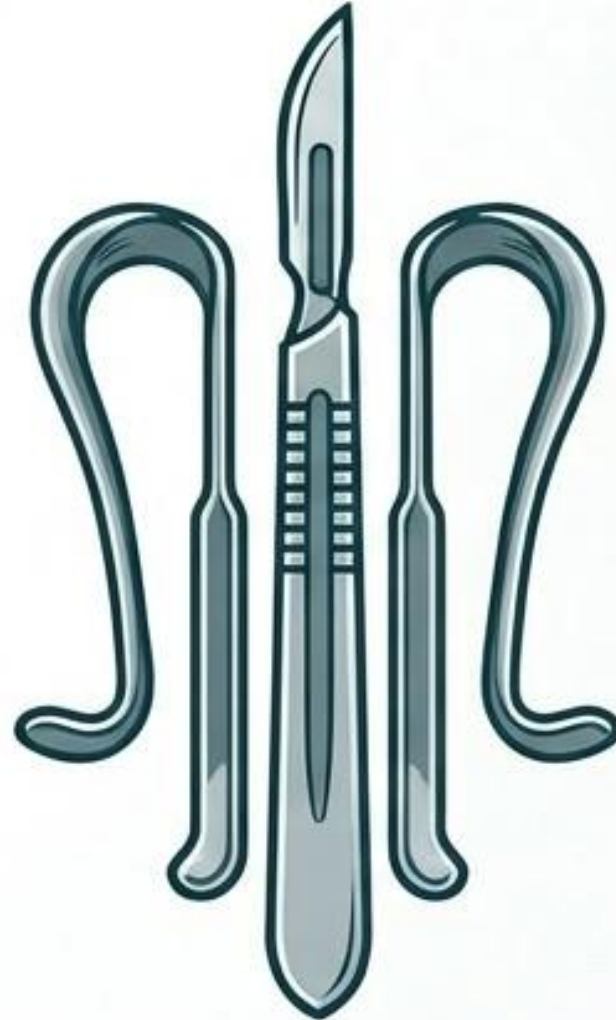


Perioperative Care Timeline: Exploratory Laparotomy

Pre-Op Phase

- **Fluid Resuscitation**
(IV 18-20 gauge)
เป้าหมาย: Urine output > 30 mL/hr
- **GI Decompression**
(NG Tube)
ลดเสี่ยง Aspiration
- **Prophylactic Antibiotics**
ภายใน 60 นาทีก่อนผ่าตัด

Intra-Op Phase



Post-Op Phase

- **Position:** Semi-Fowler's 30-45 องศา ป้องกันปอดแฟบ (Atelectasis)
- **Drain Care:** Alert แลพบ์หูก > 100 mL/hr หรือสีเปลี่ยนคล้ายน้ำดี/อุจจาระ
- **Recovery:** พลิกตัวทุก 2 ชม. + Early Ambulation ป้องกันพังผืดรัดลำไส้ ฟัง Bowel sounds ก่อนเริ่มจิบน้ำ
- **Pain:** ให้ Opioids ผ่าน PCA ควบคุมความปวดองค์รวม

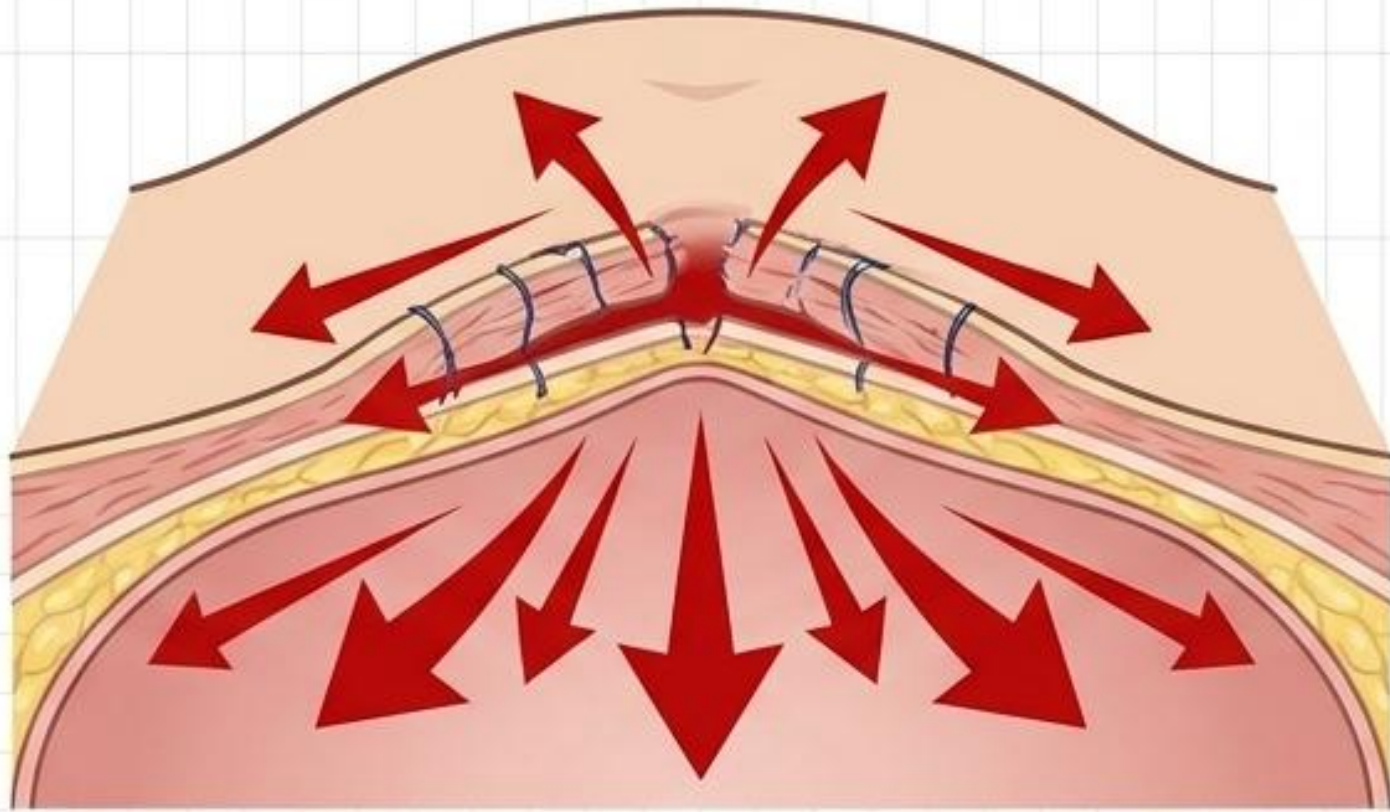
Post-Op 4: การจัดการความปวดองค์รวม (Holistic Pain Management)

The Intervention (Patient-Controlled Analgesia: PCA)

- ให้นยาแก้ปวดกลุ่ม Opioids (Morphine / Fentanyl)
- ผ่านเครื่อง PCA หรือตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- ประเมิน Pain score เป็นประจำ



ภาวะฉีกเปิด: แผลแยกและอวัยวะหลุดลอย (Wound Dehiscence & Evisceration)



⚠ Key Definition:

ภาวะที่รอยเย็บแผลหน้าท้องแยกออกจนลำไส้หรืออวัยวะภายในทะลักออกมาภายนอก

Risk Profile (กลุ่มเสี่ยงสูง)

High Alert



1. ผู้สูงอายุ
(Elderly)

High Alert



2. ไอ/จามรุนแรง
(Severe coughing/sneezing)

High Alert



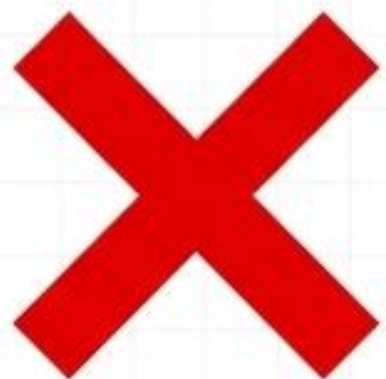
3. ท้องอืดท้อง
(Abdominal bloating)

High Alert



4. ขาดสารอาหาร
(Malnutrition)

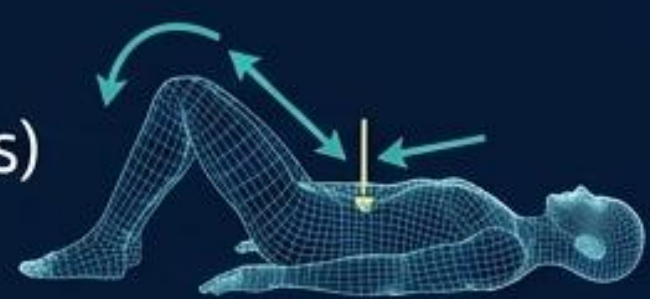
แผนตอบสนองฉุกเฉิน (Evisceration Action Plan)



ข้อห้ามเด็ดขาด (DO NOT!)

**ห้ามพยายามดันอวัยวะ
หรือลำไส้ที่หลุดออกมา
กลับเข้าช่องท้องเด็ดขาด**

ข้อปฏิบัติ (DOs)

- 1. **Protect:** คลุมปิดทับอวัยวะด้วยผ้าก๊อชชุบ 0.9% NSS ปลอดเชื้อชุมาชุ่มๆ (Sterile moist normal saline dressing) ป้องกันเนื้อเยื่อแห้งตาย 
- 2. **Position:** จัดให้นอนชันเข่า (Flex knees) เพื่อลดแรงตึงผิวหน้าท้อง 
- 3. **Prepare:**  วัดสัญญาณชีพ, งดน้ำอาหาร (NPO), เตรียมส่งเข้าห้องผ่าตัดทันที

กฎทองคำแห่งการพยาบาล (The Golden Rules Cheat Sheet)

PRE-OP (The Golden Hour)

[KPI]: Urine Output >30 mL/hr
(Crystalloids 18-20G)

[GI]: NG Tube Decompression
(ป้องกัน Aspiration)

[MEDS]: Antibiotics < 60 นาที
ก่อนกรีดแผล

POST-OP (The Path to Recovery)

[RESP]: Semi-Fowler's $30-45^\circ$
(ป้องกัน Atelectasis)

[DRAIN]: Alert แพทย์เมื่อ >100 mL/hr
หรือสีอุจจาระ/น้ำดี

[GI/MOBILITY]: พลิกตัว ทุก 2 ชม. +
Early Ambulation

[EMERGENCY]: Evisceration $\rightarrow$ คลุม
NSS ชุ่ม + นอนชันเข้า (ห้ามดันกลับ!)

Critical Nursing Action: Wound Evisceration (แผลหน้าท้องแยก ลำไส้ทะลัก)

Case Context: วันที่ 6 หลังผ่าตัด ไอแรง มีน้ำสีชมพูจาง (Serosanguinous) ซึมชุ่ม แผลแยก ลำไส้โผล่



DON'T: ห้ามดันหรือยัดลำไส้กลับเข้าช่องท้องเด็ดขาด!
(พยาธิสภาพ: ป้องกันเนื้อเยื่อชำรุดติดเชื้อ และการตายของลำไส้)

Step 1 [Cover]

ใช้ผ้าก๊อชปราศจากเชื้อ ชุบ 0.9% NSS
หมาดๆ คลุมปิดทับอวัยวะที่
(ป้องกันเนื้อเยื่อแห้งตาย/ขาดเลือด)



Step 2 [Position]

จัดท่านอนชันเข่า (Flex knees) ทันท
(ลดแรงตึงผิวหน้าท้องไม่ให้ปริเพิ่ม)



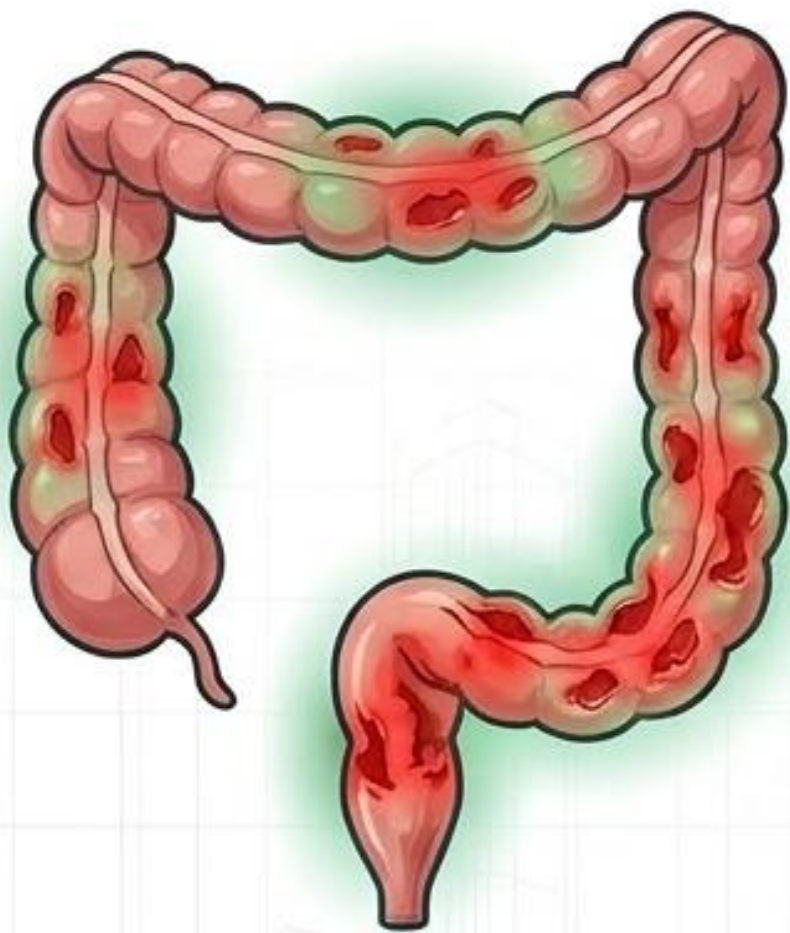
Step 3 [Stabilize]

วัดสัญญาณชีพ งดน้ำ/อาหาร (NPO)
และประสานงานส่งห้องผ่าตัดฉุกเฉิน



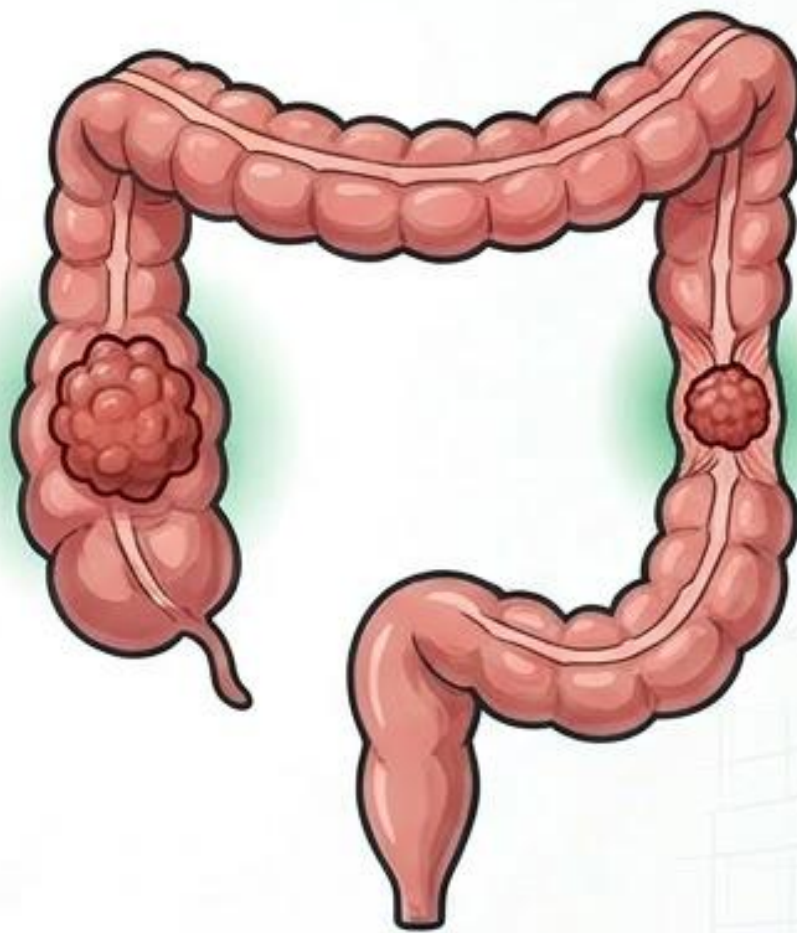
Lower GI Pathology: IBD & Colorectal Cancer

Ulcerative Colitis (IBD)



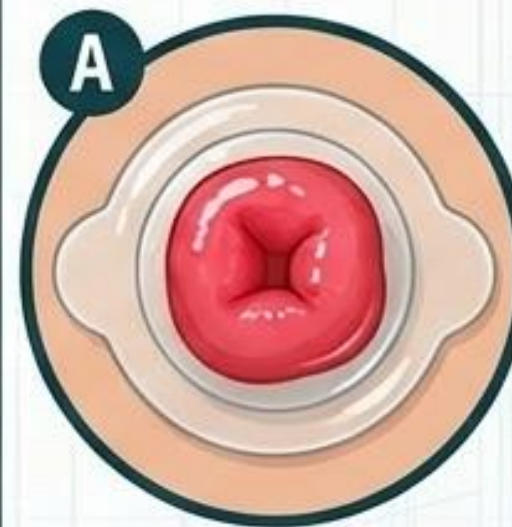
- รอยโรคต่อเนื่องจาก Rectum ขึ้นไป
- **อาการ:** ถ่ายเหลวปนมูกเลือด (Bloody Diarrhea) ปวดเบ่งทุกโชนาการ

Colorectal Cancer (CA Colon)

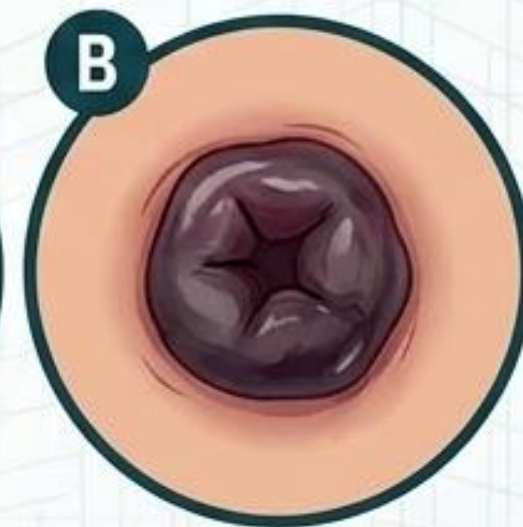


- **ผังว:** กว้าง = อาการอุจจาระขี้, ชืด, ถ่ายดำ (Melena)
- **ผังซาย:** แคบ = ท้องผูกสลับท้องเสีย, อุจจาระลำเล็กลง (Pencil-thin stool)

Post-Op Stoma Care



[Healthy]:
สีชมพูหรือแดงสด
(Pink/Red),
ชุ่มชื้น

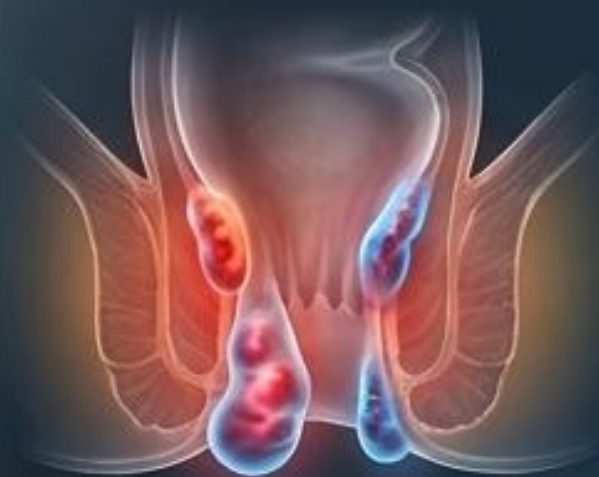


[Danger]:
สีคล้ำ ดำ หรือขีด
(ขาดเลือด)
ต้องรายงาน
แพทย์ทันที!

- ตัดถุงรองให้เหลือขอบ 1/8 นิ้ว ป้องกันอุจจาระกัดผิว

ความผิดปกติของทวารหนัก และการเตรียมส่องกล้อง (Colonoscopy)

ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)



หลอดเลือดดำโป่งพอง
-> เลือดสดหยดหลังถ่าย,
คัน, ยื่นพ้นรูทวาร

Fix Sitz bath น้ำอุ่น
15-20 นาที ลดบวม

ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)



ท่อผิดปกติจากฝีเรื้อรัง
->หนอง/น้ำเหลืองปนเลือด
ไหลซึมรอบรูทวาร

1-3 วันก่อนตรวจ:

งดอาหารกากใยสูง,
งดยาละลายลิ่มเลือด 5-7 วัน
(ป้องกันเลือดออกรุนแรงตอนตัดชิ้นเนื้อ)



1 คืนก่อนตรวจ:

ดื่มยาระบาย (PEG)
จนกว่าอุจจาระจะเป็นสีเหลืองอ่อน
ไม่มีกาก, **NPO** ล้วงหน้า 6-8 ชม.



ระหว่างตรวจ:

จัดท่านอนตะแคงซ้าย
ชันเข้าชิดอก
(Left lateral decubitus)

หัตถการส่องกล้องทวารหนักและลำไส้ใหญ่ (Proctology & Endoscopy)



ริดสีดวง (Internal ไม่เจ็บ / External เจ็บรุนแรงหากมีลิ่มเลือดอุดตัน)
vs **ฝีคัณฑสูตร** (มีท่อเชื่อมผิดปกติ มีหนองซึม)



การพยาบาล: แช่ก้นด้วยน้ำอุ่น (Sitz bath)
15-20 นาที ลดบวม/ลดปวด, **ต้มน้ำ 2-3 ลิตร**
ป้องกันท้องผูกไปครูดแผล

PRE

งดอาหารกากใยล่วงหน้า 1-3 วัน
งดยาละลายลิ่มเลือด 5-7 วัน
ให้ยาระบาย PEG จนกว่าอุจจาระเป็น
น้ำใสสีเหลืองอ่อน NPO 6-8 ชม.

INTRA

จัดท่าตะแคงซ้าย ชันเข้าชิดอก
(Left lateral decubitus),
ให้ยานอนหลับ (Conscious sedation),
เฝ้าระวัง SpO2

POST

เฝ้าระวังลำไส้ทะลุ (**Bowel Perforation** - ท้องแข็งเกร็ง
เหมือนแผ่นไม้, **ปวดรุนแรง**),
ห้ามขับถ่าย 24 ชม.

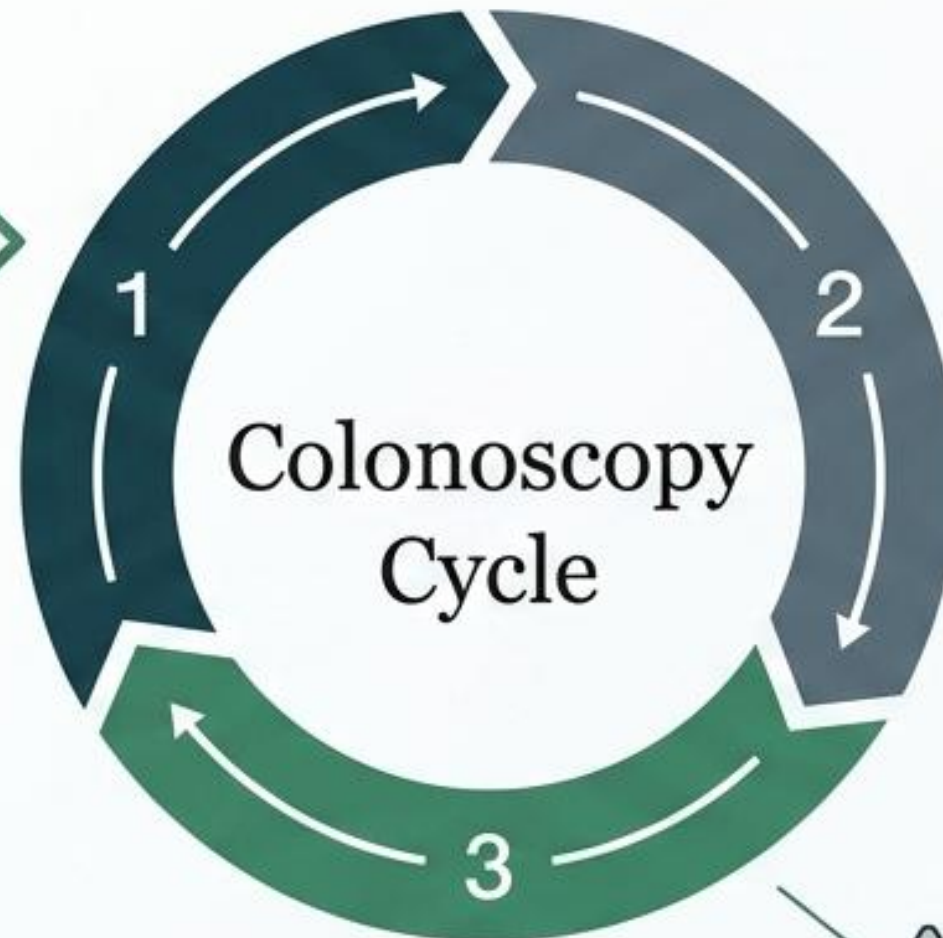
Proctology Essentials

- Hemorrhoids vs Anal Fistula:
ริดสีดวง (ความดันสูง/เส้นเลือดโป่ง) vs ฝีคัณฑสูตร (รูรั่วมีหนอง/น้ำเหลือง)
- **Nursing:** Sitz bath (แช่น้ำอุ่น 15-20 นาที)
ลดบวม/ปวด, ป้องกันท้องผูก



Pre-Procedure >>>

งดยาละลายลิ้มเลือด 5-7 วัน | **Bowel prep** ด้วย PEG จนอุจจาระเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อน ไม่มีกาก •
| NPO 6-8 ชม. •



Post-Procedure

>> **Intra-Procedure**

- จัดท่านอนตะแคงซ้าย ชันเข้าชิดอก (Left lateral decubitus)
- ให้นอนหลับ/Sedation

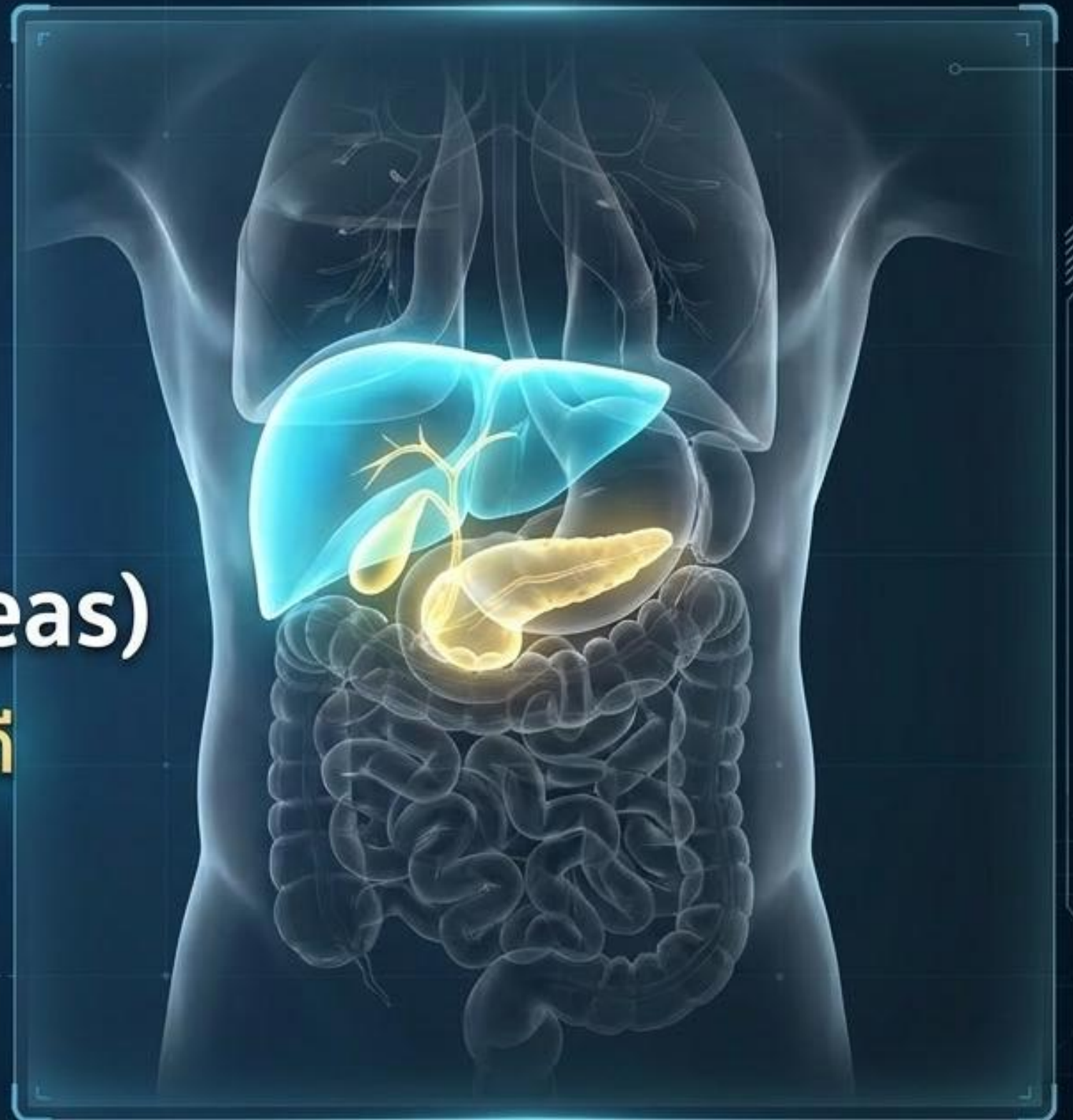


- ฝ้าระวังภาวะลำไส้ทะลุ (ปวดท้องรุนแรง ท้องแข็งเกร็ง)
- แนะนำการพยายลมเพื่อระบายแก๊ส

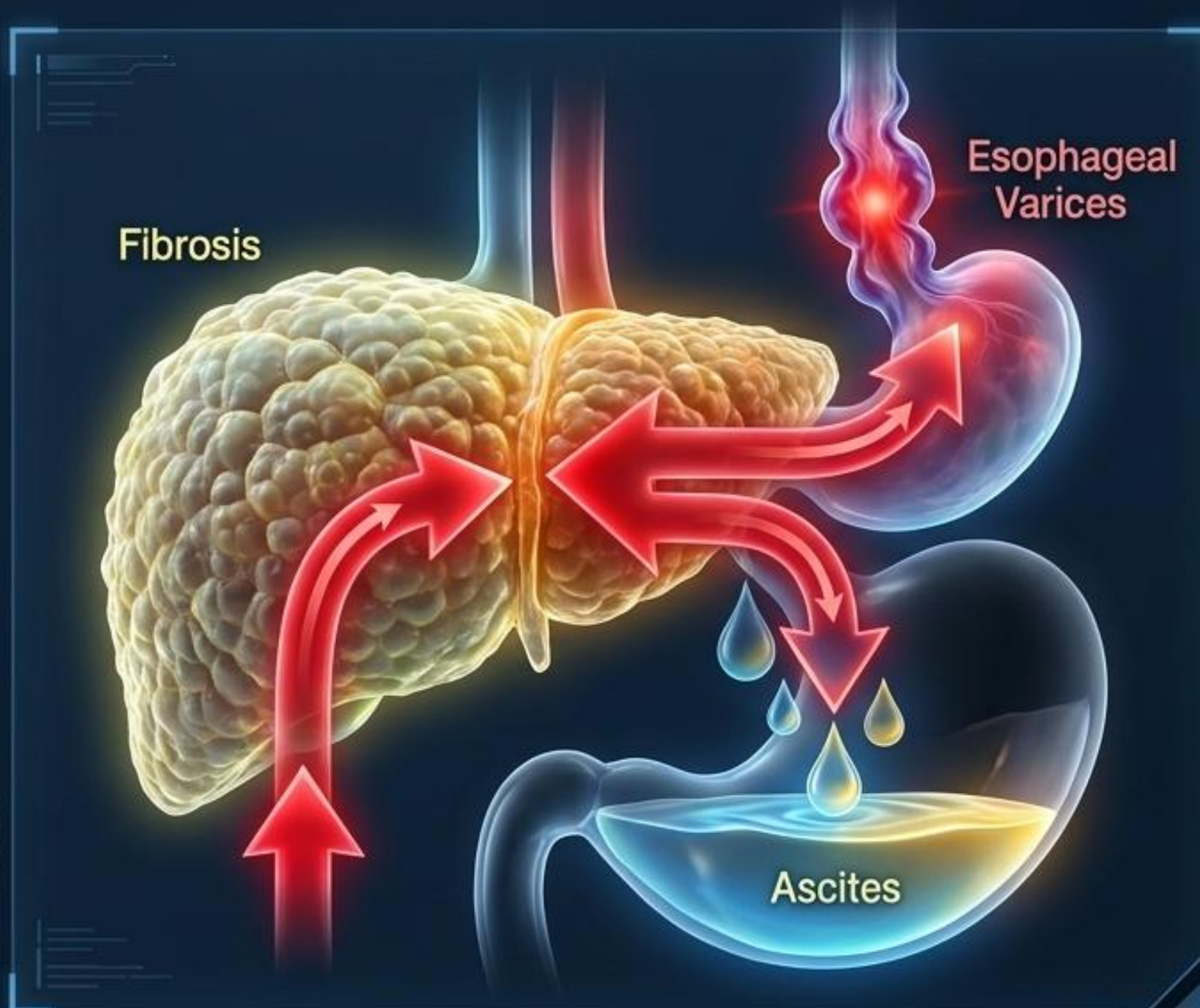


ส่วนที่ 3: ระบบตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน (Hepato-Biliary & Pancreas)

ตับแข็ง มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี
และตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน



ตับแข็ง (Cirrhosis) และการจราจรติดขัดในระบบ Portal (Portal Hypertension)



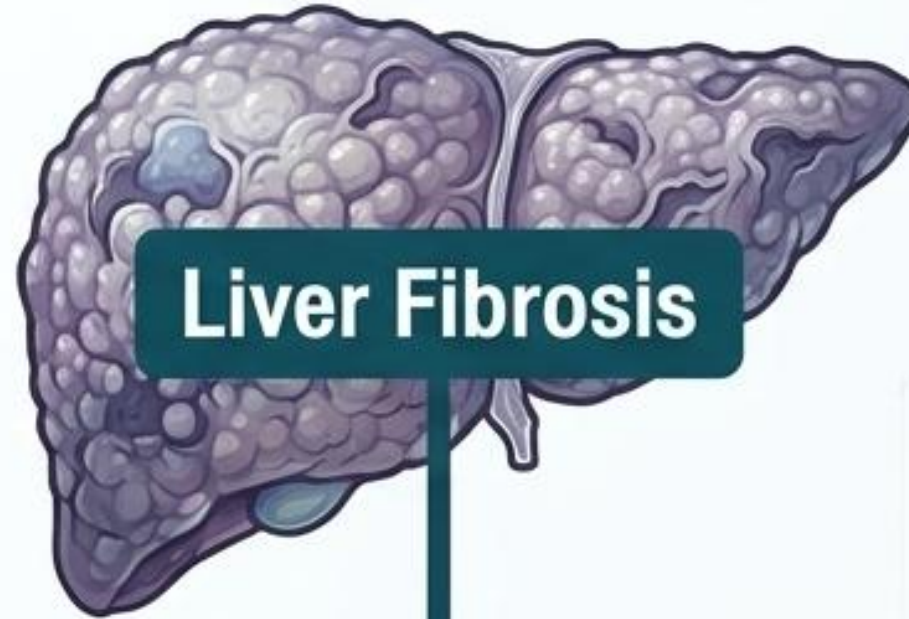
⚠ The Break & The Alarm

- เนื้อตับแข็งตัวขัดขวางการไหลเวียนเลือด เลือดไหลย้อนกลับ เกิดโคมิโนเอฟเฟกต์: ท้องมาน (Ascites), หลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร (Esophageal Varices) เสี่ยงแตกเลือดออกรุนแรง, สารพิษคั่งสมอง (Hepatic Encephalopathy): มือสั่นระริก (Asterixis), สับสน

⚙ The Fix

- **จัดการ Ascites:** จำกัดโซเดียม < 2g/วัน, วัคซีนสะอาดทุกวัน, เตรียมเจาะน้ำ (Paracentesis) ในท่ากึ่งนั่ง.
- **จัดการแอมโมเนีย:** บริหารยา Lactulose เป้าหมายคือถ่ายอุจจาระนิ่มวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อบีบแอมโมเนียทิ้ง

Hepatic Cascade: Liver Cirrhosis Complications



Branch 1: Portal Hypertension (ความดันระบบประตูตับสูง)



-> ท้องมาน (Ascites): จำกัดโซเดียม < 2g/วัน, เจาะท้องจัดท่าทึงนึ่ง (Fowler's)



-> หลอดเลือดหลอดอาหารโป่งพอง (Esophageal Varices): เสี่ยงแตก อาเจียนเป็นเลือดสด

Branch 2: Loss of Liver Function (สูญเสียหน้าที่ตับ)



-> ขาด Clotting factors: เลือดออกง่ายหยุดยาก



-> แอมโมเนียคั่งในสมอง (Hepatic Encephalopathy): อาการมือสั่นระริก (Asterixis), สับสน หมดสติ



Treatment: ให้ยา Lactulose จับแอมโมเนียทางอุจจาระ (เป้าหมายถ่ายนิ้ม 2-3 ครั้ง/วัน)

การแยกแยะฝีในตับ

อาการร่วม: ใช้สูงหนาวสั่น | ปวดเสี้ยวขวาบน (RUQ) ร้าวไปไหล่ขวา | ตับโตและกดเจ็บ

	ฝีจากแบคทีเรีย (Pyogenic)	ฝีจากเชื้อบิด (Amebic)
เชื่อก่อโรค	E. coli หรือ Klebsiella pneumoniae	Entamoeba histolytica
เส้นทางการติดเชื้อ	ลุกลามจากระบบทางเดินน้ำดี 	ผ่านระบบทางเดินอาหาร 
การตรวจพบ/การวินิจฉัย	CT Scan, Ultrasound, การเพาะเชื้อเลือด	Serology Test, การตรวจอุจจาระหาเชื้อบิด

 **Nursing Alert Box:** **เฝ้าระวังช็อกติดเชื้อ** (Septic shock): **ดูแลสายระบายหนอง** (PTD) ไม่ให้หักพับ ห้ามสวนล้างสายระบายโดยไม่มีข้อบ่งชี้ บันทึกสีและปริมาณหนองอย่างถี่ถ้วน

มะเร็งตับ (CA Liver) และมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

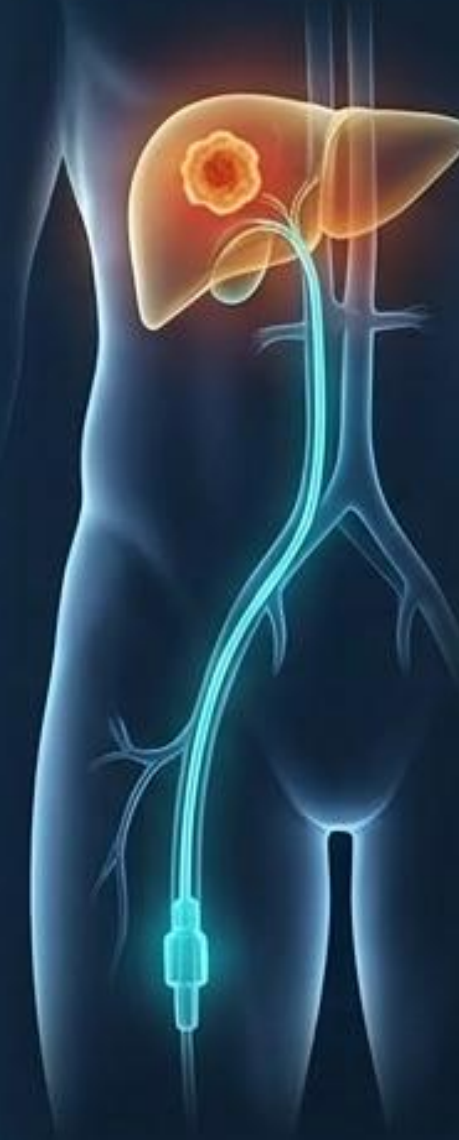
Cholangio CA



มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangio CA): สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (รับประทานปลาน้ำจืดดิบ).

อาการเด่น: ดีซ่านแบบอุดตัน (Obstructive Jaundice), อุจจาระสีซีดคล้ายดินเหนียว (Clay-colored stool), ปัสสาวะสีเข้มจัด, คันตามผิวหนังรุนแรง (Pruritus) จากเกลือน้ำดีสะสม

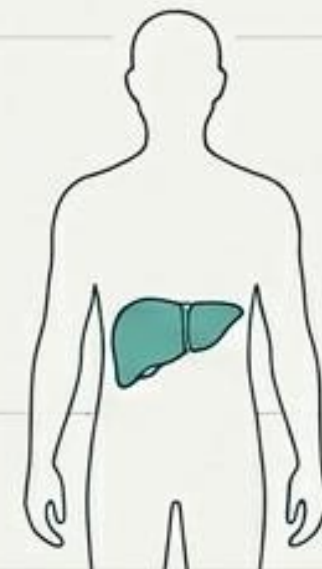
TACE Procedure



การพยาบาลหลังทำ TACE (อุดกั้นหลอดเลือดมะเร็งตับ)

- นอนราบ เหยียดขาข้างที่ทำหัตถการตรง นาน 6-8 ชั่วโมง
- ใช้อุปกรณ์กดทับแผลขาหนีบ ป้องกันเลือดออก
- ประเมินชีพจรส่วนปลาย (Pedal pulse) บ่อยๆ สังเกตสีและอุณหภูมิปลายเท้า

ตับวายและภาวะแทรกซ้อน (Cirrhosis Pathophysiology)



ตับแข็ง

(เนื้อเยื่อพังผืด **Fibrosis**
แทนที่เนื้อตับปกติ โครงสร้างบิดเบี้ยว
ขัดขวางการไหลเวียนเลือด)



Portal Hypertension



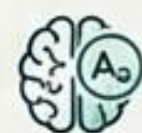
Toxin clearance failure



Ascites (ท้องมาน):
น้ำรั่วซึมเข้าช่องท้อง



Esophageal Varices:
หลอดเลือดดำโป่งพอง
หลอดเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหาร
เสี่ยงต่อการแตกและตกเลือดรุนแรง

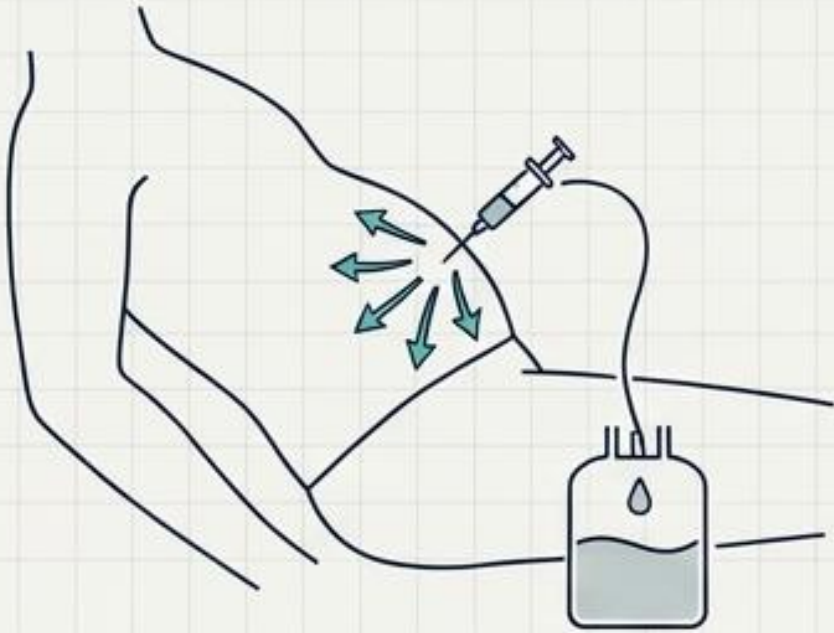


Hepatic Encephalopathy
(หมดสติจากโรคตับ):
แอมโมเนียคั่งในสมอง
เกิดอาการมือสั่นระริก
(Asterixis) สับสน



**ลดการสร้าง
Clotting factors:**
ภาวะเลือดออก
ง่ายหยุดยาก

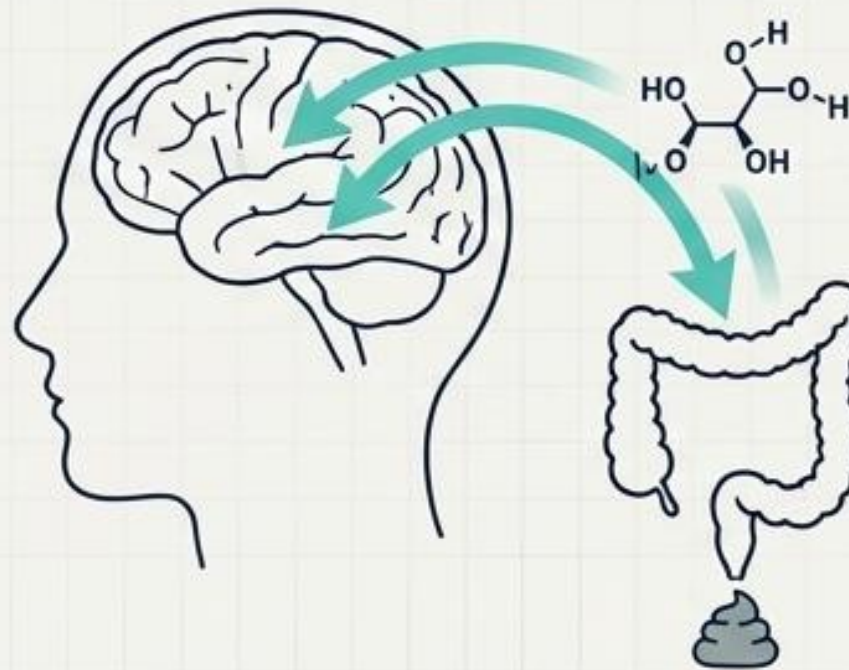
หัตถการและการรักษามะเร็งตับ (Hepatic Interventions & Oncology)



ท้องมาน / Paracentesis

จัดท่ากึ่งนั่ง (Fowler's position)
ขณะเจาะระบายน้ำ

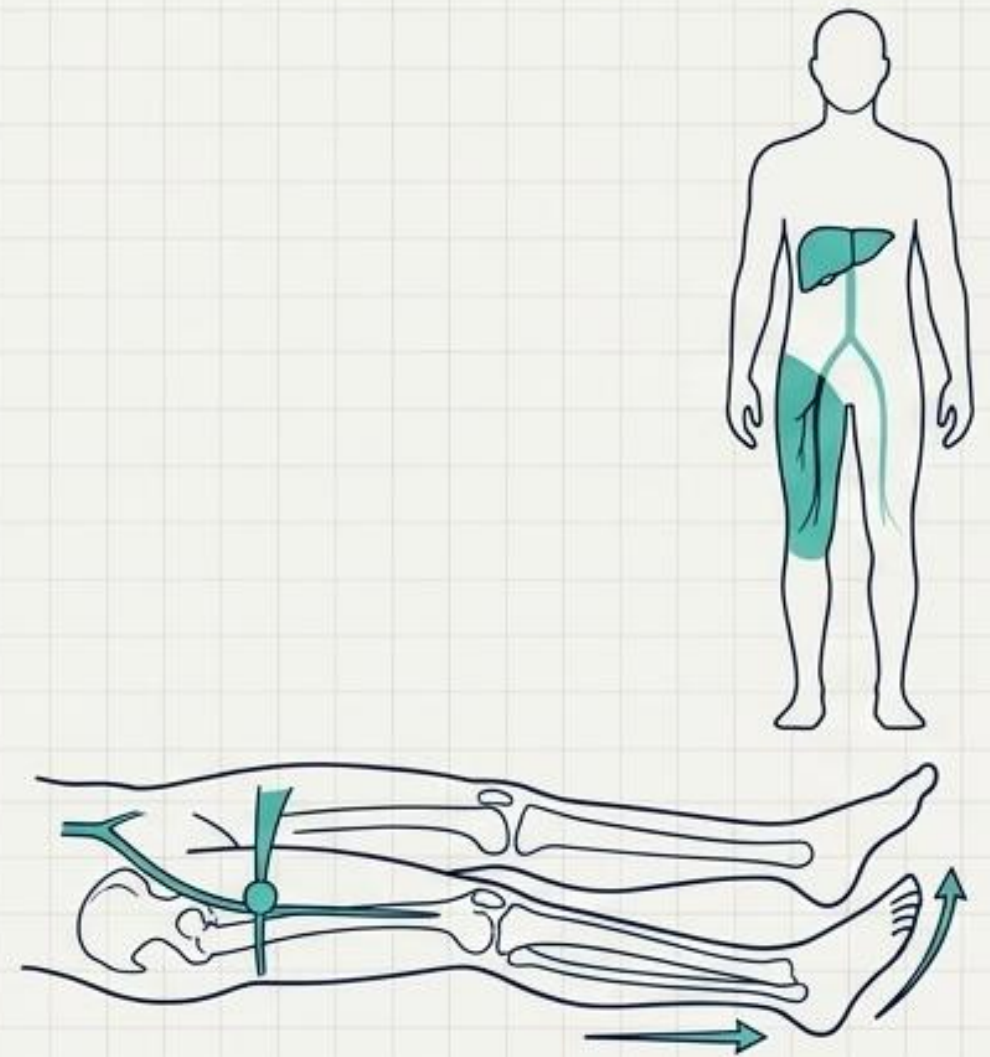
เฝ้าระวังสัญญาณชีพจากการเปลี่ยนแปลง
ความดันในช่องท้องอย่างรวดเร็ว



ภาวะทางสมอง / Hepatic Encephalopathy

บริหารยา Lactulose กระตุ้นการขับแอมโมเนีย
ทางอุจจาระ

เป้าหมายทางคลินิก: ถ่ายอุจจาระนี้วันละ 2-3 ครั้ง



มะเร็งตับ / TACE Post-Op Care

จัดให้นอนราบ เหยียดขาข้างที่ทำหัตถการตรง
นาน 6-8 ชั่วโมง

ประเมินชีพจรส่วนปลาย (Pedal pulse)
บ่อยครั้ง ตรวจสอบความเย็นและสีผิวปลายเท้า
เฝ้าระวัง Post-embolization syndrome
(ไข้ คลื่นไส้ ปวดท้องขวาบน)

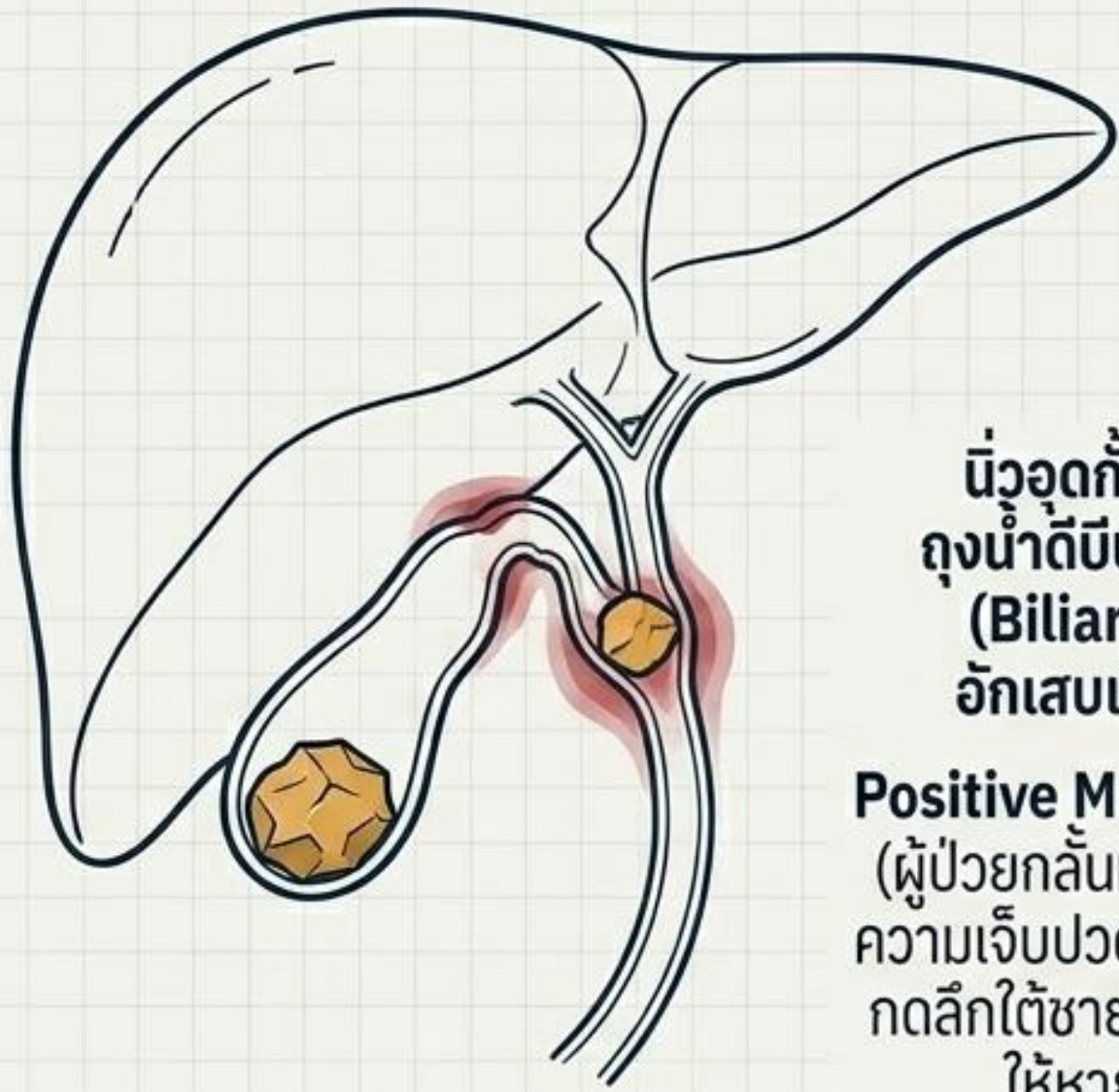
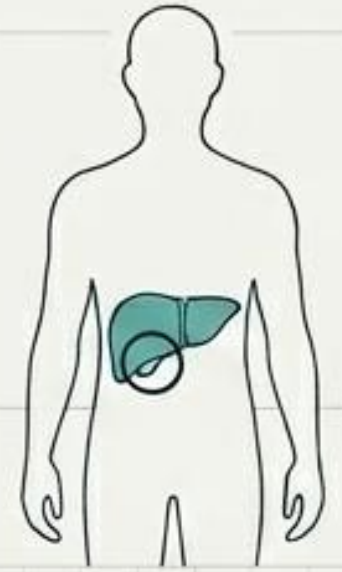
การแยกแยะฝีในตับ

อาการร่วม: ใช้สูงหนาวสั่น | ปวดเสี้ยวขวาบน (RUQ) ร้าวไปไหล่ขวา | ตับโตและกดเจ็บ

	ฝีจากแบคทีเรีย (Pyogenic)	ฝีจากเชื้อบิด (Amebic)
เชื่อก่อโรค	E. coli หรือ Klebsiella pneumoniae	Entamoeba histolytica
เส้นทางการติดเชื้อ	ลุกลามจากระบบทางเดินน้ำดี 	ผ่านระบบทางเดินอาหาร 
การตรวจพบ/การวินิจฉัย	CT Scan, Ultrasound, การเพาะเชื้อเลือด	Serology Test, การตรวจอุจจาระหาเชื้อบิด

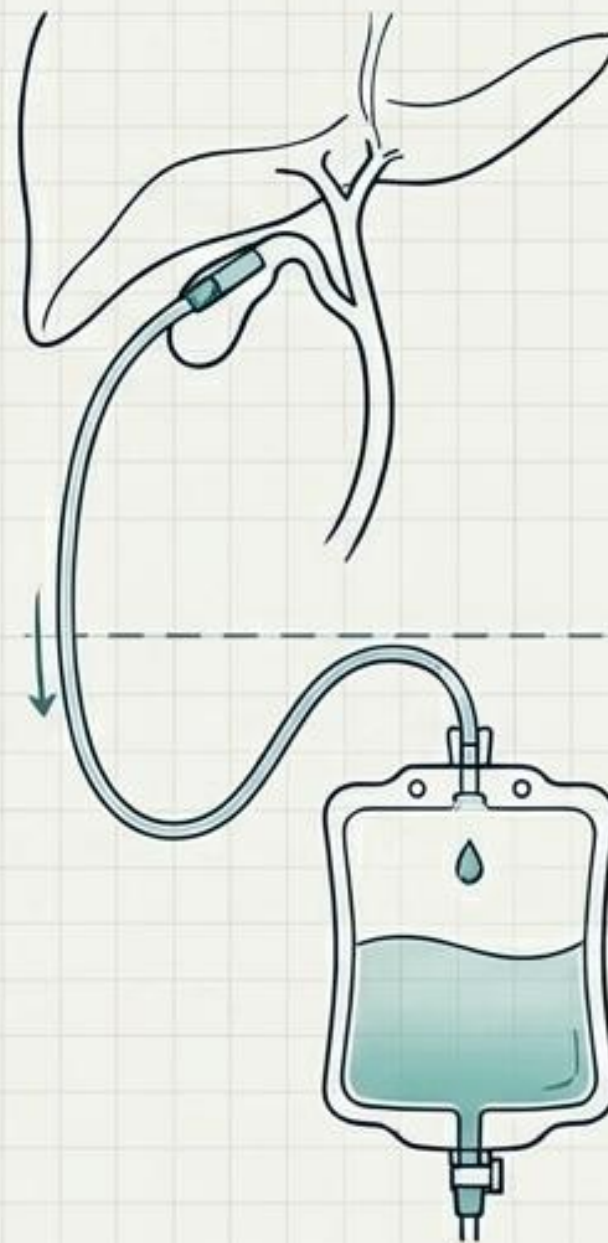
 **Nursing Alert Box:** ฝ้าระวังช็อกติดเชื้อ (Septic shock): ดูแลสายระบายหนอง (PTD) ไม่ให้หักพับ ห้ามสวนล้างสายระบายโดยไม่มีข้อบ่งชี้ บันทึกสีและปริมาณหนองอย่างถี่ถ้วน

ระบบทางเดินน้ำดี (Cholelithiasis & Cholecystitis)



นิ่วอุดตันท่อน้ำดี
ถุงน้ำดีบีบตัวรุนแรง
(Biliary Colic)
อักเสบเฉียบพลัน

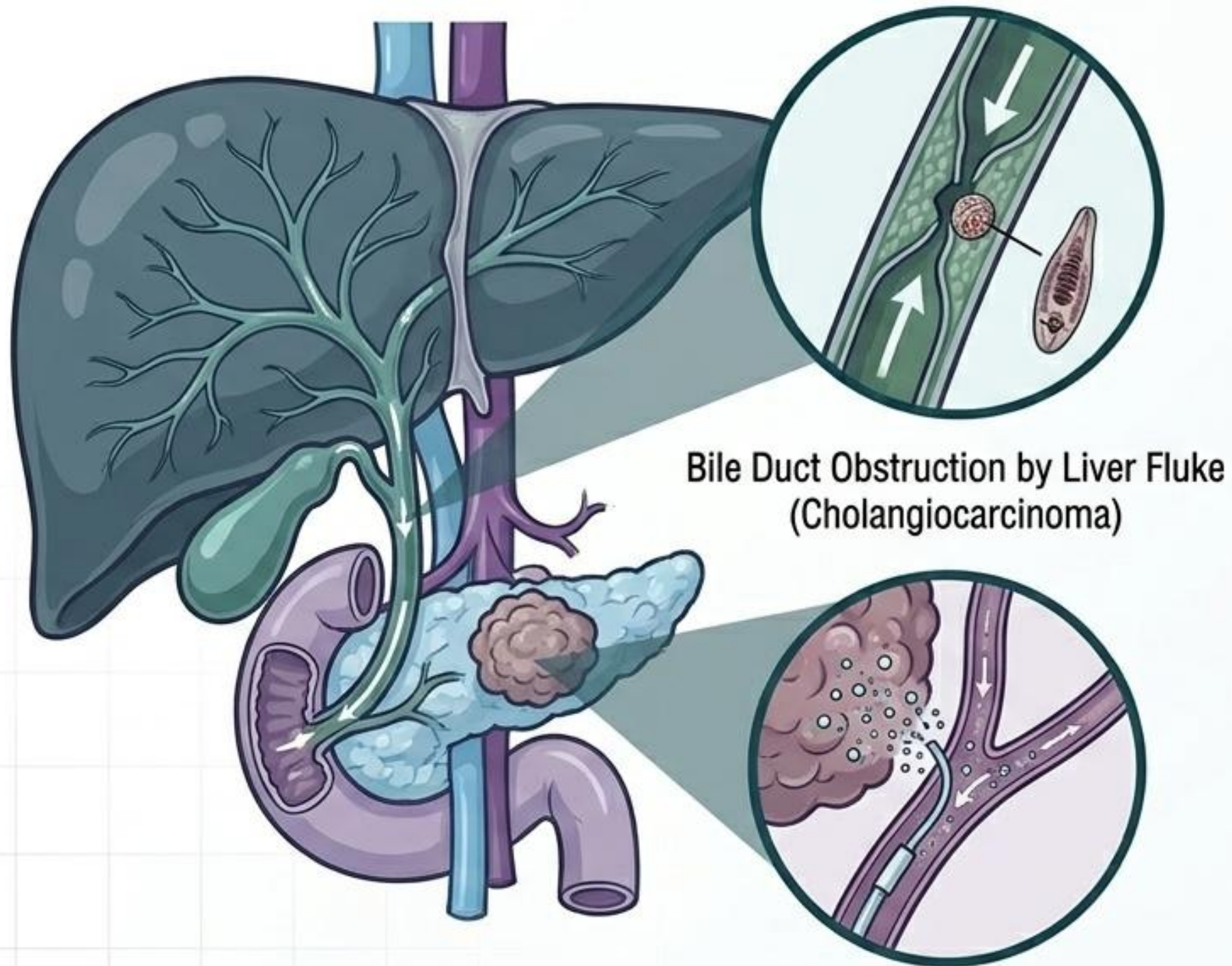
Positive Murphy's sign
(ผู้ป่วยกลืนหายใจขัดด้วย
ความเจ็บปวดขณะพยายาม
กดลิ้นใต้ชายโครงขวาแล้ว
ให้หายใจเข้า)



T-Tube Management Rules

- ✓ วางถุงรองรับน้ำดีให้อยู่ต่ำกว่าระดับเอวเสมอ (ห้ามวางบนพื้น)
- ✓ สังเกตปริมาณ: วันแรกๆ ระบายได้ 300-500 mL/วัน หาก > 1,000 mL ต้องรายงานแพทย์
- ✓ ฝึกระวังน้ำดีรั่วเข้าช่องท้อง (ปวดท้องรุนแรง หน้าท้องแข็งเกร็ง ใช้สูง)

Liver & Bile Duct Cancers



Bile Duct Obstruction by Liver Fluke (Cholangiocarcinoma)

TACE Procedure:
Targeted Chemoembolization

Cholangiocarcinoma (มะเร็งท่อน้ำดี)

- พบบ่อยในภาคอีสาน (ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากปลาดิบ)
- Signs: ตัวเหลืองตาเหลือง (Obstructive Jaundice), อุจจาระสีซีดดินเหนียว, คันผิวหนังรุนแรง (Pruritus จากเกลือน้ำดีสะสม)
- PTBD Drain: กุ้งต้องต่ำกว่าตับเสมอ น้ำดีปกติสีเหลืองทอง/เขียวเข้ม



CA Liver & Post-TACE Care

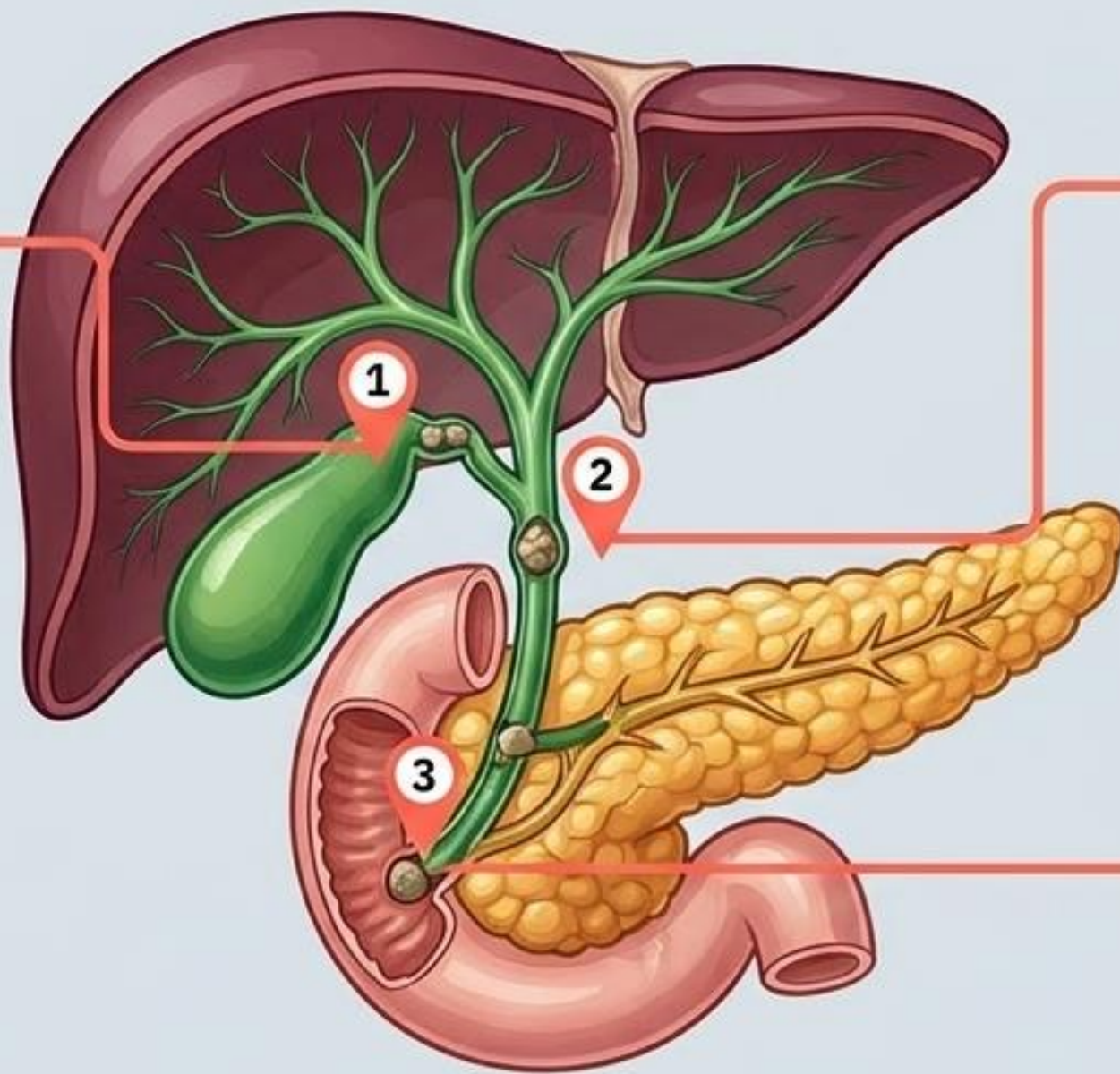
- หลังฉีดคีโมอุดเส้นเลือด (TACE) ที่ง่าหนีบ: นอนราบเหยียดขาตรง 6-8 ชม.
- ประเมินชีพจรส่วนปลาย (Pedal pulse) สีผิวและความเย็นปลายเท้า
- ฝ้าระวัง Post-embolization syndrome (ไข้ คลื่นไส้ ปวดท้องขวาบน)



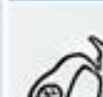
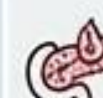
The Biliary Bottleneck: การอุดตันของระบบท่อน้ำดี

Gallbladder Neck

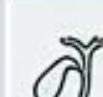
-  **นิ่วอุดตันที่ท่อน้ำดี**
-  → ท่อน้ำดีบีบตัวรุนแรง
-  → Biliary Colic และ Acute Cholecystitis



Common Bile Duct

-  **นิ่วหลุดลงท่อน้ำดีหลัก**
- น้ำดีไหลกลับตับ
-  → Obstructive Jaundice (ดีซ่าน/ตัวอึกเสบ)

Ampulla of Vater

-  **นิ่วอุดตันจุดเชื่อมต่อตับอ่อน**
-  → น้ำย่อยตับอ่อนไหลกลับ
-  → Acute Pancreatitis (ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน)

จุดอุดตันเพียงจุดเดียวสามารถส่งผลกระทบข้ามอวัยวะ
เปลี่ยนจากภาวะปวดบิดเฉพาะที่ เป็นวิกฤตระบบตับและตับอ่อนได้

ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน และการดูแลสาย T-Tube

The Alarm (Murphy's Sign)



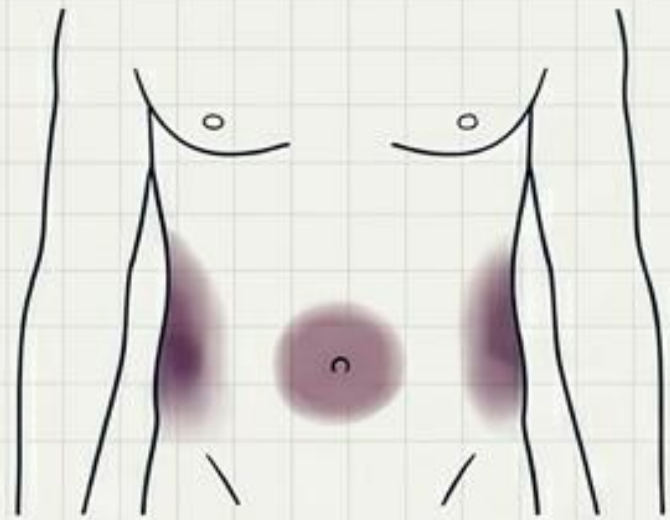
ปวดท้องใต้ชายโครงขวาเฉียบพลัน ร้าวไปสะบักขวา.
Positive Murphy's Sign: ผู้ป่วยกลั้นหายใจอึดด้วยความเจ็บปวดขณะพยาบาลกดมือลิ้นใต้ชายโครงขวาแล้วให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก



The Fix (T-Tube Care Kit)

- จัดสายไม่ให้ตึงรั้ง ยึดติดกับเสื้อผู้ป่วยให้แน่นหนา
- วางถุงรองรับน้ำดีต่ำกว่าระดับเอวเสมอ (แต่ห้ามวางบนพื้น)
- สังเกตสีและปริมาณน้ำดี (ปกติ 300-500 mL/วัน ในวันแรกๆ) ถ้าเกิน 1,000 mL ต้องรายงานแพทย์
- ฝ้าระวังภาวะน้ำดีรั่วเข้าช่องท้อง (Biliary peritonitis): ปวดท้องรุนแรง หน้าท้องแข็งเกร็ง

การย่อยสลายตัวเองของตับอ่อน (Acute Pancreatitis)

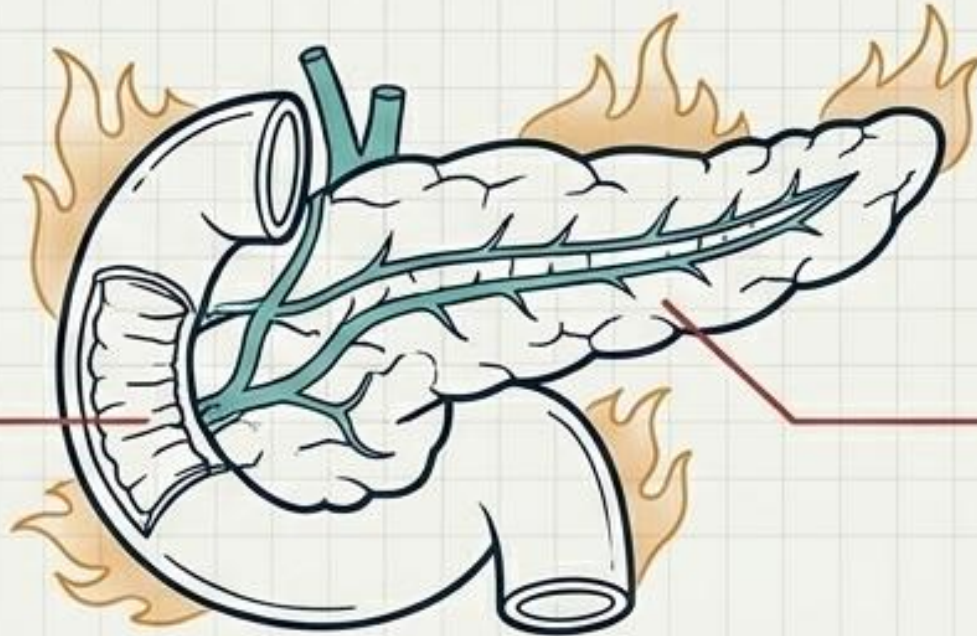


Cullen's sign:

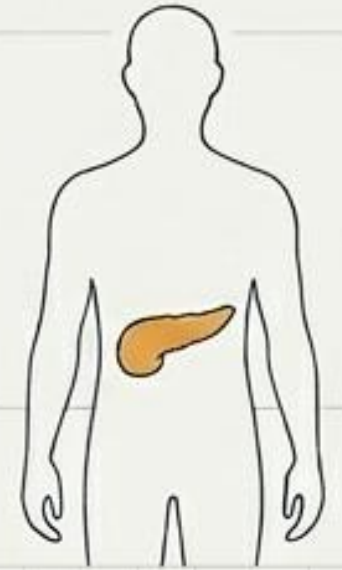
รอยจ้ำเลือดสีเขียวคล้ำรอบสะดือ

Grey Turner's sign:

รอยจ้ำเลือดบริเวณซี่ข้าง (Flank)



น้ำย่อย (Trypsin) ทำงานก่อนเวลา
ย่อยสลายเนื้อเยื่อตับอ่อน
เกิดเนื้อตายและหลอดเลือดฉีกขาด
ปวดลิ้นปี่รุนแรงทะลุไปหลัง



Chvostek's sign:

เคาะหน้าใบหูแล้วมุมปากกระตุก

Trousseau's sign:

รัดปลอกแขนวัดความดันแล้ว
นิ้วมือเกร็งจับเข้าหากัน

งดน้ำและอาหารทางปากเด็ดขาด (Absolute NPO), ใส่สาย NG suction ลดความดัน, คุ่มสมดุลงานน้ำอย่างเข้มงวด

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute Pancreatitis): เมื่อเอนไซม์ย่อยสลายตัวเอง



Chvostek's sign:
เคาะหน้าใบหูแล้วมุมปากกระตุก



The Break: เอนไซม์ Trypsin ทำงานก่อนเวลา
เกิดการย่อยสลายเนื้อเยื่อตับอ่อนเอง (Autodigestion)



Trousseau's sign: รัดปลอกแขน
วัดความดัน 3 นาทีแล้วข้อมือเกร็งจับ

The Alarm: ปวดลิ้นปี่รุนแรงทะลุไปหลัง, Cullen's sign (จ้ำเลือดรอบสะดือ), Grey Turner's sign (จ้ำเลือดสีข้าง), Amylase/Lipase สูง > 3 เท่า

The Fix: Absolute NPO & NG Tube - งดน้ำอาหารเด็ดขาดและระบายกรดเพื่อหยุดการทำงานของตับอ่อน

Biliary Colic & Pancreatic Autodigestion



Gallbladder (Cholelithiasis/Cholecystitis)



ปวดชายโครงขวา้าวไปสะบัก



Murphy's Sign: กดลิ้นใต้ชายโครงขวา ผู้ป่วยเจ็บจนกลืนหายใจอึด



T-Tube Care: วันแรก 300-500 mL หาก > 1,000 mL ต้องรายงานแพทย์



Pancreatitis (ตับอ่อนอักเสบ)



น้ำย่อย (Trypsin) ย่อยเนื้อเยื่อตัวเอง (Autodigestion) | ปวดทะลุหลัง



Danger Signs: Cullen's sign (รอบสะดือเขียวคล้ำ) /



Grey Turner's sign (จ้ำเลือดสีม่วง) จากเลือดออกในช่องท้อง



Nursing: Absolute NPO พักตับอ่อน (Rest Pancreas) |

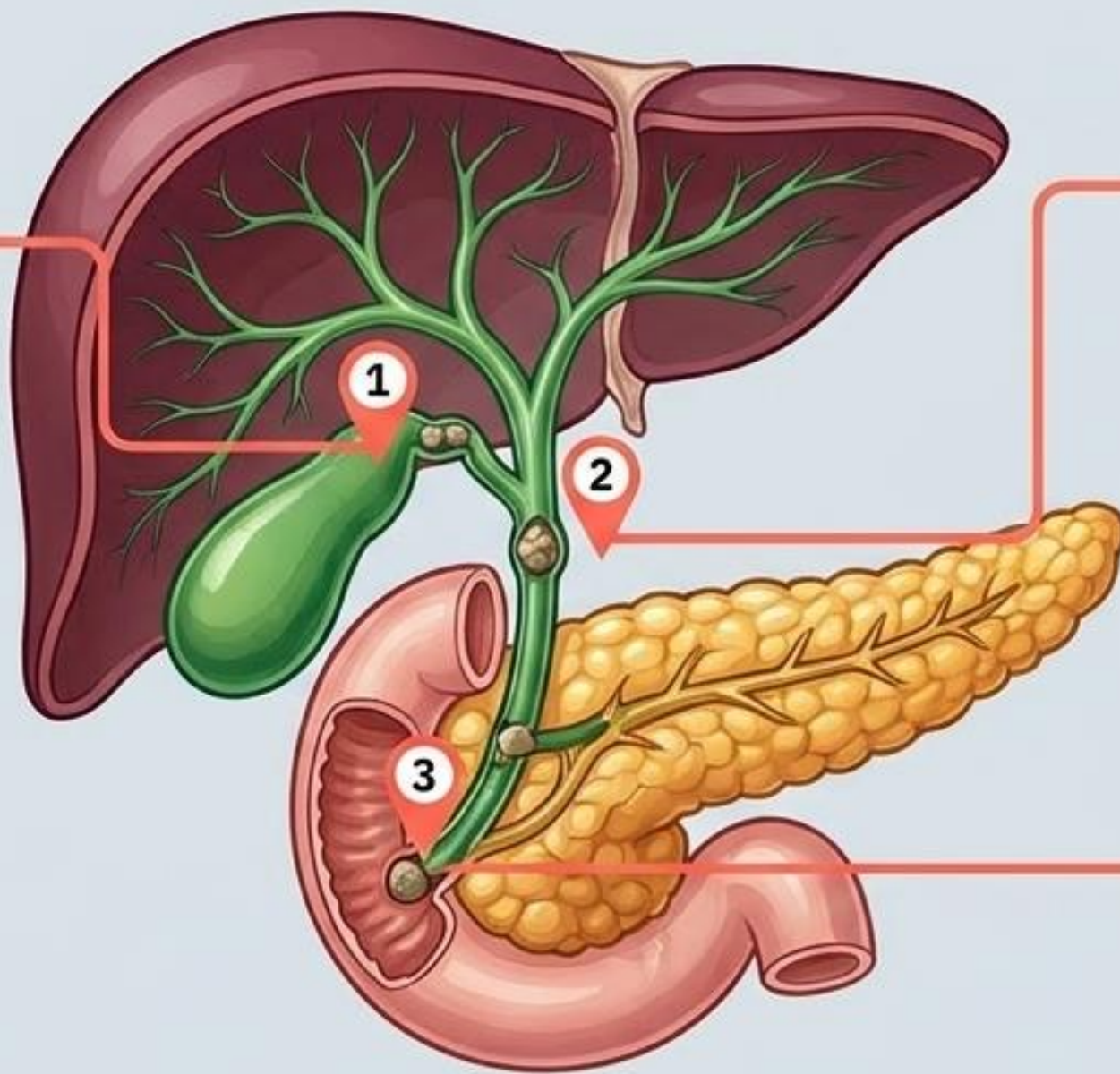


ประเมินแคลเซียมต่ำ (Chvostek's / Trousseau's sign)

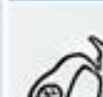
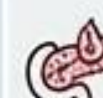
The Biliary Bottleneck: การอุดตันของระบบท่อน้ำดี

Gallbladder Neck

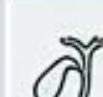
-  **นิ่วอุดตันที่ท่อน้ำดี**
-  → ท่อน้ำดีบีบตัวรุนแรง
-  → Biliary Colic และ Acute Cholecystitis



Common Bile Duct

-  **นิ่วหลุดลงท่อน้ำดีหลัก**
- น้ำดีไหลกลับตับ
-  → Obstructive Jaundice (ดีซ่าน/ตัวอึกเสบ)

Ampulla of Vater

-  **นิ่วอุดตันจุดเชื่อมต่อตับอ่อน**
- น้ำย่อยตับอ่อนไหลกลับ
-  → Acute Pancreatitis (ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน)

จุดอุดตันเพียงจุดเดียวสามารถส่งผลกระทบข้ามอวัยวะ
เปลี่ยนจากภาวะปวดบิดเฉพาะที่ เป็นวิกฤตระบบตับและตับอ่อนได้

นิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ

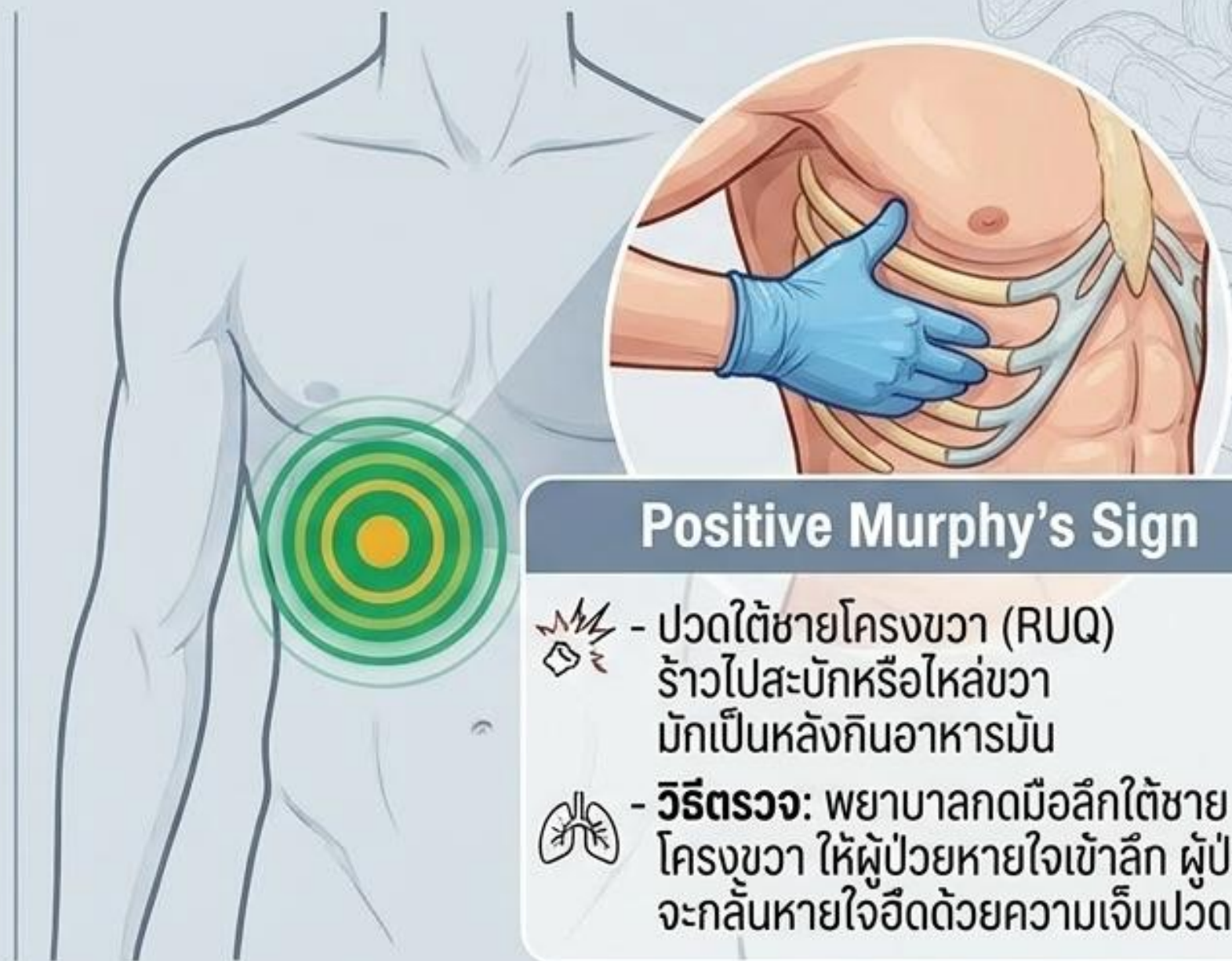
ตกตะกอนของคอเลสเตอรอล หรือ บิลิรูบิน

อุดกั้นท่อถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีบีบตัวอย่างรุนแรง

ปวดบิดรุนแรงเฉียบพลัน (Biliary Colic)

ติดเชื้อกลายเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน



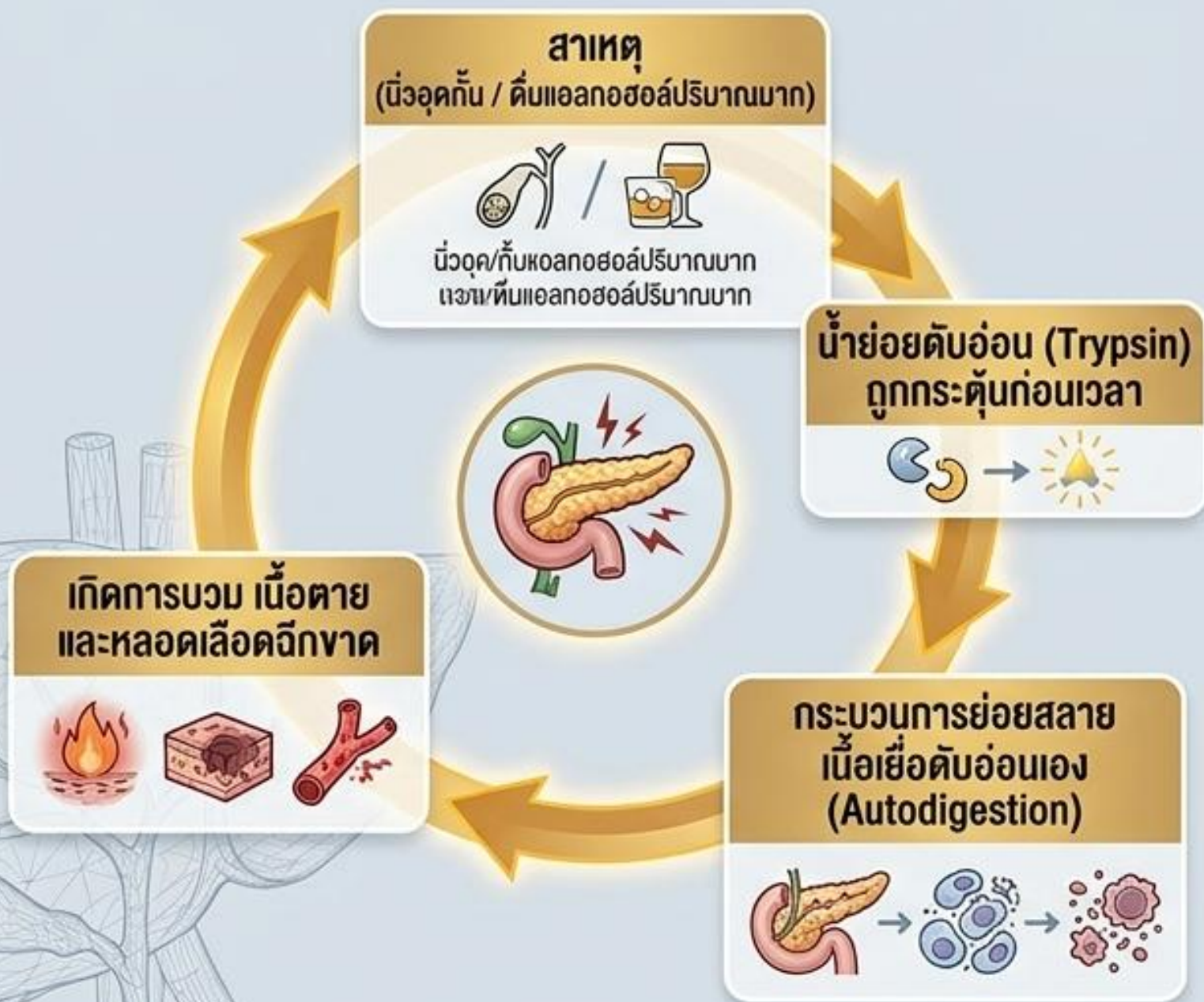
Positive Murphy's Sign

- ปวดใต้ชายโครงขวา (RUQ) ร้าวไปสะบักหรือไหล่ขวา มักเป็นหลังกินอาหารมัน
- **วิธีตรวจ:** พยาบาลกดมือลึกใต้ชายโครงขวา ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก ผู้ป่วยจะกลั้นหายใจอึดด้วยความเจ็บปวด

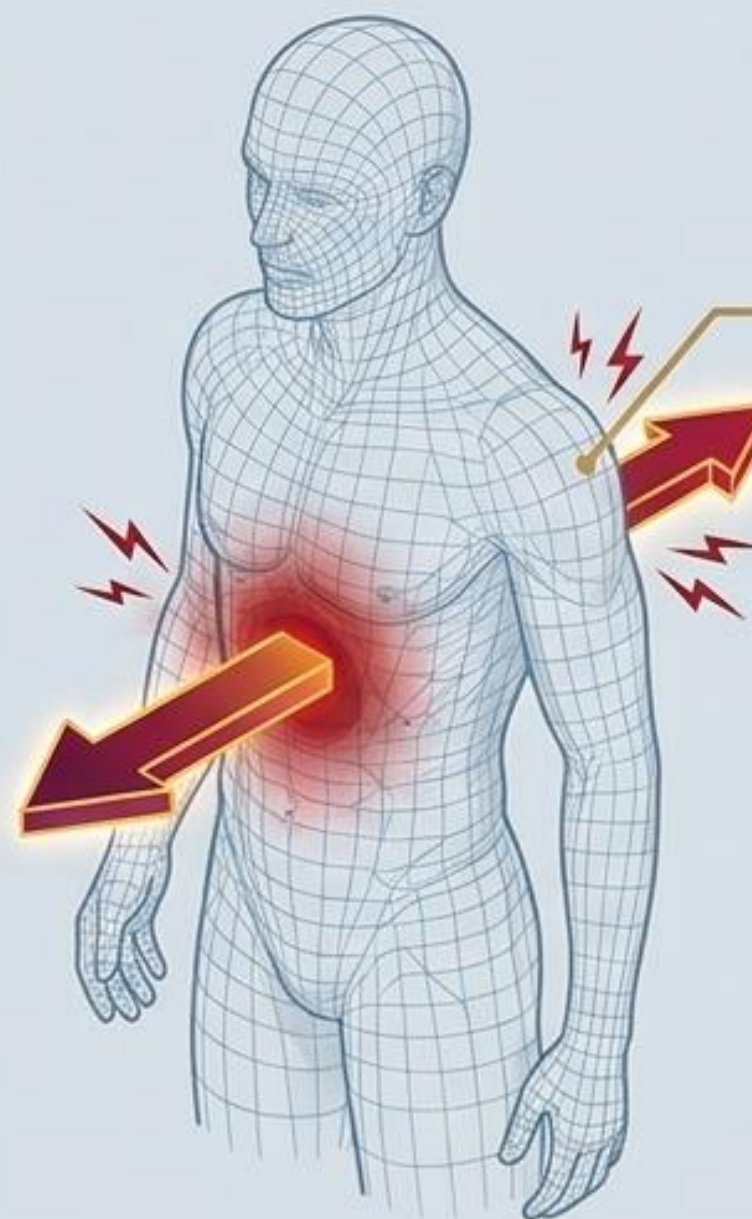
การจัดการความปวด: ปัจจุบันเน้นการบริหารยาบรรเทาปวดตามความเหมาะสมร่วมกับยาต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ (Antispasmodics)

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute Pancreatitis): พยาธิสภาพ

วงจรการย่อยสลายตัวเอง (The Autodigestion Cycle)



อาการแสดงที่สำคัญ (Hallmark Symptom)



Severe Epigastric Pain (ปวดลิ้นปี่รุนแรง)

- **ลักษณะเด่น:**
ปวดทะลุไปที่หลัง
(Radiation to back)
รุนแรงมากจนทนไม่ได้
- **การบรรเทา:** ปวดลดลง
เมื่อนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า
หรือนอนตะแคงคุกเข่า
(Fetal position)

สัญญาณเลือดออกในช่องท้องและผลแล็บ

Cullen's Sign:

ผิวหนังรอบสะดือมีสีเขียว
คล้ำคล้ายรอยจ้ำเลือด

Grey Turner's Sign:

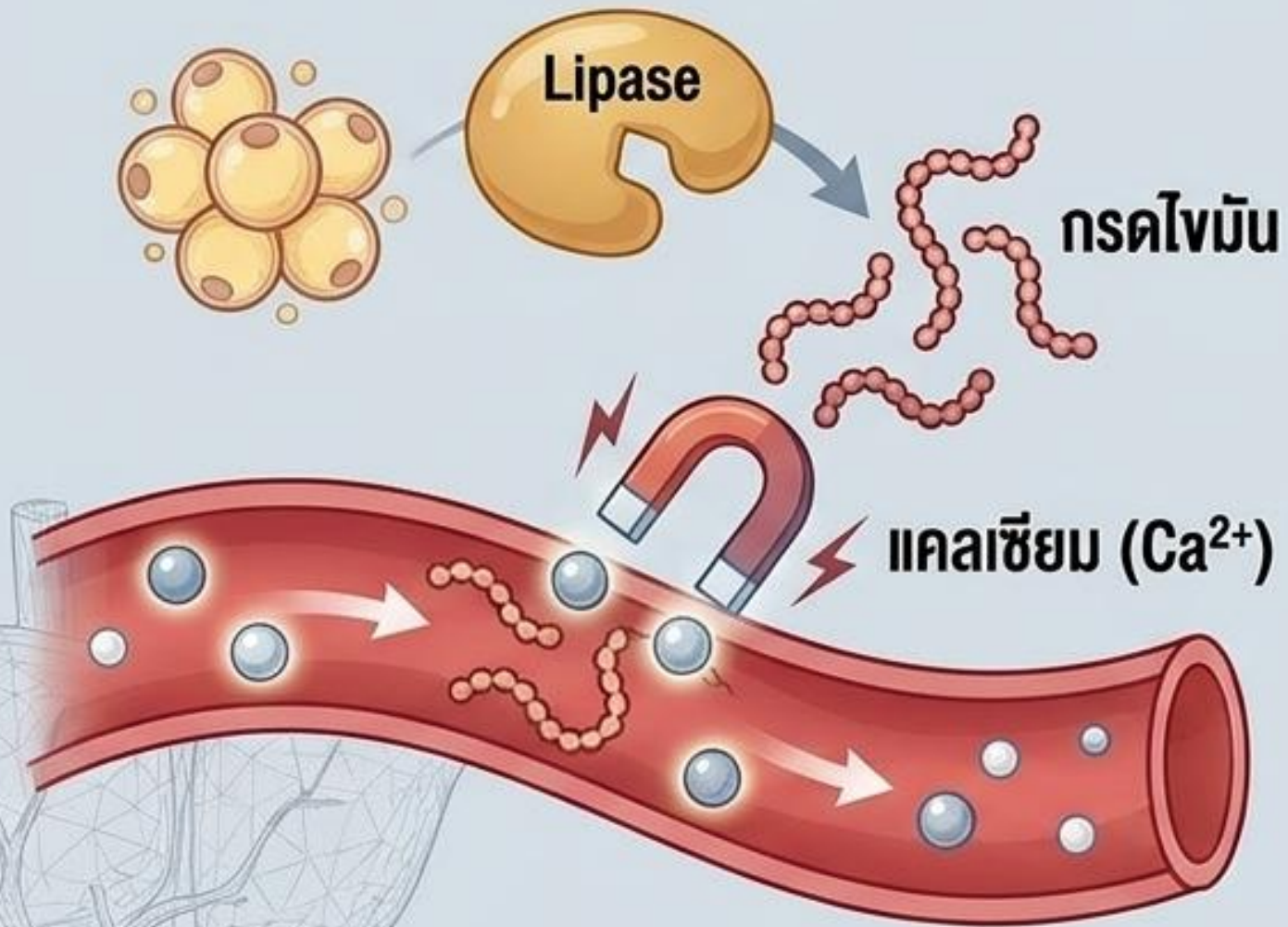
ภาวะผิวหนังบริเวณสีข้าง
(Flanks) มีรอยจ้ำเลือด

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Results):

- Serum Amylase: สูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ ▲
- Serum Lipase: สูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ (มีความจำเพาะต่อตับอ่อนสูง) ▲

ภาวะแคลเซียมต่ำในเลือด (The Hypocalcemia Reaction)

วงจรการเกิดภาวะแคลเซียมต่ำ (The Mechanism Cycle)



กรดไขมันที่ถูกย่อยด้วย Lipase จะไปจับกับแคลเซียมในกระแสเลือด ทำให้แคลเซียมในเลือดต่ำลงอย่างรวดเร็ว

การประเมินทางคลินิก (Neuromuscular Assessment)

Chvostek's Sign



Chvostek's Sign: เคาะบริเวณเส้นประสาทคู่ที่ 7 หน้าใบหู → มุมปากกระตุก

Trousseau's Sign



Trousseau's Sign: รัดพลาอกแขนวัดความดันไว้ 3 นาที → ข้อมือและนิ้วมือเกิดอาการเกร็งจับเข้าหากัน

โปรโตคอลฉุกเฉินผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ

การลดการหลั่งน้ำย่อย (Rest Pancreas)



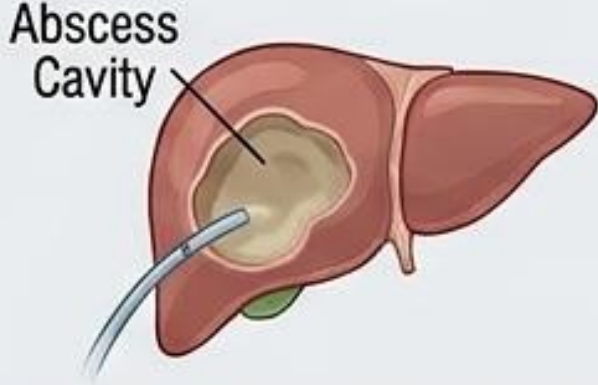
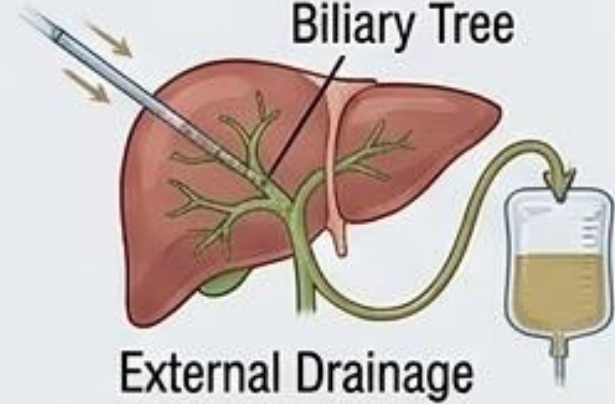
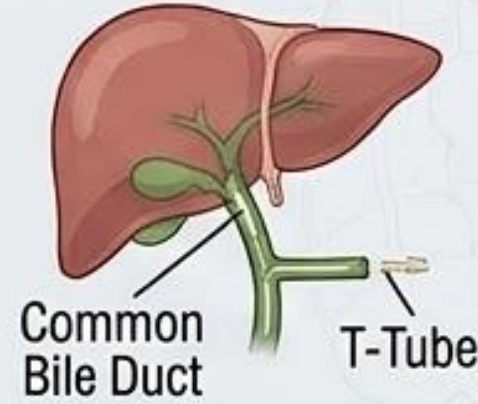
- **Absolute NPO:** งดน้ำและอาหารทางปากโดยเด็ดขาดในระยะเฉียบพลัน
- ใส่สายระบายทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร (Nasogastric tube to suction)
- **จุดประสงค์:** ระบายกรดและแก๊ส ลดการกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งเอนไซม์

การคงสมดุลสารน้ำ (Fluid Resuscitation)



- **การสูญเสียน้ำ:** ผู้ป่วยจะสูญเสียสารน้ำ (Third-space fluid shifting) เข้าช่องท้องปริมาณมหาศาล
- **จัดการให้สารน้ำ**ทางหลอดเลือดดำปริมาณสูงอย่างเข้มงวดตามแผน
- **การประเมิน:** ประเมินสัญญาณชีพและบันทึกปริมาณปัสสาวะ (Urine output) ทุกชั่วโมง
- **เป้าหมายสำคัญ:** ปัสสาวะต้องมากกว่า 30 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิง: ระบบสายระบายตับและทางเดินน้ำดี

	PTD (Percutaneous Transhepatic Drainage)	PTBD (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage)	T-Tube (T-shaped Biliary Drain)
	 Abscess Cavity	 Biliary Tree External Drainage	 Common Bile Duct T-Tube
ตำแหน่ง/ข้อบ่งชี้	ระบายหนองจากฝีในตับ	ระบายน้ำดีออกนอกร่างกาย (ลดดีซ่าน)	ใส่หลังผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางเดินน้ำดี
การดูแล/ระดับดูแล	ห้ามสวนล้างหากไม่มีข้อบ่งชี้	ถุงรองรับต้องอยู่ต่ำกว่าระดับตับเสมอ	ถุงรองรับต่ำกว่าระดับเอว แต่อย่าให้วางบนพื้น
สิ่งที่คาดหวัง/ปกติ	หนอง/ของเหลวติดเชื้อ	น้ำดีสีเหลืองทองหรือเขียวเข้ม	น้ำดีระบายได้ประมาณ 300-500 มิลลิลิตร/วัน ในวันแรกๆ
สัญญาณเตือน	สายพับงอ/หนองหยุดไหล	มีเลือดสดปนออกมาปริมาณมาก	น้ำดีออกมากกว่า 1,000 มล./วัน หรือปวดท้องรุนแรง หน้าท้องแข็ง (สัญญาณน้ำดีรั่วเข้าช่องท้อง)

Key Takeaways: Holistic Nursing Mindset



1. Evidence-Based Interventions

ยึดหลักฐานมาตรฐาน (เช่น การใช้ PPIs, T-Tube/Drain Care, การประเมินสัญญาณชีพ ช็อกแบบจำเพาะ) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



2. Critical Thinking & Cross-System Vigilance

ตระหนักเสมอว่าความผิดปกติของอวัยวะย่อยอาหารย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบเผาผลาญและการขับถ่าย (เช่น Hepatorenal syndrome)



3. Self-Management Empowerment

การพยาบาลในสังคมผู้สูงอายุ ไม่จบที่โรงพยาบาล ต้องติดตามความรู้ให้ผู้ป่วย/ญาติ (เช่น การดูแล Stoma, การจัดการนอน GERD, Dumping syndrome) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การบูรณาการพยาบาลแบบองค์รวม (The Holistic Care Synthesis)



จิตสังคมและจิตวิญญาณ

ประเมินความทุกข์ทรมาน (Spiritual distress) ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย, การยอมรับภาพลักษณ์ (Stoma), และการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง

โภชนาการและสารน้ำ

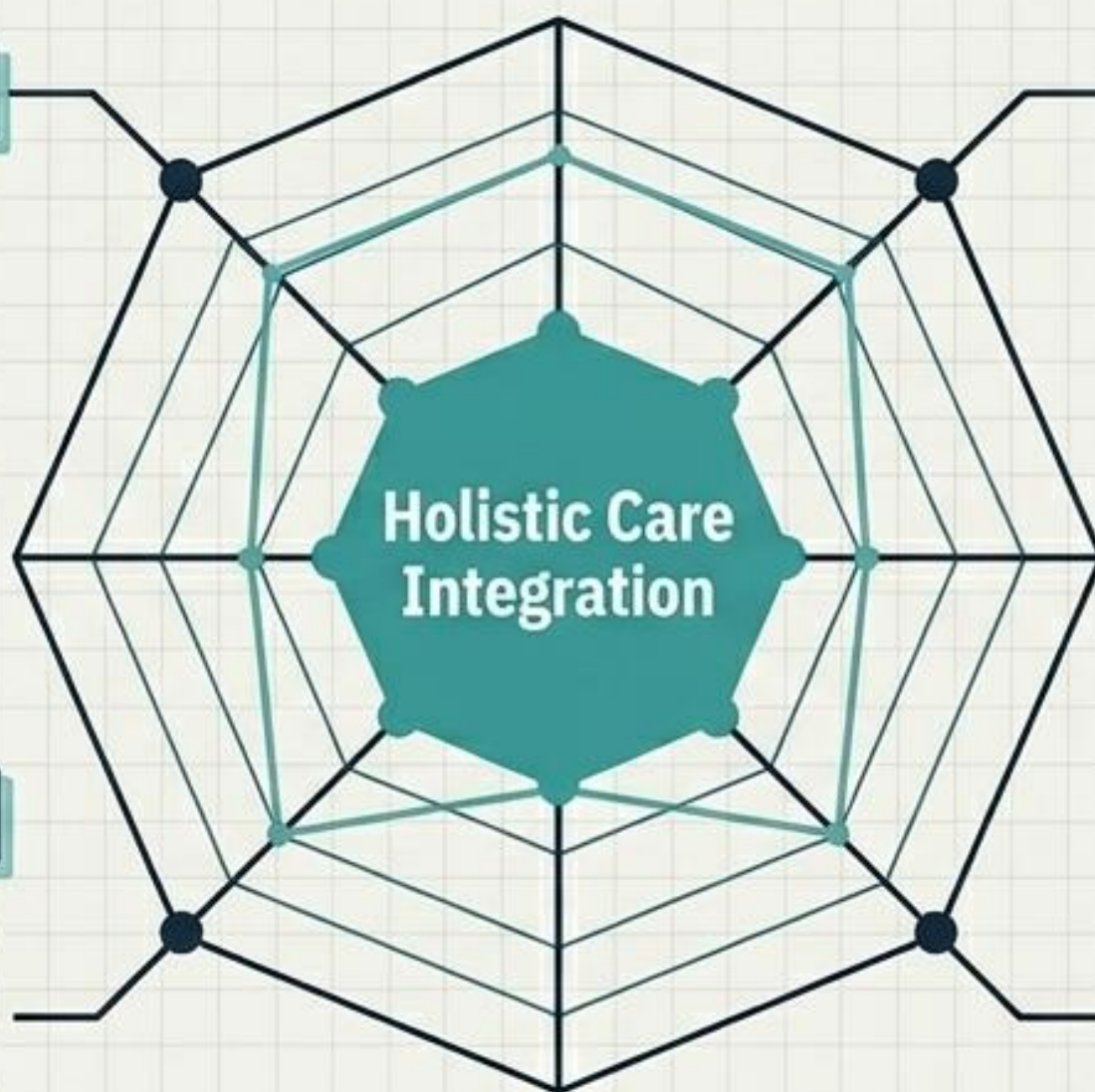
- การประเมิน Albumin, การบริหาร TPN สำหรับภาวะทุพโภชนาการ และการรักษา Isotonic balance ในระยะวิกฤต

การเฝ้าระวังหลังผ่าตัด

ตรวจจับสัญญาณอันตรายของ Anastomotic leak, ลำไส้ทะลุ (Rigid abdomen) และการอุดตันของสายระบาย (Drain occlusion)

การลดแรงดันและการจัดการความปวด

การใช้ NG tube เพื่อระบาย (Decompression) หยุดยั้งการทำงานของอวัยวะ (Rest organ) และหลีกเลี่ยงปัจจัยเพิ่มแรงดันในช่องท้อง



Case Study Synthesis: วิกฤตการณ์หลังเปิดช่องท้อง (Exploratory Laparotomy)



The Patient Scenario

ผู้ป่วย: ชายอายุ 68 ปี, มีภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)

ประวัติ: ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารทะลุ (Post-op Day 6)

เหตุการณ์กระตุ้น: ผู้ป่วยมีอาการ 'ไออย่างรุนแรง' (แรงดันในช่องท้องพุ่งสูง)

The Alarm (สิ่งที่คุณตรวจพบ)

น้ำสีชมพูจางๆ (Serosanguinous fluid) ไหลซึมชุ่มผ้าปิดแผลปริมาณมาก...
เมื่อเปิดก็พบแผลแยก 3 ซม. และ ลำไส้ทะลักออกมา (Wound Evisceration)!

Critical Question: ในฐานะพยาบาล คุณจะปฏิบัติกรช่วยเหลือฉุกเฉิน 3 ลำดับแรกอย่างไรก่อนแพทย์มาถึง?

กรณี evisceration

1.

⚠ STOP



1. ห้ามดันกลับเด็ดขาด (DO NOT PUSH BACK)

เหตุผล: การยัดลำไส้กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อรุนแรงและการบอบซ้ำของเนื้อเยื่อ (Ischemia)

2.



2. คลุมด้วยก๊อชชุบน้ำเกลือปลอดเชื้อ (Sterile Moist NSS Dressing)

เหตุผล: ป้องกันเนื้อเยื่อลำไส้แห้งตาย (Necrosis)
ซึ่งจะทำให้เสียความยืดหยุ่นและต้องถูกตัดทิ้ง

3.



3. จัดท่านอนชันเข่า (Flex Knees) + ประเมิน V/S + ตามแพทย์

เหตุผล: การชันเข่าช่วยลดแรงตึงผิวและลดความดันที่
ผนังหน้าท้อง ป้องกันไม่ให้อวัยวะทะลักออกมามากขึ้น
งดน้ำอาหารทันทีเพื่อเตรียมเข้า OR

Takeaway: การพยาบาลผู้ป่วยระบบย่อยอาหารไม่ใช่แค่การดูแลตามระบบ
แต่คือการมองเห็น 'โดมิโนเอฟเฟกต์' เพื่อตัดวงจรวิกฤตได้ทันเวลา

คำถามและข้อสงสัย



THANK YOU
FOR
YOUR ATTENTIONS

